

Buku Ajar **KEPERAWATAN GERONTIK**

I Wayan Suardana • Resa Livia Nica • Syaiful
Dini Nurbaeti Zen • Martha Lowrani Siagian,

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis:

Dr. I Wayan Suardana, S.Kep., Ns., M.Kep.

Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.

Syaiful, Skep., Ns., M.Pd., MKes.

Ns. Dini Nurbaeti Zen, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Martha Lowrani Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis:

Dr. I Wayan Suardana, S.Kep., Ns., M.Kep.
Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes.
Syaiful, Skep., Ns., M.Pd., MKes.
Ns. Dini Nurbaeti Zen, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Martha Lowrani Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-87-9

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, serta penerapan asuhan keperawatan kepada lanjut usia secara komprehensif. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi dosen, perawat, tenaga kesehatan, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan lanjut usia.

Peningkatan usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Namun, kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang memiliki kebutuhan kesehatan semakin kompleks. Proses menua dapat menimbulkan berbagai perubahan pada aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempertahankan fungsi tubuh, beradaptasi dengan lingkungan, serta menjaga kemandirian dan kualitas hidupnya.

Keperawatan gerontik memiliki peran penting dalam membantu lanjut usia menjalani proses penuaan secara sehat, aktif, produktif, dan bermartabat. Perawat tidak hanya dituntut untuk memahami penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia, tetapi juga harus mampu mengenali perubahan normal akibat proses penuaan, mengidentifikasi faktor risiko, melakukan pengkajian secara menyeluruh, serta merancang asuhan keperawatan sesuai kondisi dan kebutuhan individual. Pelayanan keperawatan kepada lanjut usia perlu diberikan dengan mengedepankan sikap empati, penghormatan terhadap martabat manusia, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, serta keterlibatan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Buku ini membahas berbagai materi yang berkaitan dengan keperawatan gerontik, mulai dari konsep dasar lanjut usia, teori dan proses penuaan, perubahan fisiologis dan psikososial, hingga pengkajian lanjut usia secara multidimensional. Pembahasan juga mencakup berbagai masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan risiko jatuh, gangguan mobilitas, masalah nutrisi, gangguan kognitif, masalah psikologis, serta penerapan proses keperawatan pada berbagai kondisi. Selain itu, buku ini turut menekankan pentingnya pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dalam mendukung kesejahteraan lanjut usia.

Penyusunan buku ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis agar pembaca dapat memahami materi secara bertahap. Materi tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi, pengambilan keputusan, serta sikap caring dalam memberikan pelayanan keperawatan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan proses keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil asuhan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memperluas wawasan mengenai keperawatan lanjut usia, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan keperawatan gerontik. Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan kepada lanjut usia yang holistik, manusiawi, aman, bermutu, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian serta kualitas hidup.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB 1 TEORI PENUAAN & PERUBAHAN BIOPSIKOSOSIAL-SPIRITUAL	
PADA LANSIA	1
A. Teori Penuaan	11
B. Perubahan Biopsikososial-Spiritual Pada Lansia	17
C. Manifestasi Klinis.....	18
D. Pemeriksaan Penunjang	22
E. Komplikasi	24
F. Penatalaksanaan.....	25
G. Latihan Soal.....	34
H. Daftar Pustaka.....	37
 BAB 2 ETIK, HAK DAN ISSUE LEGAL DALAM PERAWATAN LANSIA	
41	
A. Prinsip-Prinsip Etik dalam Perawatan Lansia	43
B. Penerapan Aspek Etik dalam Perawatan Lansia.....	44
C. Tantangan Etik dalam Perawatan Lansia	44
D. Hak Lanjut Usia.....	45
E. Isu dan Aspek Legal Perawatan Lansia	46
F. Legal Aspek Perawatan Lansia	46
G. Latihan Soal.....	49
H. Ringkasan	51
I. Daftar Pustaka.....	52
 BAB 3 MENETAPKAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN GERONTIK DAN	
MENYUSUN RENCANA ASUHAN BERBASIS EVIDENCE	53
A. Pengertian Diagnosis dan Standar Diagnosis Keperawatan	58
B. Tujuan Diagnosis Keperawatan	61
C. Klasifikasi Diagnosis Keperawatan.....	61
D. Jenis Diagnosis Keperawatan	62
E. Komponen Diagnosis Keperawatan.....	62
F. Proses Penegakan Diagnosis Keperawatan.....	63
G. Kriteria Penunjuk Penulisan Diagnosis Keperawatan.....	66
H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan Diagnosis Medis.....	67
I. Format atau Lembar Diagnosis Keperawatan.....	67
J. Konsep Tahap Perencanaan Dalam Keperawatan	71
K. Tujuan Intervensi Keperawatan.....	72
L. Klasifikasi Intervensi Keperawatan.....	72
M. Komponen Intervensi Keperawatan.....	74

N. Latihan Soal.....	89
O. Ringkasan	92
P. Daftar Pustaka.....	94

BAB 4 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DENGAN LANSIA & KELUARGA

(KULTURAL DAN EMPATIK).....	97
A. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Gerontik.....	102
B. Tujuan dan Manfaat Komunikasi Terapeutik pada Lansia	102
C. Tahapan Komunikasi Terapeutik	103
D. Perubahan pada Lansia yang Mempengaruhi Komunikasi	104
E. Komunikasi Empatik dalam Keperawatan Lansia	105
F. Komunikasi Kultural dalam Asuhan Keperawatan Lansia.....	105
G. Latihan Soal.....	108
H. Ringkasan	111
I. Daftar Pustaka.....	111

BAB 5 DOKUMENTASI, CONTINUITY OF CARE, DAN PENGANTAR

MUTU–KESELAMATAN PASIEN LANSIA.....	113
A. Dokumentasi Keperawatan Gerontik.....	125
B. Prinsip Dokumentasi Keperawatan.....	127
C. Standar Dokumentasi.....	128
D. Model Dokumentasi	129
E. Dokumentasi Khusus pada Lansia dalam keperawatan.....	133
F. Continuity of Care (Continuum of Care).....	135
G. Mutu Pelayanan Kesehatan Lansia	140
H. Keselamatan Pasien Lansia (Patient Safety)	141
I. Latihan Soal.....	142
J. Ringkasan	142
K. Daftar Pustaka.....	143

PROFIL PENULIS	145
-----------------------------	------------

BAB 1

TEORI PENUAAN & PERUBAHAN BIOPSIKOSOSIAL-SPIRITUAL PADA LANSIA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu-keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Gerontik dan Peran Perawat	1.1 Menguraikan ruang lingkup keperawatan gerontik, terminologi kunci, dan kebutuhan layanan lansia.	1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, dan kompetensi perawat dalam tim geriatri serta alur layanan promotif-paliatif.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-6
Bab 2. Teori Penuaan & Perubahan Biopsikososial-Spiritual pada Lansia	2.1 Membedakan teori/konsep penuaan dan implikasinya terhadap respon kesehatan lansia.	2.2 Menganalisis perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia sebagai dasar intervensi holistik.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5
Bab 3. Etika, Hak Lansia, dan Isu Legal dalam Praktik Keperawatan	3.1 Menerapkan prinsip etika dalam penyelesaian kasus-kasus keperawatan gerontik.	3.2 Menjelaskan hak lansia, informed consent, kerahasiaan, dan isu legal (penelantaran, kekerasan, kapasitas keputusan).	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Pengkajian Gerontik Komprehensif (CGA): ADL/IADL, frailty, risiko	4.1 Melakukan CGA terstruktur menggunakan instrumen ADL/IADL, skrining frailty, kognitif, mood, nutrisi, dan risiko jatuh.	4.2 Mensintesis temuan CGA menjadi masalah prioritas, risiko, dan kebutuhan rujukan/kolaborasi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Diagnosa Keperawatan Gerontik & Perencanaan Asuhan Berbasis Evidence	5.1 Merumuskan diagnosis & keperawatan gerontik berbasis data dengan prioritas yang jelas.	5.2 Menyusun rencana asuhan berbasis evidence (tujuan terukur, intervensi, evaluasi) dan indikator hasil.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-6
Bab 6. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia & Keluarga (kultural dan empatik)	6.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada lansia secara empatik dan adaptif terhadap keterbatasan sensori/kognitif.	6.2 Merancang edukasi kesehatan dan counseling keluarga dengan pendekatan kultural, health literacy, dan shared decision-making.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-2
Bab 7. Dokumentasi, Continuity of Care, dan Pengantar Mutu–Keselamatan Pasien Lansia	7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.	7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 8. Frailty, Sarcopenia, dan Risiko Disabilitas	8.1 Menilai frailty dan sarcopenia serta keterkaitannya	8.2 Merancang intervensi keperawatan/kolaboratif untuk pencegahan dan	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	dengan disabilitas dan outcome.	penanganan frailty–sarcopenia.		
Bab 9. Jatuh pada Lansia: Skrining Risiko, Pencegahan, dan Rehabilitasi	9.1 Melakukan skrining risiko jatuh dan identifikasi faktor intrinsik–ekstrinsik.	9.2 Menyusun paket pencegahan jatuh dan rencana rehabilitasi dasar pasca-jatuh termasuk edukasi lingkungan aman.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 10. Delirium: Deteksi Dini, Tata Laksana Keperawatan, dan Pencegahan	10.1 Melakukan deteksi dini delirium dan identifikasi faktor pemicu menggunakan alat skrining sederhana.	10.2 Menyusun intervensi keperawatan nonfarmakologis, monitoring, dan pencegahan delirium secara kolaboratif.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
Bab 11. Ulkus Tekan & Perawatan Kulit Lansia: Pencegahan hingga Perawatan Luka	11.1 Mengidentifikasi risiko ulkus tekan dan langkah pencegahan berbasis repositioning serta perawatan kulit.	11.2 Merencanakan perawatan luka dasar (asesmen luka, balutan, nyeri) dan rujukan sesuai tingkat keparahan.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 12. Inkontinensia Urin/Feses dan Asuhan Keperawatan Terintegrasi	12.1 Mengkaji tipe/derajat inkontinensia dan dampaknya pada kualitas hidup serta risiko komplikasi.	12.2 Merancang asuhan terintegrasi dan edukasi (latihan, manajemen cairan, higiene, alat bantu) dengan evaluasi terukur.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
Bab 13. Malnutrisi, Dehidrasi, dan Masalah Menelan (Dysphagia) pada Lansia	13.1 Melakukan skrining malnutrisi, dehidrasi, dan dysphagia serta menetapkan risiko aspirasi.	13.2 Menyusun intervensi nutrisi–hidrasi aman (modifikasi tekstur, posisi, pemantauan) dan evaluasi outcome.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 14. Polifarmasi & Keselamatan Obat pada Lansia (kolaborasi interprofesional)	14.1 Mengidentifikasi polifarmasi, obat berisiko tinggi, dan potensi interaksi/efek samping melalui medication review sederhana.	14.2 Merancang strategi keselamatan obat: rekonsiliasi obat, edukasi kepatuhan, dan komunikasi interprofesional untuk deprescribing bila perlu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Kuis/tes tertulis; tugas ringkas (concept map)	Ketepatan konsep penuaan & gerontik ($\geq 80\%$ benar); kemampuan mengaitkan perubahan biopsikosial-spiritual dengan kebutuhan asuhan (≥ 2 contoh tepat)	10	Nilai kuis; concept map terstruktur
CPMK-2	Analisis kasus etik-legal tertulis; refleksi terarah	Identifikasi isu etik-legal & hak lansia (≥ 4 poin relevan); rekomendasi keputusan/advokasi konsisten dengan prinsip etika dan prosedur (≥ 2 justifikasi)	10	Lembar analisis kasus; refleksi etis
CPMK-3	OSCE pengkajian; penugasan laporan CGA	Kelengkapan item CGA ($\geq 90\%$ terisi); ketepatan skoring instrumen (selisih ≤ 1 kategori); sintesis prioritas masalah & risiko (≥ 3 prioritas dengan alasan)	15	Lembar CGA; laporan interpretasi; checklist OSCE
CPMK-4	Studi kasus (care plan) berbasis	Ketepatan diagnosis/masalah (sesuai data, ≥ 3 diagnosis); tujuan/outcome terukur	20	Dokumen care plan; daftar

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
	evidence; penilaian portofolio	(SMART, ≥ 3); intervensi rasional berbasis evidence (≥ 3 sumber kredibel)		pustaka ringkas; portofolio kasus
CPMK-5	OSCE/role play komunikasi; penugasan materi edukasi	Keterampilan komunikasi (empati, klaritas, validasi, adaptasi sensori/kognitif) minimal "baik" pada ≥ 4 komponen; materi edukasi sesuai health literacy dan budaya (≥ 2 strategi adaptasi)	10	Video/lembar observasi OSCE; leaflet/outline edukasi
CPMK-6	Audit dokumentasi simulasi; tugas handover & rekonsiliasi obat; kuis keselamatan	Dokumentasi (lengkap, akurat, tepat waktu) $\geq 85\%$ item terpenuhi; kualitas handover (SBAR/format setara) ≥ 4 elemen lengkap; identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan (≥ 3 risiko + 3 tindakan)	15	Catatan SOAP/ADPIE; form handover; form rekonsiliasi obat; hasil audit
CPMK-7	Ujian akhir berbasis kasus sindrom geriatri; OSCE intervensi terpilih	Ketepatan paket intervensi (pencegahan + tata laksana) sesuai masalah kasus ($\geq 80\%$ sesuai pedoman/bukti); monitoring outcome & kriteria rujukan jelas (≥ 3 parameter + ≥ 1 rujukan/kolaborasi tepat)	20	Lembar jawaban kasus; rencana intervensi terintegrasi; checklist OSCE

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep penuaan	Banyak konsep keliru;	Konsep dasar cukup namun ada kekeliruan	Konsep tepat dan cukup lengkap;	Konsep sangat tepat, komprehensif,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& keperawatan gerontik	istilah tidak tepat; <60% benar	penting; 60–74% benar	kesalahan minor; 75–89% benar	dan terintegrasi; ≥90% benar
1.2 Analisis perubahan biopsikososial-spiritual & implikasi asuhan	Uraian deskriptif tanpa kaitan implikasi asuhan	Mengaitkan sebagian perubahan dengan implikasi; contoh terbatas	Analisis logis; mengaitkan perubahan dengan kebutuhan asuhan; contoh relevan	Analisis mendalam, integratif, memprioritaskan implikasi; argumentasi kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Identifikasi isu etik-legal & hak lansia pada kasus	Isu utama tidak teridentifikasi/keliru	Isu teridentifikasi sebagian; ada yang terlewat	Isu utama teridentifikasi lengkap dan relevan	Isu lengkap, tajam, termasuk risiko dan pihak terkait
2.2 Kualitas keputusan/advokasi (alasan dan langkah)	Rekomendasi tidak konsisten; tanpa justifikasi	Rekomendasi cukup, justifikasi lemah/umum	Rekomendasi tepat; justifikasi berbasis prinsip; langkah jelas	Rekomendasi sangat tepat; justifikasi kuat; mempertimbangkan alternatif dan dampak

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan & ketepatan pelaksanaan CGA	Data banyak kosong; sering salah	Data cukup; beberapa komponen CGA terlewat	Data lengkap; skoring benar dengan kesalahan minor	Data sangat lengkap; skoring akurat; teknik pengkajian sistematis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		skoring kurang konsisten		
3.2 Sintesis hasil CGA menjadi prioritas masalah & risiko	Tidak mampu memprioritaskan; alasan tidak berbasis data	Prioritas ada namun kurang didukung data	Prioritas jelas; alasan berbasis data; risiko utama terpetakan	Prioritas sangat tajam; mengaitkan faktor risiko, protektif, dan kebutuhan kolaborasi

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan diagnosis/masalah keperawatan berbasis data	Tidak sesuai data; pernyataan masalah kabur	Sebagian sesuai data; masih ada diagnosis tidak tepat	Sesuai data; prioritas logis; pernyataan jelas	Sangat sesuai data; prioritas sangat tepat; mempertimbangkan komorbid & risiko
4.2 Kualitas rencana asuhan berbasis evidence	Tujuan tidak terukur; intervensi generik tanpa rasional	Tujuan cukup; intervensi ada namun kurang spesifik/kurang bukti	Tujuan SMART; intervensi spesifik; rasional berbasis evidence; evaluasi ada	Sangat terstruktur; evidence kuat; indikator hasil jelas; rencana evaluasi dan penyesuaian rinci

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Keterampilan komunikasi terapeutik dengan lansia	Tidak empatik; komunikasi tidak jelas; tidak adaptif	Empati ada namun kurang konsisten;	Empatik, jelas, adaptif; membangun hubungan dan validasi	Sangat empatik; responsif; mengelola hambatan sensorik/kognitif secara efektif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		adaptasi terbatas		
5.2 Kualitas edukasi & kolaborasi dengan keluarga	Materi tidak sesuai kebutuhan/kemampuan; tanpa tindak lanjut	Materi cukup sesuai; strategi adaptasi minim	Materi sesuai; adaptif budaya & literasi; ada rencana tindak lanjut	Sangat sesuai; melibatkan keluarga; strategi adaptasi kuat; evaluasi pemahaman jelas

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas dokumentasi & handover/continuity	Tidak lengkap; tidak akurat; tidak tepat waktu	Cukup lengkap namun ada kekurangan elemen penting	Lengkap, akurat, tepat waktu; format konsisten	Sangat lengkap; sangat akurat; mendukung transisi dan keterlacakan klinis
6.2 Identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan	Risiko tidak terpetakan; rencana tidak spesifik	Risiko sebagian teridentifikasi; rencana umum	Risiko utama teridentifikasi; rencana pencegahan spesifik dan realistis	Risiko komprehensif; rencana pencegahan terintegrasi, prioritas jelas, dan terukur

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan intervensi sindrom geriatri (pencegahan & tata laksana)	Intervensi tidak sesuai masalah; berisiko/kontraindikasi	Intervensi sebagian sesuai; masih ada komponen penting terlewat	Intervensi sesuai masalah; mencakup pencegahan dan	Intervensi sangat tepat; komprehensif; mempertimbangan preferensi,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			tata laksana	keamanan, dan evidence
7.2 Monitoring outcome, evaluasi, dan kolaborasi/rujukan	Tidak ada parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Parameter terbatas; rujukan/kolaborasi kurang tepat	Parameter monitoring jelas; evaluasi dan kolaborasi tepat	Monitoring sangat terukur; evaluasi adaptif; kolaborasi/rujukan tepat waktu dan efektif

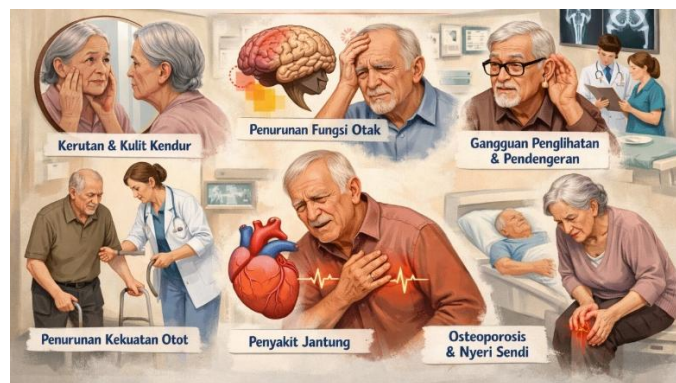
Uraian Materi

A. Teori Penuaan

Penuaan (*aging*) merupakan proses biologis alami yang bersifat progresif dan irreversibel, ditandai dengan penurunan fungsi sel, jaringan, dan organ dalam mempertahankan homeostasis. Penuaan bersifat multidimensional, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berinteraksi dan memengaruhi kualitas hidup individu.

Secara biologis, penuaan merupakan proses degeneratif akibat akumulasi kerusakan pada tingkat seluler, molekuler, dan sistem organ. Perubahan ini meliputi stres oksidatif, pemendekan telomer, serta kerusakan DNA yang menyebabkan penurunan kemampuan proliferasi dan regenerasi sel. Selain itu, disfungsi mitokondria mengakibatkan penurunan produksi energi (ATP) yang berdampak pada menurunnya fungsi jaringan.

Pada tingkat jaringan dan organ, penuaan ditandai dengan berkurangnya elastisitas jaringan, penurunan massa otot (*sarkopenia*), penurunan kepadatan tulang, serta penurunan fungsi organ vital. Secara sistemik, terjadi penurunan fungsi sistem imun (*immunosenescence*), perubahan hormonal, dan menurunnya kapasitas adaptasi terhadap stres. Dengan demikian, penuaan biologis merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang berkontribusi terhadap penurunan fungsi tubuh secara bertahap.



Gambar 1.1 Desain Resa, 2026

1. Etiologi

Penuaan bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi faktor intrinsik (Internal) dan ekstrinsik (Lingkungan):

a. Faktor Intrinsik (Internal / Biologis), merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari dan diprogram secara biologis.

1) Genetik (Telomere Shortening)

a) Telomer adalah struktur pelindung kromosom

- b) Setiap pembelahan sel telomer memendek
 - c) Akibatnya sel mengalami senescence (penuaan sel) atau apoptosis
 - d) Telomer menjadi biomarker utama penuaan seluler
- 2) Disfungsi Mitokondria
 - a) Mitokondria menghasilkan energi (ATP)
 - b) Seiring usia terjadi penurunan fungsi peningkatan radikal bebas
 - c) Menyebabkan kerusakan sel dan jaringan
- 3) Stres Oksidatif (Oxidative Stress)
 - a) Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan
 - b) Mengakibatkan kerusakan DNA, protein, dan lipid
- 4) Senescence Sel (Cellular Senescence)
 - a) Sel berhenti membelah tetapi tidak mati ("sel zombie")
 - b) Menghasilkan zat inflamasi (SASP)
 - c) Akumulasi sel ini mempercepat kerusakan jaringan dan penyakit kronis
- 5) Perubahan Hormonal
 - a) Penurunan hormon (estrogen, testosteron, hormon pertumbuhan)
 - b) Mengganggu metabolisme, kepadatan tulang, dan fungsi organ
- 6) Kerusakan DNA dan Epigenetik
 - a) Mutasi DNA akibat usia dan lingkungan
 - b) Perubahan ekspresi gen tanpa mengubah struktur DNA
- 7) Disfungsi Sistem Imun (*Immunosenescence*)
 - a) Penurunan respons imun
 - b) Meningkatkan risiko infeksi, kanker, dan penyakit kronis
- b. Faktor Ekstrinsik (Lingkungan dan Gaya Hidup), faktor ini dapat mempercepat penuaan (accelerated aging).
 - 1) Radiasi Ultraviolet (UV)
 - a) Penyebab utama penuaan kulit (*photoaging*)
 - b) Menyebabkan kerusakan kolagen dan elastin
 - 2) Polusi Lingkungan
 - a) Paparan toksin meningkatkan stres oksidatif
 - b) Memicu inflamasi kronis
 - 3) Gaya Hidup Tidak Sehat
 - a) Merokok
 - b) Konsumsi alkohol
 - c) Diet buruk
 - d) Kurang aktivitas fisik
 - e) Faktor ini berkontribusi terhadap percepatan penuaan biologis

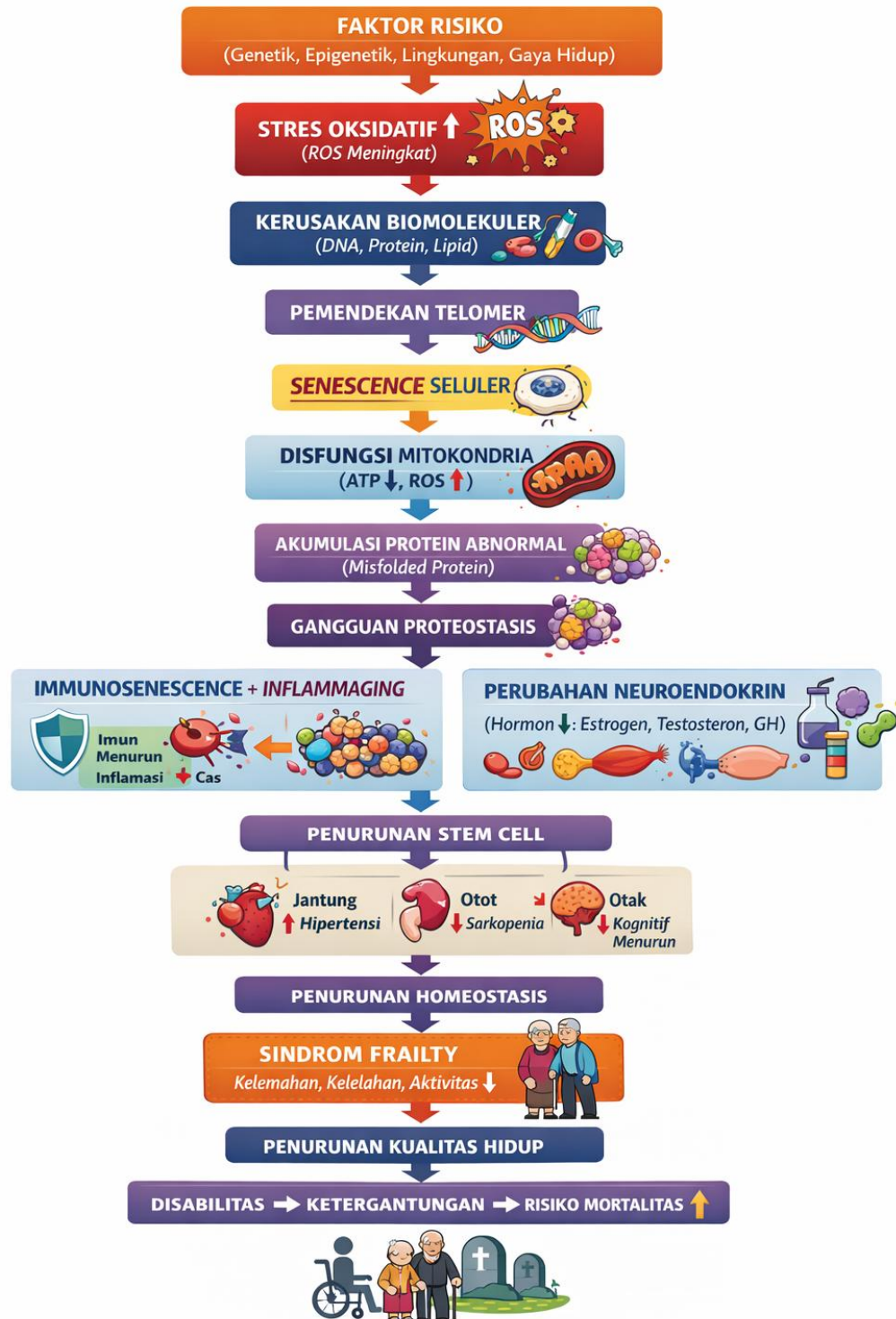
- 4) Stres Psikologis Kronis
 - a) Meningkatkan hormon kortisol
 - b) Mempercepat penuaan sel dan otak
- 5) Penyakit Kronis
 - a) Diabetes, hipertensi, penyakit jantung
 - b) Mempercepat penurunan fungsi organ
 - c) Penyakit tertentu dapat mempercepat “usia biologis” tubuh

2. Patofisiologi

Suatu proses biologis yang kompleks, multifaktorial, dan bersifat progresif serta irreversibel, yang ditandai oleh penurunan fungsi sel, jaringan, dan organ akibat interaksi antara faktor genetik, epigenetik, lingkungan, dan gaya hidup sepanjang siklus kehidupan. Secara molekuler, proses ini diawali oleh peningkatan stres oksidatif akibat akumulasi reactive oxygen species (ROS) yang melebihi kapasitas sistem antioksidan tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan pada DNA, protein, dan lipid sel. Kerusakan biomolekuler ini diperparah oleh pemendekan telomer pada setiap pembelahan sel yang pada akhirnya memicu terjadinya senescence seluler, yaitu kondisi ketika sel kehilangan kemampuan proliferasi namun tetap aktif secara metabolik dan berkontribusi terhadap inflamasi kronis. Selain itu, disfungsi mitokondria menyebabkan penurunan produksi energi (ATP) dan peningkatan pembentukan radikal bebas, yang mempercepat proses apoptosis dan memperburuk kerusakan seluler. Gangguan proteostasis juga terjadi akibat akumulasi protein abnormal atau misfolded protein yang menghambat fungsi normal sel. Pada tingkat sistem, penuaan ditandai oleh terjadinya immunosenescence yang menyebabkan penurunan respons imun adaptif serta peningkatan kondisi inflamasi kronis ringan (inflammaging), sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan penyakit degeneratif. Perubahan pada sistem neuroendokrin, seperti penurunan hormon estrogen, testosteron, dan hormon pertumbuhan, turut berkontribusi terhadap penurunan massa otot, kepadatan tulang, dan metabolisme tubuh. Selain itu, berkurangnya jumlah dan fungsi sel punca (stem cell) menyebabkan menurunnya kapasitas regenerasi jaringan dan memperlambat proses penyembuhan. Akumulasi perubahan tersebut mengakibatkan disfungsi multisistem, seperti penurunan elastisitas pembuluh darah pada sistem kardiovaskular, sarkopenia pada sistem muskuloskeletal, serta penurunan fungsi kognitif pada sistem saraf, yang secara keseluruhan meningkatkan risiko terjadinya sindrom frailty. Kondisi frailty ditandai dengan penurunan cadangan fisiologis, kelemahan, kelelahan, serta meningkatnya ketergantungan, sehingga

berdampak pada penurunan kualitas hidup lansia dan meningkatnya risiko morbiditas serta mortalitas.

Pathway Patofisiologi Penuaan



Gambar 1.2 Desain Nica, 2026

3. Klasifikasi Teori Penuaan

Teori penuaan dikembangkan untuk menjelaskan mekanisme, penyebab, dan konsekuensi dari proses menua yang terjadi secara kompleks dan multidimensional. Tidak ada satu teori tunggal yang mampu menjelaskan seluruh fenomena penuaan, sehingga berbagai pendekatan diklasifikasikan ke dalam kelompok teori berdasarkan perspektif biologis, psikologis, sosial, dan evolusioner. Klasifikasi ini penting dalam keperawatan gerontik karena memberikan dasar ilmiah dalam memahami perubahan lansia serta merancang intervensi yang komprehensif dan berbasis bukti. Secara umum, teori penuaan modern menekankan bahwa penuaan merupakan hasil akumulasi kerusakan biologis, penurunan adaptasi, serta interaksi faktor internal dan eksternal sepanjang kehidupan.



Gambar 1.3 Desain Nica, 2026

- a. Teori Biologis (Biological Aging Theories). Teori biologis menjelaskan penuaan sebagai akibat dari perubahan struktural dan fungsional pada tingkat seluler dan molekuler. Teori ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu teori terprogram (programmed theories) dan teori kerusakan (damage/error theories).

- b. Teori Terprogram (Programmed Theories). Teori ini menyatakan bahwa penuaan telah diprogram secara genetik dalam tubuh manusia, di mana setiap individu memiliki "jam biologis" yang mengatur usia hidupnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah teori genetik dan teori telomer yang menjelaskan bahwa pemendekan telomer membatasi kemampuan sel untuk bereplikasi.
- c. Teori Kerusakan (Damage/Error Theories). Teori ini menjelaskan bahwa penuaan terjadi akibat akumulasi kerusakan sel akibat faktor internal maupun eksternal. Contohnya adalah teori radikal bebas yang menyatakan bahwa ROS menyebabkan kerusakan DNA dan membran sel, serta teori cross-linking yang menjelaskan perubahan struktur protein akibat ikatan silang. Selain itu, teori akumulasi kerusakan (damage accumulation) juga menegaskan bahwa kerusakan yang tidak sepenuhnya diperbaiki akan terakumulasi dan menyebabkan disfungsi organ.
- d. Teori Psikologis (Psychological Aging Theories). Teori psikologis berfokus pada perubahan fungsi mental, emosional, dan adaptasi individu terhadap proses penuaan. Salah satu teori utama adalah teori aktivitas (activity theory) yang menyatakan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial dan fisik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, teori kontinuitas (continuity theory) menjelaskan bahwa individu akan mempertahankan pola perilaku dan kepribadian sepanjang hidupnya sebagai bentuk adaptasi terhadap penuaan. Teori ini menekankan pentingnya kesehatan mental dan kemampuan coping dalam menghadapi perubahan usia.
- e. Teori Sosiologis (Sociological Aging Theories). Teori sosiologis menyoroti perubahan peran sosial, interaksi, dan posisi lansia dalam masyarakat. Teori disengagement menyatakan bahwa penuaan disertai dengan penarikan diri secara bertahap dari aktivitas sosial, sedangkan teori aktivitas justru menekankan pentingnya keterlibatan sosial. Selain itu, teori modernisasi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan industrialisasi dapat menurunkan status sosial lansia karena berkurangnya peran tradisional mereka dalam masyarakat. Teori ini relevan dalam konteks perubahan sosial modern yang memengaruhi kesejahteraan lansia.
- f. Teori Evolusioner (Evolutionary Theories). Teori evolusioner menjelaskan penuaan dari sudut pandang seleksi alam. Penuaan dianggap sebagai konsekuensi dari berkurangnya tekanan seleksi setelah masa reproduksi. Teori ini mencakup konsep seperti mutation accumulation dan antagonistic pleiotropy, yang menyatakan bahwa gen yang menguntungkan pada usia muda dapat berdampak negatif pada usia lanjut. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa penuaan merupakan fenomena universal pada organisme hidup.

- g. Teori Integratif Modern (Integrative Aging Theories). Perkembangan penelitian terbaru menunjukkan bahwa penuaan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu mekanisme tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai proses biologis, psikologis, dan sosial. Pendekatan integratif modern menggabungkan konsep kerusakan seluler, inflamasi kronis, perubahan epigenetik, serta faktor lingkungan dalam satu kerangka holistik. Teori ini menekankan bahwa penuaan merupakan proses dinamis yang melibatkan penurunan kompleksitas sistem biologis dan kegagalan mekanisme perbaikan tubuh secara bertahap.

B. Perubahan Biopsikososial-Spiritual Pada Lansia

Perubahan pada lansia merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penuaan tidak terjadi secara linier, tetapi merupakan hasil dari dinamika kompleks yang melibatkan perubahan molekuler, fungsi otak, kondisi psikososial, serta faktor lingkungan dan gaya hidup. Pendekatan biopsikososial modern menegaskan bahwa kesehatan lansia dipengaruhi oleh keterkaitan erat antara tubuh, pikiran, dan lingkungan sosialnya.

1. Perubahan Biologis (Evidence-Based). Perubahan biologis pada lansia terjadi akibat akumulasi kerusakan seluler dan penurunan fungsi sistem organ. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses penuaan berkaitan dengan disfungsi mitokondria, inflamasi kronis, serta perubahan metabolisme yang memengaruhi berbagai sistem tubuh. Secara klinis, perubahan biologis meliputi penurunan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan fungsi kardiovaskular, serta gangguan sistem imun. Selain itu, penelitian menunjukkan adanya fenomena "*aging acceleration*", yaitu percepatan penuaan pada periode tertentu kehidupan yang berkaitan dengan perubahan molekuler signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan neurodegeneratif. Perubahan biologis juga berkaitan dengan peningkatan inflamasi kronis (*inflammaging*) dan gangguan neuroinflamasi yang berkontribusi terhadap nyeri kronis dan penurunan fungsi neurologis pada lansia.
2. Perubahan Psikologis (Evidence-Based). Perubahan psikologis pada lansia mencakup penurunan fungsi kognitif, perubahan emosional, serta kemampuan adaptasi terhadap stres. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor biologis, psikologis, dan sosial saling berinteraksi dalam memengaruhi kesehatan mental lansia, termasuk risiko depresi dan kecemasan. Secara kognitif, lansia mengalami penurunan memori jangka pendek, kecepatan pemrosesan informasi, dan fungsi eksekutif. Namun, beberapa aspek seperti kebijaksanaan dan pengalaman hidup

tetap terjaga. Selain itu, penelitian terbaru memperkenalkan konsep “*psychogenic aging*”, yang menunjukkan bahwa kondisi psikologis seperti stres kronis dapat mempercepat proses penuaan biologis. Secara emosional, lansia lebih rentan mengalami depresi akibat kehilangan pasangan, penurunan fungsi fisik, serta perubahan peran sosial. Faktor protektif seperti dukungan sosial, aktivitas bermakna, dan coping adaptif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis.

3. **Perubahan Sosial (Evidence-Based).** Perubahan sosial pada lansia berkaitan dengan perubahan peran, status, dan interaksi dalam masyarakat. Lansia sering mengalami pensiun, kehilangan pasangan, serta penurunan partisipasi sosial yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor sosial seperti dukungan keluarga, keterlibatan komunitas, dan mobilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Lansia yang tetap aktif secara sosial dan memiliki kemandirian mobilitas menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan yang mengalami isolasi sosial. Selain itu, rendahnya dukungan sosial terbukti berkaitan dengan peningkatan risiko depresi dan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Oleh karena itu, intervensi sosial menjadi komponen penting dalam asuhan keperawatan gerontik.
4. **Perubahan Spiritual (Evidence-Based).** Perubahan spiritual pada lansia merupakan aspek penting dalam menghadapi proses penuaan dan kematian. Lansia cenderung mengalami peningkatan kebutuhan spiritual, termasuk pencarian makna hidup, penerimaan diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa spiritualitas berperan sebagai faktor protektif terhadap stres, depresi, dan kecemasan. Spiritualitas juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan psikologis, serta kemampuan coping dalam menghadapi penyakit kronis. Pendekatan spiritual dalam keperawatan gerontik membantu lansia mencapai ketenangan batin, meningkatkan harapan hidup, serta memperkuat adaptasi terhadap perubahan fisik dan sosial.

C. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala penuaan merupakan berbagai perubahan yang tampak secara fisik, fisiologis, dan fungsional pada individu lanjut usia sebagai akibat dari proses penuaan yang berlangsung secara progresif. Perubahan ini mencerminkan penurunan kapasitas adaptasi tubuh terhadap stres internal maupun eksternal, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan gangguan fungsi organ. Berikut ini manifestasi klinis berdasarkan sistem tubuh.

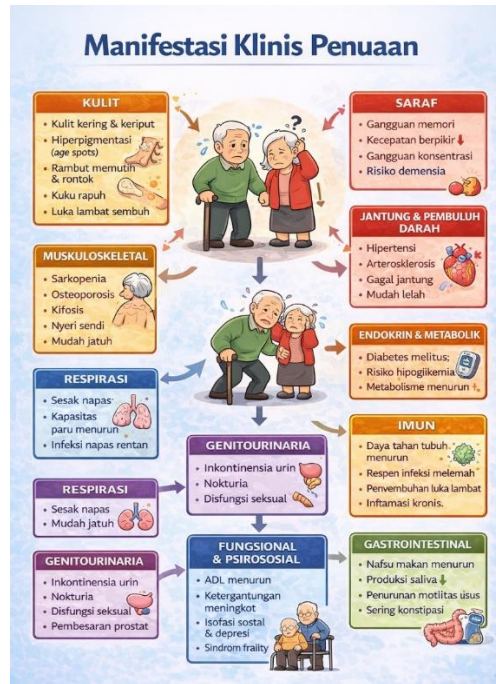
1. **Sistem Integumen.** Penuaan menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi kulit akibat penurunan produksi kolagen, elastin, dan hidrasi kulit. Kulit menjadi

lebih tipis, kering, dan kehilangan elastisitas sehingga tampak keriput. Selain itu, muncul hiperpigmentasi atau bercak penuaan, rambut mengalami pemutihan dan kerontokan, serta kuku menjadi rapuh. Proses penyembuhan luka juga mengalami perlambatan akibat penurunan vaskularisasi dan regenerasi sel.

2. **Sistem Muskuloskeletal.** Perubahan pada sistem muskuloskeletal ditandai dengan penurunan massa dan kekuatan otot yang dikenal sebagai sarkopenia. Kepadatan tulang juga menurun sehingga meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur. Lansia sering mengalami perubahan postur tubuh seperti kifosis, nyeri sendi, serta penurunan mobilitas yang berdampak pada peningkatan risiko jatuh dan ketergantungan.
3. **Sistem Kardiovaskular.** Pada sistem kardiovaskular, terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah yang menyebabkan peningkatan resistensi perifer dan tekanan darah. Fungsi jantung juga menurun, termasuk penurunan curah jantung dan kemampuan beradaptasi terhadap aktivitas. Manifestasi klinis yang muncul antara lain mudah lelah, toleransi aktivitas menurun, serta peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke.
4. **Sistem Respirasi.** Perubahan pada sistem respirasi meliputi penurunan elastisitas paru dan kapasitas vital, sehingga pertukaran gas menjadi kurang optimal. Refleks batuk yang menurun menyebabkan akumulasi sekret, sehingga lansia lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Secara klinis, lansia dapat mengalami sesak napas terutama saat aktivitas.
5. **Sistem Saraf.** Penuaan menyebabkan penurunan jumlah neuron dan fungsi neurotransmitter yang berdampak pada fungsi kognitif. Manifestasi klinis meliputi penurunan daya ingat, kecepatan berpikir yang melambat, gangguan konsentrasi, serta peningkatan risiko demensia. Selain itu, refleks tubuh menjadi lebih lambat sehingga meningkatkan risiko cedera.
6. **Sistem Endokrin dan Metabolik.** Perubahan hormonal terjadi akibat penurunan produksi hormon seperti estrogen, testosteron, dan hormon pertumbuhan. Hal ini berdampak pada penurunan metabolisme basal, peningkatan resistensi insulin, serta perubahan komposisi tubuh. Lansia menjadi lebih rentan terhadap gangguan metabolik seperti diabetes melitus.
7. **Sistem Imun.** Penurunan fungsi sistem imun atau immunosenescence menyebabkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Respon imun menjadi lebih lambat dan kurang efektif, disertai peningkatan inflamasi kronis tingkat rendah. Kondisi ini menyebabkan lansia lebih rentan terhadap infeksi dan memperlambat proses penyembuhan luka.
8. **Sistem Gastrointestinal.** Perubahan pada sistem gastrointestinal meliputi penurunan produksi saliva, berkurangnya nafsu makan, serta penurunan motilitas

usus. Kondisi ini sering menyebabkan konstipasi dan gangguan penyerapan nutrisi, yang berdampak pada status gizi lansia.

9. **Sistem Genitourinaria.** Pada sistem genitourinaria, terjadi penurunan fungsi ginjal dan kapasitas kandung kemih. Lansia dapat mengalami inkontinensia urin, nokturia, serta penurunan fungsi seksual. Pada pria, sering terjadi pembesaran prostat yang dapat mengganggu proses eliminasi urin.



Gambar 1.4 Desain Nica, 2026

Berikut ini merupakan manifestasi fungsional dan psikososial.

1. Perubahan Fungsional. Penuaan menyebabkan penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau Activities of Daily Living. Lansia sering mengalami keterbatasan mobilitas, penurunan kekuatan, serta peningkatan ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Perubahan Psikologis. Perubahan psikologis meliputi penurunan kemampuan adaptasi terhadap stres, peningkatan risiko depresi, kecemasan, serta gangguan kognitif. Lansia juga dapat mengalami perubahan konsep diri akibat perubahan fisik dan peran sosial.
3. Perubahan Sosial. Perubahan sosial ditandai dengan berkurangnya interaksi sosial, pensiun, kehilangan pasangan hidup, serta penurunan peran dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan menurunkan kualitas hidup lansia.

No	Aspek	Perubahan Utama	Mekanisme (Evidence-Based)	Manifestasi Klinis	Implikasi Keperawatan
----	-------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------------

1	Biologis	Penurunan fungsi organ dan sistem tubuh	Disfungsi mitokondria, stres oksidatif, inflamming, penurunan hormon	Kelemahan , sarkopenia, hipertensi, penurunan imun	Monitoring kondisi fisik, promotif preventif, manajemen penyakit kronis
2	Biologis	Penurunan sistem imun	Immunosenesce dan inflamasi kronis	Mudah infeksi, penyembuhan luka lambat	Pencegahan infeksi, edukasi kesehatan, nutrisi adekuat
3	Biologis	Penurunan metabolisme	Resistensi insulin dan perubahan hormonal	Risiko diabetes, obesitas atau malnutrisi	Edukasi diet, monitoring gula darah
4	Psikologis	Penurunan fungsi kognitif	Degenerasi neuron dan neurotransmitter	Gangguan memori, konsentrasi menurun	Stimulasi kognitif, terapi aktivitas
5	Psikologis	Gangguan emosional	Stres kronis, kehilangan peran sosial	Depresi, kecemasan , kesepian	Dukungan emosional, konseling
6	Psikologis	Penurunan koping	Adaptasi terhadap perubahan kehidupan	Mudah stres, menarik diri	Pendampingan psikologis, terapi suportif
7	Sosial	Perubahan peran sosial	Pensiun, kehilangan pasangan	Isolasi sosial, kesepian	Dukungan keluarga, aktivitas sosial
8	Sosial	Penurunan interaksi sosial	Mobilitas terbatas,	Kesepian, depresi	Program komunitas lansia

			perubahan lingkungan		
9	Sosial	Ketergantungan	Penurunan fungsi fisik	Ketergantungan ADL	Rehabilitasi, peningkatan kemandirian
10	Spiritual	Peningkatan kebutuhan spiritual	Pencarian makna hidup dan penerimaan diri	Lebih religius, refleksi diri	Dukungan spiritual, fasilitasi ibadah
11	Spiritual	Koping spiritual	Keyakinan dan nilai hidup	Ketahanan menghadapi penyakit	Pendekatan holistik spiritual
12	Spiritual	Kesejahteraan spiritual	Ketenangan batin dan harapan hidup	Adaptasi lebih baik	Pendampingan spiritual dan keluarga

D. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada lansia merupakan serangkaian pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi, menegaskan diagnosis, serta memantau perkembangan penyakit pada individu lanjut usia. Pemeriksaan ini sangat penting karena lansia sering mengalami kondisi multimorbiditas dan perubahan fisiologis yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, interpretasi hasil pemeriksaan pada lansia harus mempertimbangkan kondisi penuaan normal dan patologis.

Pendekatan pemeriksaan penunjang pada lansia bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, fungsi organ, serta skrining geriatri untuk menilai status fungsional, kognitif, dan psikososial.

Pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu pemeriksaan penunjang utama yang digunakan untuk menilai kondisi metabolik dan fungsi organ pada lansia. Pemeriksaan darah rutin seperti hemoglobin, leukosit, dan trombosit digunakan untuk mendeteksi anemia, infeksi, serta gangguan hematologi. Pemeriksaan kadar glukosa darah, baik gula darah puasa, gula darah sewaktu,

maupun hemoglobin terglikasi (HbA1c), sangat penting untuk mendeteksi dan memantau diabetes melitus yang prevalensinya meningkat pada lansia. Selain itu, pemeriksaan profil lipid seperti kolesterol total, low density lipoprotein, high density lipoprotein, dan trigliserida digunakan untuk menilai risiko penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan fungsi ginjal melalui ureum dan kreatinin serta estimasi laju filtrasi glomerulus (eGFR) juga penting karena fungsi ginjal cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Pemeriksaan fungsi hati dan elektrolit turut diperlukan untuk menilai keseimbangan metabolik dan respons tubuh terhadap terapi.

Selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi berperan penting dalam mengevaluasi struktur organ tubuh. Pemeriksaan foto rontgen digunakan untuk mendeteksi kelainan pada paru dan tulang, seperti pneumonia atau fraktur. Pemeriksaan yang lebih lanjut seperti computed tomography scan dan magnetic resonance imaging digunakan untuk menilai kondisi otak, tumor, serta gangguan neurologis lainnya. Pada lansia, pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mineral density menjadi penting untuk mendeteksi osteoporosis yang sering terjadi akibat penurunan massa tulang.

Pemeriksaan fungsi organ juga merupakan bagian penting dalam evaluasi kesehatan lansia. Elektrokardiografi digunakan untuk menilai aktivitas listrik jantung dan mendeteksi gangguan irama jantung yang sering terjadi pada usia lanjut. Pemeriksaan spirometri digunakan untuk menilai fungsi paru dan kapasitas ventilasi, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit paru. Selain itu, pemeriksaan fungsi ginjal lanjutan seperti eGFR memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan filtrasi ginjal.

Dalam keperawatan gerontik, pemeriksaan skrining geriatri memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya menilai kondisi fisik, tetapi juga aspek kognitif, psikologis, dan fungsional lansia. Pemeriksaan Mini Mental State Examination digunakan untuk menilai fungsi kognitif dan mendeteksi gangguan seperti demensia. Geriatric Depression Scale digunakan untuk mengidentifikasi adanya depresi yang sering tidak terdiagnosis pada lansia. Penilaian Activities of Daily Living dan Instrumental Activities of Daily Living digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Timed Up and Go Test digunakan untuk menilai risiko jatuh yang merupakan salah satu masalah utama pada lansia.

Tabel 1.2 Pemeriksaan Penunjang Pada Lansia

No	Jenis Pemeriksaan	Tujuan	Indikasi pada Lansia
1	Darah rutin	Deteksi anemia dan infeksi	Kelemahan, pucat
2	Gula darah	Deteksi diabetes	Poliuria, polidipsia
3	Profil lipid	Risiko kardiovaskular	Hipertensi, obesitas

4	Fungsi ginjal	Menilai ginjal	Edema, penurunan urin
5	Rontgen	Evaluasi paru dan tulang	Batuk lama, nyeri tulang
6	EKG	Deteksi gangguan jantung	Nyeri dada, palpitasi
7	MMSE	Fungsi kognitif	Lupa, bingung
8	GDS	Deteksi depresi	Murung, menarik diri
9	ADL	Kemandirian	Ketergantungan
10	TUG Test	Risiko jatuh	Gangguan mobilitas

Peran perawat dalam pemeriksaan penunjang sangat penting, mulai dari mempersiapkan pasien sebelum pemeriksaan, memberikan edukasi, hingga melakukan observasi selama dan setelah pemeriksaan. Perawat juga berperan dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara dasar serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan tindak lanjut yang tepat. Dengan demikian, pemeriksaan penunjang pada lansia tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnostik, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia.

E. Komplikasi

Komplikasi pada lansia merupakan kondisi lanjutan yang muncul akibat proses penuaan yang disertai penyakit kronis, penurunan fungsi organ, serta berkurangnya kemampuan adaptasi tubuh terhadap stres. Lansia sering mengalami multimorbiditas yang menyebabkan terjadinya interaksi kompleks antar penyakit, sehingga meningkatkan risiko komplikasi yang bersifat progresif dan dapat menurunkan kualitas hidup. Komplikasi ini dapat melibatkan berbagai sistem tubuh, seperti kardiovaskular, metabolik, neurologis, muskuloskeletal, serta psikososial, dan sering kali saling berkaitan satu sama lain.

Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada lansia adalah penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan elastisitas pembuluh darah dan perubahan struktur jantung yang terjadi seiring bertambahnya usia. Komplikasi yang dapat muncul antara lain stroke, infark miokard, dan gagal jantung kronis. Penatalaksanaan pada kondisi ini meliputi pengendalian faktor risiko seperti tekanan darah, kadar lipid, dan gula darah, pemberian terapi farmakologis sesuai indikasi, serta modifikasi gaya hidup seperti diet sehat, aktivitas fisik teratur, dan berhenti merokok.

Selain itu, gangguan metabolik seperti diabetes melitus juga sering menimbulkan komplikasi pada lansia, termasuk neuropati, nefropati, dan retinopati. Komplikasi ini terjadi akibat hiperglikemia kronis yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil. Penatalaksanaan meliputi pengontrolan kadar glukosa darah

melalui terapi obat, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, serta pemantauan rutin untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Komplikasi pada sistem muskuloskeletal, seperti osteoporosis dan sarkopenia, dapat menyebabkan fraktur, penurunan mobilitas, serta peningkatan risiko jatuh. Risiko jatuh merupakan salah satu masalah utama pada lansia yang dapat menyebabkan cedera serius dan disabilitas. Penatalaksanaan meliputi latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, suplementasi kalsium dan vitamin D, serta modifikasi lingkungan untuk mencegah jatuh.

Pada sistem neurologis, komplikasi seperti demensia dan delirium sering ditemukan pada lansia. Demensia ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang progresif, sedangkan delirium merupakan gangguan kesadaran akut yang sering dipicu oleh infeksi atau gangguan metabolik. Penatalaksanaan meliputi stimulasi kognitif, pengobatan sesuai penyebab, serta dukungan lingkungan yang aman dan terstruktur.

Komplikasi psikologis seperti depresi dan kecemasan juga sering terjadi pada lansia, terutama akibat kehilangan pasangan, perubahan peran sosial, dan penyakit kronis. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan fisik dan meningkatkan risiko kematian. Penatalaksanaan meliputi terapi psikososial, dukungan keluarga, serta intervensi farmakologis bila diperlukan. Selain itu, lansia juga rentan terhadap komplikasi infeksi akibat penurunan sistem imun. Infeksi seperti pneumonia dan infeksi saluran kemih dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan kondisi yang serius. Penatalaksanaan meliputi deteksi dini, terapi antibiotik yang tepat, serta upaya pencegahan seperti imunisasi dan peningkatan kebersihan.

Pendekatan penatalaksanaan pada lansia harus bersifat holistik dan terintegrasi, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian komprehensif, mengidentifikasi faktor risiko, memberikan edukasi kesehatan, serta mendukung lansia dalam mempertahankan kemandirian. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal. Dengan demikian, komplikasi pada lansia merupakan kondisi yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penatalaksanaan yang tepat tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pencegahan komplikasi lebih lanjut, serta dukungan psikososial dan spiritual bagi lansia.

F. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan penuaan merupakan upaya sistematis dan komprehensif yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi fisiologis, mencegah terjadinya

komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal. Pendekatan penatalaksanaan tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, pendekatan penatalaksanaan penuaan berbasis bukti menjadi sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik.

Tabel 1.3 Penatalaksanaan Penuaan pada Lansia

No Pendekatan Tujuan		Intervensi Utama	Contoh Tindakan	Peran Perawat
1	Promotif	Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup	Edukasi gaya hidup sehat	Diet seimbang, olahraga rutin, dan manajemen stres motivator
2	Promotif	Mencegah penurunan fungsi	Peningkatan aktivitas fisik	Latihan kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas
3	Preventif	Mencegah penyakit	Skrining kesehatan rutin	Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol
4	Preventif	Mencegah komplikasi	Imunisasi dan kontrol risiko	Vaksinasi, kontrol DM dan hipertensi
5	Preventif	Mencegah cedera	Modifikasi lingkungan	Pencahayaan baik, pegangan kamar mandi
6	Kuratif	Mengobati penyakit	Terapi farmakologis	Obat antihipertensi, antidiabetik
7	Kuratif	Mengurangi gejala	Terapi nonfarmakologis	Terapi fisik, terapi okupasi
8	Kuratif	Mencegah efek samping	Manajemen obat	Evaluasi interaksi obat
9	Rehabilitatif	Memulihkan fungsi	Latihan fisik dan ADL	Latihan berjalan, aktivitas mandiri

No Pendekatan Tujuan		Intervensi Utama	Contoh Tindakan	Peran Perawat
10	Rehabilitatif	Meningkatkan kemandirian	Penggunaan alat bantu	Edukator penggunaan alat
11	Psikososial	Meningkatkan kesejahteraan mental	Dukungan emosional	Konseling, terapi kelompok Konselor
12	Psikososial	Mencegah isolasi sosial	Aktivitas sosial	Kegiatan komunitas lansia Fasilitator sosial
13	Spiritual	Meningkatkan ketenangan batin	Dukungan spiritual	Ibadah, doa, konseling spiritual Pendamping spiritual
14	Spiritual	Meningkatkan koping	Pemaknaan hidup	Diskusi makna hidup Motivator

Penatalaksanaan promotif pada lansia bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui gaya hidup sehat. Upaya ini meliputi edukasi kesehatan mengenai pentingnya pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, serta penghentian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Aktivitas fisik seperti latihan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas terbukti dapat memperlambat penurunan fungsi otot dan mencegah risiko jatuh. Selain itu, pemenuhan nutrisi yang adekuat, termasuk asupan protein, vitamin, dan mineral, sangat penting dalam mempertahankan massa otot dan fungsi organ.

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit dan komplikasi pada lansia. Upaya ini meliputi skrining kesehatan secara berkala, imunisasi, serta pengendalian faktor risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia. Pemeriksaan kesehatan rutin memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan sehingga dapat dilakukan intervensi secara cepat dan tepat. Selain itu, modifikasi lingkungan rumah yang aman, seperti pencahayaan yang baik dan penggunaan alat bantu, sangat penting untuk mencegah risiko jatuh.

Penatalaksanaan kuratif difokuskan pada pengobatan penyakit yang telah terjadi pada lansia. Pendekatan ini melibatkan terapi farmakologis dan nonfarmakologis yang disesuaikan dengan kondisi individu. Dalam pemberian terapi obat, perlu diperhatikan prinsip penggunaan obat pada lansia, seperti dosis yang tepat, potensi interaksi obat, serta efek samping yang mungkin timbul akibat

perubahan fungsi organ. Selain itu, pendekatan nonfarmakologis seperti terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi psikososial juga berperan penting dalam mendukung pemulihan kondisi lansia.

Penatalaksanaan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan dan mempertahankan kemampuan fungsional lansia agar tetap mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Program rehabilitasi meliputi latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan, pelatihan aktivitas sehari-hari, serta penggunaan alat bantu sesuai kebutuhan. Rehabilitasi juga mencakup dukungan psikologis untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain pendekatan medis, penatalaksanaan penuaan juga harus memperhatikan aspek psikososial dan spiritual. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Keterlibatan lansia dalam aktivitas sosial dan komunitas dapat mencegah isolasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Dari aspek spiritual, lansia perlu difasilitasi dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan menemukan makna hidup, yang terbukti dapat meningkatkan ketenangan batin dan kemampuan koping terhadap penyakit.

Peran perawat dalam penatalaksanaan penuaan sangat strategis, yaitu sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, dan koordinator pelayanan kesehatan. Perawat melakukan pengkajian komprehensif terhadap kondisi lansia, merencanakan intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi hasil tindakan secara berkelanjutan. Pendekatan keperawatan gerontik menekankan pentingnya asuhan yang berpusat pada pasien dan keluarga, serta kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.

Dengan demikian, penatalaksanaan penuaan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan holistik. Tujuan utama penatalaksanaan adalah mempertahankan kemandirian lansia, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Pendekatan berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan individu menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik yang optimal.

Tabel 1.4 Ringkas Penatalaksanaan Pada Lansia

Pendekatan	Fokus Utama	Dampak
Promotif	Gaya hidup sehat	Mencegah penuaan patologis
Preventif	Deteksi dini	Mengurangi risiko penyakit
Kuratif	Pengobatan	Mengontrol penyakit kronis
Rehabilitatif	Pemulihan fungsi	Meningkatkan kemandirian
Psikososial	Dukungan mental	Mencegah depresi
Spiritual	Kesejahteraan batin	Meningkatkan kualitas hidup

Tabel 1.5 Instrumen Pengkajian Gerontik Komprehensif (Cga)

No	Domain Pengkajian	Instrumen Standar	Aspek yang Dinilai	Interpretasi Hasil	Implikasi Keperawatan
1	Fungsi Aktivitas Harian	ADL (Katz Index)	Mandi, berpakaian, makan, eliminasi, berpindah, kontinensia	Mandiri / ketergantungan ringan / sedang / berat	Menentukan tingkat ketergantungan dan kebutuhan bantuan
2	Fungsi Instrumental	IADL (Lawton & Brody)	Mengelola uang, obat, transportasi, belanja, telepon, memasak	Mandiri / perlu bantuan sebagian / total bantuan	Menilai kemampuan hidup mandiri di komunitas
3	Status Kognitif	MMSE (Mini Mental State Examination)	Orientasi, memori, atensi, bahasa, visuospatial	Normal (24–30), gangguan ringan (18–23), berat (<18)	Deteksi gangguan kognitif/demensia
4	Status Psikologis	GDS (Geriatric Depression Scale)	Mood, minat, energi, isolasi sosial	Normal (0–4), depresi ringan (5–8), sedang–berat (≥9)	Deteksi risiko depresi dan isolasi sosial
5	Status Nutrisi	MNA (Mini Nutritional Assessment)	Berat badan, nafsu makan, BMI,	Normal, risiko malnutrisi, malnutrisi	Deteksi risiko kekurangan gizi

				intake makanan		
6	Risiko Jatuh	TUG (Timed Up and Go Test)	Waktu berdiri, berjalan 3 meter, kembali duduk	<10 detik normal, 10–14 risiko, ≥14 tinggi	Pencegahan jatuh dan cedera	
7	Frailty (Kerapuhan)	Fried Phenotype	Penurunan BB, kelemahan, kelelahan, aktivitas rendah, slow walking	Robust / Pre-frail / Frail	Menentukan risiko penurunan fungsi cepat	
8	Status Fisik Umum	TTV & Pemeriksaan Klinis	TD, nadi, RR, suhu, penyakit kronis	Normal / abnormal sesuai standar klinis	Deteksi stabilitas kondisi medis	
9	Status Sosial	APGAR Keluarga / wawancara sosial	Dukungan keluarga, interaksi sosial, tinggal sendiri	Dukungan baik / kurang / isolasi sosial	Menentukan kebutuhan dukungan sosial	
10	Status Lingkungan	Observasi rumah/lingkungan	Keamanan rumah, risiko jatuh, akses layanan	Aman / berisiko / tidak aman	Intervensi home safety & pencegahan jatuh	
11	Status Spiritual	Wawancara spiritual	Makna hidup, ibadah,	Adaptif / maladaptif	Mendukung coping dan	

	coping spiritual	kesejahteraan spiritual
--	---------------------	----------------------------

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Seorang perempuan berusia 72 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sering pusing, mudah lelah, dan nyeri pada punggung bawah sejak 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan sulit tidur dan sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Riwayat penyakit yang dimiliki adalah diabetes melitus sejak 8 tahun yang lalu, namun pasien tidak rutin melakukan kontrol. Pasien tinggal sendiri di rumah sejak suaminya meninggal 3 tahun yang lalu dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan gula darah sewaktu 250 mg/dL, tekanan darah 150/90 mmHg, serta pasien tampak berjalan perlahan dan berhati-hati.

Hasil Pengkajian Menunjukkan

1. Tekanan darah 150/90 mmHg.
2. Gula darah sewaktu 250 mg/dL.
3. Pasien tampak lemah dan mudah lelah.
4. Gaya berjalan lambat dan berhati-hati.
5. Ekspresi wajah tampak cemas.
6. Aktivitas fisik terbatas.

Pertanyaan Diskusi (Level Knows How)

1. Identifikasi masalah keperawatan utama pada pasien berdasarkan kasus di atas.
2. Jelaskan perubahan biologis yang terjadi pada pasien terkait proses penuaan.
3. Analisis kondisi psikologis dan sosial pasien.
4. Tentukan faktor risiko yang memperburuk kondisi pasien.
5. Jelaskan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi.
6. Susun rencana penatalaksanaan berdasarkan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Jelaskan peran perawat dalam penanganan kasus tersebut secara komprehensif.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil berjumlah 4 sampai 5 orang.
2. Diskusikan kasus secara sistematis menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual.
3. Gunakan teori penuaan dan konsep keperawatan gerontik sebagai dasar analisis.
4. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan singkat dan terstruktur.
5. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Kasus II:

Seorang laki-laki berusia 75 tahun dibawa oleh anaknya ke puskesmas dengan keluhan sering lupa, sulit berkonsentrasi, dan terkadang tidak mengenali anggota keluarga sejak 6 bulan terakhir. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan berat badan. Riwayat penyakit hipertensi dan pernah mengalami stroke ringan 1 tahun yang lalu. Pasien tampak kurang berkomunikasi, sering bingung terhadap waktu dan tempat, serta aktivitas sehari-hari mulai dibantu oleh keluarga. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 155/90 mmHg dan pasien tampak lemah.

Hasil Pengkajian Keperawatan Menunjukkan

1. Tekanan darah 155/90 mmHg.
2. Pasien tampak bingung dan disorientasi waktu serta tempat.
3. Komunikasi verbal menurun.
4. Nafsu makan menurun.
5. Aktivitas sehari-hari dibantu keluarga.
6. Pasien tampak lemah

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah utama pada pasien berdasarkan kasus di atas.
2. Analisis perubahan biologis yang terjadi terkait sistem saraf.
3. Jelaskan gangguan kognitif yang dialami pasien.
4. Tentukan faktor risiko yang memperburuk kondisi pasien.
5. Jelaskan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi.
6. Susun penatalaksanaan berdasarkan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Jelaskan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik pada kasus ini.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil berjumlah 4 sampai 5 orang.
2. Diskusikan kasus menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual.
3. Gunakan teori penuaan dan konsep keperawatan gerontik sebagai dasar analisis.
4. Susun hasil diskusi secara sistematis dan ilmiah.
5. Presentasikan hasil diskusi di kelas. 4

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pengkajian

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Kelengkapan Item CGA
- Ketepatan skoring instrument
- Sintesis prioritas masalah dan risiko

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

G. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 78 tahun tinggal di panti werdha. Hasil anamnesis: pasien mengatakan hampir terjatuh dua kali ketika berjalan ke kamar mandi pada malam hari dan merasa kedua tungkainya semakin lemah. Hasil pengkajian: tekanan darah 132/78 mmHg, nadi 80 kali/menit, hasil Timed Up and Go Test 16 detik, gaya berjalan tidak stabil, pencahayaan kamar redup, serta tidak terdapat pegangan di kamar mandi.

Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Menganjurkan pasien menjalani tirah baring total
- B. Memasang restrain setiap kali pasien ditinggalkan
- C. Memperbaiki pencahayaan, memasang pegangan, serta mendampingi mobilisasi pasien
- D. Meminta keluarga mengambil alih seluruh aktivitas sehari-hari pasien
- E. Mengurangi asupan cairan agar pasien tidak sering ke kamar mandi

Kunci Jawaban: C. Memperbaiki pencahayaan, memasang pegangan, serta mendampingi mobilisasi pasien

Rasional:

Hasil Timed Up and Go Test selama 16 detik menunjukkan pasien memiliki risiko jatuh tinggi karena dalam materi, hasil ≥ 14 detik dikategorikan sebagai risiko tinggi. Kondisi tersebut diperkuat oleh gaya berjalan tidak stabil dan lingkungan yang tidak aman. Intervensi yang tepat adalah memodifikasi lingkungan, meningkatkan pencahayaan, menyediakan pegangan, mendampingi mobilisasi, dan menilai kebutuhan penggunaan alat bantu.

2. Seorang perempuan berusia 76 tahun dibawa anaknya ke puskesmas. Hasil anamnesis: selama enam bulan terakhir pasien sering mengulang pertanyaan, lupa jadwal minum obat, dan beberapa kali salah menyebutkan tanggal. Keluhan muncul secara bertahap dan tidak disertai perubahan kesadaran akut. Hasil pengkajian: pasien sadar penuh, tanda-tanda vital stabil, dan skor Mini Mental State Examination adalah 21.

Apakah interpretasi hasil pengkajian yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Fungsi kognitif normal
- B. Gangguan kognitif ringan
- C. Gangguan kognitif berat
- D. Status kognitif tidak dapat dinilai
- E. Gangguan kognitif akut yang pasti menunjukkan delirium

Kunci Jawaban: B. Gangguan kognitif ringan

Rasional:

Mini Mental State Examination digunakan untuk menilai orientasi, memori, atensi, kemampuan bahasa, dan kemampuan visuospasial. Berdasarkan klasifikasi dalam materi, skor 24–30 menunjukkan fungsi kognitif normal, skor 18–23 menunjukkan gangguan kognitif ringan, sedangkan skor kurang dari 18 menunjukkan gangguan kognitif berat. Dengan skor 21, hasil pengkajian pasien termasuk gangguan kognitif ringan.

3. Seorang laki-laki berusia 72 tahun datang ke posyandu lansia bersama anaknya. Hasil anamnesis: sejak istrinya meninggal delapan bulan lalu, pasien lebih sering berada di kamar, tidak tertarik mengikuti kegiatan warga, mudah merasa sedih, dan menganggap dirinya tidak lagi berguna. Hasil pengkajian: pasien masih mandiri dalam aktivitas sehari-hari, tidak mengalami keluhan fisik akut, dan memperoleh skor Geriatric Depression Scale 7.

Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengambil alih seluruh aktivitas sehari-hari pasien
- B. Memusatkan pelayanan pada pemeriksaan fisik pasien
- C. Menganjurkan pasien tetap berada di kamar agar dapat beristirahat
- D. Memberikan dukungan emosional dan melibatkan pasien secara bertahap dalam aktivitas sosial
- E. Memasang restrain untuk mencegah pasien meninggalkan rumah

Kunci Jawaban: D. Memberikan dukungan emosional dan melibatkan pasien secara bertahap dalam aktivitas sosial

Rasional:

Skor Geriatric Depression Scale 7 termasuk kategori depresi ringan karena rentang skor 5–8 menunjukkan depresi ringan. Keluhan kehilangan minat, perasaan tidak berguna, kesedihan, dan penarikan diri setelah kehilangan pasangan menunjukkan kebutuhan intervensi pada aspek psikologis dan sosial. Tindakan yang tepat adalah membangun hubungan terapeutik, memberikan dukungan emosional, melibatkan keluarga, dan mendorong partisipasi sosial secara bertahap.

4. Seorang perempuan berusia 80 tahun dirawat oleh keluarganya di rumah. Hasil anamnesis: pasien mengeluh sulit mengunyah, nafsu makan menurun, serta lebih sering menghabiskan teh daripada makanan utama. Berat badan pasien turun 4 kg dalam tiga bulan terakhir. Hasil pengkajian: pakaian tampak semakin longgar

dan hasil Mini Nutritional Assessment menunjukkan pasien berisiko mengalami malnutrisi.

Apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengkaji pola makan dan kemampuan mengunyah, memantau berat badan, serta menyesuaikan tekstur makanan
- B. Mempertahankan menu biasa agar pasien terbiasa mengunyah makanan keras
- C. Membatasi asupan protein untuk mengurangi beban metabolisme pasien
- D. Mengganti seluruh makanan padat dengan minuman manis
- E. Menunda intervensi sampai pasien menunjukkan tanda penyakit akut

Kunci Jawaban: A. Mengkaji pola makan dan kemampuan mengunyah, memantau berat badan, serta menyesuaikan tekstur makanan

Rasional:

Mini Nutritional Assessment digunakan untuk menilai berat badan, nafsu makan, indeks massa tubuh, dan asupan makanan serta mengidentifikasi kondisi normal, risiko malnutrisi, atau malnutrisi. Penurunan berat badan, berkurangnya nafsu makan, dan kesulitan mengunyah menunjukkan perlunya pengkajian nutrisi yang lebih komprehensif. Perawat perlu memantau asupan dan berat badan, menyesuaikan tekstur makanan dengan kemampuan pasien, serta berkolaborasi dalam pemenuhan nutrisi yang adekuat.

5. Seorang laki-laki berusia 82 tahun dengan penyakit jantung kronis dirawat di rumah. Hasil anamnesis: pasien mengatakan hidupnya tidak lagi bermakna dan ingin tetap melaksanakan ibadah, tetapi keluarga melarangnya karena khawatir pasien kelelahan. Hasil pengkajian: pasien sadar penuh, dapat berkomunikasi dengan baik, tanda-tanda vital stabil, tidak sesak saat istirahat, dan mampu duduk dengan bantuan.

Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengalihkan pembicaraan pasien kepada kegiatan hiburan
- B. Melarang pasien beribadah untuk mencegah kelelahan
- C. Mengutamakan perawatan fisik dan mengabaikan keluhan spiritual
- D. Menyerahkan seluruh pemenuhan kebutuhan spiritual kepada keluarga
- E. Menggali makna hidup pasien dan memfasilitasi ibadah sesuai kemampuan fisiknya

Kunci Jawaban: E. Menggali makna hidup pasien dan memfasilitasi ibadah sesuai kemampuan fisiknya

Rasional:

Lansia dapat mengalami peningkatan kebutuhan spiritual berupa pencarian makna hidup, penerimaan diri, harapan, dan kedekatan dengan Tuhan. Pada

pasien yang stabil dan masih mampu duduk dengan bantuan, perawat dapat memfasilitasi ibadah sesuai kemampuan fisik, mengeksplorasi perasaan dan makna hidup pasien, serta melibatkan keluarga atau pendamping spiritual berdasarkan kebutuhan dan keyakinan pasien.

H. Daftar Pustaka

- Aging Biology Collaborative Group. (2019). New mechanisms of aging and age-related disease. *Nature Medicine*, 25(8), 1253–1262. <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0533-8>
- Arai, H., & Ouchi, Y. (2020). Aging and frailty: A clinical update. *Geriatrics & Gerontology International*, 20(3), 177–183. <https://doi.org/10.1111/ggi.13802>
- Bissett, D. I., & Burgess, K. (2021). Cellular senescence and aging mechanisms. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 22(2), 115–130. <https://doi.org/10.1038/s41580-020-00314-4>
- Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M. O., & Rockwood, K. (2013). Frailty in elderly people. *The Lancet*, 381(9868), 752–762. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)62167-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62167-9)
- Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state": A practical method for grading the cognitive state of patients. *Journal of Psychiatric Research*, 12(3), 189–198. [https://doi.org/10.1016/0022-3956\(75\)90026-6](https://doi.org/10.1016/0022-3956(75)90026-6)
- Fried, L. P., Tangen, C. M., Walston, J., Newman, A. B., Hirsch, C., Gottdiener, J., Seeman, T., Tracy, R., Kop, W. J., Burke, G., & McBurnie, M. A. (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. *The Journals of Gerontology: Series A*, 56(3), M146–M157. <https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.M146>
- Fulop, T., Larbi, A., Dupuis, G., Le Page, A., Frost, E. H., Cohen, A. A., Witkowski, J. M., & Franceschi, C. (2019). Immunosenescence and inflamm-aging as two sides of the same coin. *Frontiers in Immunology*, 10, 1960. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01960>
- Harden, R. M., & Gleeson, F. A. (1979). Assessment of clinical competence using objective structured clinical examination (OSCE). *Medical Education*, 13(1), 41–54. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1979.tb00918.x>
- Inouye, S. K., Studenski, S., Tinetti, M. E., & Kuchel, G. A. (2007). Geriatric syndromes: Clinical, research, and policy implications. *Journal of the American Geriatrics Society*, 55(5), 780–791. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2007.01156.x>

- Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W. (1963). Studies of illness in the aged: The index of ADL. *JAMA*, 185(12), 914–919. <https://doi.org/10.1001/jama.1963.03060120024016>
- Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. *The Gerontologist*, 9(3), 179–186. https://doi.org/10.1093/geront/9.3_Part_1.179
- Li, Z., & Zhao, X. (2022). Oxidative stress and aging: Molecular mechanisms and clinical implications. *Ageing Research Reviews*, 75, 101534. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101534>
- Liu, Z., Kuo, P. L., & Chen, J. (2020). Psychosocial factors and healthy aging: A biopsychosocial perspective. *The Gerontologist*, 60(6), 1105–1115. <https://doi.org/10.1093/geront/gnz194>
- Miller, C. A. (2020). *Nursing for wellness in older adults: Theory and practice*. Wolters Kluwer.
- O’Caoimh, R., Galluzzo, L., Rodriguez-Laso, A., Van der Heyden, J., Ranhoff, A. H., Lamprini-Koula, M., & Cornally, N. (2021). Prevalence of frailty across Europe. *BMC Geriatrics*, 21, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02002-2>
- Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed “Up & Go”: A test of basic functional mobility for frail elderly persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 39(2), 142–148. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The Gerontologist*, 37(4), 433–440. <https://doi.org/10.1093/geront/37.4.433>
- Rushforth, H. E. (2007). Objective structured clinical examination (OSCE): Review of literature. *Nurse Education Today*, 27(5), 481–490. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2006.12.014>
- Smith, P. J., & Blumenthal, J. A. (2020). Psychological aging and stress physiology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 123–145. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095509>
- United Nations. (2023). *World population ageing 2023*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://www.un.org>

- World Health Organization. (2020). *Decade of healthy ageing 2021–2030*. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2022). *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1982). Development and validation of a geriatric depression screening scale. *Journal of Psychiatric Research*, 17(1), 37–49. [https://doi.org/10.1016/0022-3956\(82\)90033-4](https://doi.org/10.1016/0022-3956(82)90033-4)

BAB 2

ETIK, HAK DAN ISSUE LEGAL DALAM PERAWATAN LANSIA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu-keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu–keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Bab 2. Etika, Hak Lansia, dan Isu Legal dalam Praktik Keperawatan	3.1 Menerapkan prinsip etika dalam penyelesaian kasus-kasus keperawatan gerontik.	3.2 Menjelaskan hak lansia, informed consent, kerahasiaan, dan isu legal (penelantaran, kekerasan, kapasitas keputusan).	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6
---	---	--	--------	-------------------

CPMK-2	Analisis kasus etik-legal tertulis; refleksi terarah	Identifikasi isu etik-legal & hak lansia (≥4 poin relevan); rekomendasi keputusan/advokasi konsisten dengan prinsip etika dan prosedur (≥2 justifikasi)	10	Lembar analisis kasus; refleksi etis
CPMK-5	OSCE/role play komunikasi; penugasan materi edukasi	Keterampilan komunikasi (empati, klaritas, validasi, adaptasi sensori/kognitif) minimal “baik” pada ≥4 komponen; materi edukasi sesuai health literacy dan budaya (≥2 strategi adaptasi)	10	Video/lembar observasi OSCE; leaflet/outline edukasi
CPMK-6	Audit dokumentasi simulasi; tugas handover & rekonsiliasi obat; kuis keselamatan	Dokumentasi (lengkap, akurat, tepat waktu) ≥85% item terpenuhi; kualitas handover (SBAR/format setara) ≥4 elemen lengkap; identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan (≥3 risiko + 3 tindakan)	15	Catatan SOAP/ADPIE; form handover; form rekonsiliasi obat; hasil audit

Uraian Materi

Etik, hak dan aspek legal dalam perawatan lansia merupakan suatu yang sangat penting dalam rangkaian perawatan pada lansia. Etik Adalah konsep yang memberikan arah tentang baik, buruk, benar dan salah dari Tindakan. Hak mengacu pada hal-hal yang seharusnya diterima oleh lansia Ketika dilakukan perawatan, dan legal merupakan pedoman tertulis yang bisa dsijadikan pedoman dari tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Etik Dalam Perawatan Lansia
- Aspek etik dalam perawatan lansia adalah penerapan nilai-nilai moral dan prinsip etika dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu lanjut usia. Etika keperawatan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak agar pelayanan yang diberikan tetap menghormati hak, martabat, dan kebutuhan pasien.
- Lansia sering kali menghadapi berbagai masalah seperti penurunan fungsi fisik, gangguan kognitif, hingga ketergantungan pada orang lain. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak, sehingga tenaga kesehatan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

A. Prinsip-Prinsip Etik dalam Perawatan Lansia

Dalam praktik keperawatan lansia, terdapat beberapa prinsip etik utama yang harus diperhatikan:

1. Autonomi (Autonomy)

Prinsip ini menekankan bahwa lansia memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait dirinya sendiri. Tenaga kesehatan harus menghormati pilihan pasien, termasuk dalam hal pengobatan atau perawatan, selama pasien masih memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan.

2. Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk memberikan tindakan yang terbaik demi kesejahteraan pasien. Setiap tindakan harus didasarkan pada niat untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

3. Non-Maleficence (Tidak Merugikan)

Tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Dalam konteks lansia, hal ini penting karena kondisi mereka lebih rentan terhadap efek samping atau komplikasi.

4. Justice (Keadilan)

Semua pasien, termasuk lansia, berhak mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, baik dari segi usia, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial.

5. Veracity (Kejujuran)

Tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada pasien dan keluarga, terutama terkait kondisi kesehatan dan rencana perawatan.

6. Fidelity (Kesetiaan)

Prinsip ini berkaitan dengan menjaga kepercayaan pasien. Perawat harus konsisten dalam memberikan pelayanan sesuai janji dan menjaga kerahasiaan informasi pasien.

B. Penerapan Aspek Etik dalam Perawatan Lansia

Penerapan etika dalam perawatan lansia dapat dilihat dalam berbagai situasi berikut:

1. Pengambilan Keputusan Medis

Dalam beberapa kasus, lansia mungkin mengalami penurunan fungsi kognitif. Perawat harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan keinginan pasien, serta melibatkan keluarga bila diperlukan.

2. Informed Consent

Sebelum melakukan tindakan medis, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami oleh lansia. Hal ini penting agar pasien dapat memberikan persetujuan secara sadar.

3. Perlindungan terhadap Kekerasan dan Penelantaran

Lansia berisiko mengalami kekerasan fisik, emosional, atau penelantaran. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab etik untuk mengenali tanda-tanda tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

4. Privasi dan Kerahasiaan

Informasi kesehatan lansia harus dijaga kerahasiaannya. Perawat tidak boleh membagikan informasi tanpa izin pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum.

5. Perawatan Akhir Hayat (End-of-Life Care)

Dalam kondisi terminal, aspek etik menjadi sangat penting. Perawat harus menghormati pilihan pasien terkait perawatan paliatif, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga.

C. Tantangan Etik dalam Perawatan Lansia

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan etika antara lain:

1. Konflik antara keinginan pasien dan keluarga
2. Keterbatasan sumber daya pelayanan kesehatan
3. Penurunan kapasitas kognitif pasien

4. Perbedaan nilai budaya dan kepercayaan

D. Hak Lanjut Usia

Definisi hak lansia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang yang telah mencapai usia lanjut untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan agar dapat hidup layak, mandiri, serta tetap dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, dan mereka berhak memperoleh berbagai bentuk pelayanan seperti kesehatan, sosial, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial.

Berikut penerapan hak lansia dalam kehidupan sehari-hari (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998):

1. Pelayanan keagamaan & mental spiritual

Lansia difasilitasi ikut pengajian, kebaktian, atau kegiatan rohani di banjar/komunitas. Keluarga membantu mengantar ke tempat ibadah atau menyediakan sarana ibadah di rumah.

2. Pelayanan kesehatan

Pemeriksaan rutin di puskesmas atau posyandu lansia, mendapat prioritas antrean atau layanan khusus di fasilitas kesehatan.

3. Kesempatan kerja (sesuai kemampuan)

Lansia tetap bisa bekerja ringan, seperti berjualan kecil-kecilan atau kerajinan, dilibatkan sebagai penasihat atau berbagi pengalaman di komunitas.

4. Pendidikan dan pelatihan

Mengikuti pelatihan keterampilan (misalnya membuat kerajinan, berkebun), kelas literasi digital sederhana agar bisa memakai ponsel untuk komunikasi.

5. Kemudahan fasilitas umum

Tersedianya kursi prioritas di bus, jalur khusus, atau pegangan tangan di tempat umum, layanan prioritas di bank, rumah sakit, atau kantor pelayanan publik. Pemberian potongan harga pada beberapa penggunaan layanan public merupakan contoh nyata dari implementasi dari pemberian kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas umum.

6. Bantuan sosial

Mendapat bantuan tunai/sembako dari pemerintah bagi lansia kurang mampu, program keluarga atau desa yang membantu kebutuhan harian.

7. Perlindungan sosial & penghormatan

Tidak ditelantarkan atau diperlakukan kasar oleh keluarga/masyarakat, dilibatkan dalam kegiatan keluarga dan tetap dihargai pendapatnya. Lansia

diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai aktifitas sosial baik produktif maupun non produktif

E. Isu dan Aspek Legal Perawatan Lansia

Isu Perawatan Lansia

Definisi isu adalah suatu permasalahan atau topik penting yang muncul di masyarakat dan memerlukan perhatian, pembahasan, serta penyelesaian karena dapat berdampak pada individu maupun kelompok. Dalam konteks umum isu sering berkaitan dengan kondisi yang belum terselesaikan atau masih menimbulkan perdebatan, dapat bersifat aktual (sedang terjadi) atau berkembang dalam jangka waktu tertentu dan memiliki dampak sosial, ekonomi, hukum, atau kesehatan. Perawatan lansia menghadapi berbagai isu, antara lain:

1. Isu Kesehatan

Lansia rentan terhadap penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan demensia. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Posbindu lansia yang disiapkan untuk pelayanan primer terkendala oleh keterbatasan

2. Isu psikologis

Banyak lansia mengalami kesepian, depresi, dan perasaan tidak berguna akibat perubahan peran sosial dalam keluarga dan masyarakat. Kecemasan, kesepian dan depresi merupakan masalah psikosoal yang saat ini ditemukan pada lansia seiring dengan penambahan usia.

3. Isu sosial

Terjadi perubahan struktur keluarga yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap lansia. Urbanisasi dan kesibukan keluarga membuat lansia berisiko mengalami penelantaran.

4. Isu ekonomi

Tidak semua lansia memiliki jaminan finansial. Banyak yang bergantung pada keluarga atau bantuan sosial dari pemerintah.

5. Isu kekerasan dan penelantaran

Kasus kekerasan terhadap lansia sering tidak terungkap, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun penelantaran.

F. Legal Aspek Perawatan Lansia

Peningkatan usia harapan hidup di Indonesia menyebabkan jumlah lanjut usia (lansia) semakin meningkat setiap tahun. Lansia merupakan kelompok rentan yang mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial sehingga membutuhkan

perhatian khusus, termasuk dalam aspek perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum, negara telah memberikan perlindungan melalui berbagai regulasi. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang secara khusus mengatur hak dan kesejahteraan lansia. Selain itu, perkembangan terbaru dalam sistem kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memperkuat pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk lansia. Dengan adanya kedua regulasi tersebut, perawatan lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat dalam menjamin kualitas hidup lansia. Undang-undang nomor 13 tahun 1998, merupakan landasan utama dalam perlindungan lansia di Indonesia. Lansia didefinisikan sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Lansia dalam peraturan ini dikelompokkan sebagai lansia potensial yakni: masih mampu bekerja, dan lansia tidak potensial yakni lansia yang memerlukan bantuan.

Tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam perawatan antara lain: 1) pemerintah: menyediakan kebijakan dan fasilitas, 2) keluarga: merawat lansia dan 3) masyarakat: berpartisipasi dalam pelayanan sosial

Dalam UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ditetapkan:

Tentang hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan termasuk lansia yakni: 1) mendapat pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, 2) mendapat akses pelayanan kesehatan, 3) Mendapat perlindungan Kesehatan. Dalam peraturan ini bentuk pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan menurut UU 17 tahun 2023 antara lain 1) Promotif (peningkatan kesehatan), 2) preventif (pencegahan penyakit), 3) kuratif (pengobatan), 4) rehabilitatif (pemulihan) dan 4) paliatif. Perawatan lansia diutamakan untuk perawatan jangka panjang.

Aktivitas 1 — Knows How

Seorang lansia laki-laki 76 tahun menyampaikan badannya lemah, sering pusing, sering merasa keseimbangannya terganggu. Lansia memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun dan stroke berulang sudah 2 X. Stroke pertama 4 tahun lalu dan stroke kedua 6 bulan yang lalu. Saat ini dirawat di rumah dan tidak mau dirawat di rumah sakit karena alasan sudah tua dan tidak ada yang menunggu di rumah sakit. Lagi pula saat ini merasa nyaman tinggal di rumah. Hasil pemeriksaan vital sign Tensi 180/90 mmHg, Nadi 85 kali, Suhu 36,8 derajat. Kekuatan otot 55/222. Hasil pemeriksaan indeks Katz D, skor MMSE: 17, Skor GDS: 4.

Diskusikan dalam kelompok:

1. Bagaimana pandangan saudara dari segi etik dengan menganalisis sikap pasien lansia tersebut.

2. Apa saran terkait etik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah diatas!

Aktivitas 2 — Shows How

Seorang lansia 80 tahun dirawat di rumah dengan post stroke. Saat ini terbaring di rumah dengan kondisi badan lemah, tidak mampu beraktifitas dan terus berbaring saja. Sampai saat ini lansia hanya dirawat di rumah oleh keluarga terutama anaknya. Dari hasil pengkajian lansia tampak lemah, ada decubitus seluas 6 cm² di bokong dengan kedalaman 2 cm. Keluarga tidak mau membawa ke rumah sakit dan minta dirawat di rumah saja.

Tugas

1. Lakukan kajian etik dari permintaan pasien dan keluarga!
2. Lakukan kajian aspek legal jika pasien tersebut dirawat di rumah!
3. Lakukan simulasi edukasi terkait dengan etik dan aspek legal untuk bisa melakukan bantuan pelayanan perawatan pada lansia di rumah.

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Menjelaskan aspek etik pemilihan perawatan di rumah
- Menjelaskan aspek legal perawatan pasien di rumah
- Menjelaskan ketentuan perawatan pasien di rumah
- Menjelaskan prosedur perawatan luka di rumah

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

G. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 76 tahun dengan riwayat hipertensi dan stroke dirawat di rumah. Hasil anamnesis: pasien menolak dirujuk ke rumah sakit karena merasa lebih nyaman dirawat di rumah. Pasien mampu menjelaskan kembali risiko dari keputusannya. Hasil pengkajian: kesadaran compos mentis, tekanan darah 180/90 mmHg, nadi 85 kali/menit, suhu 36,8°C, dan keluarga memaksa pasien menjalani perawatan di rumah sakit.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Membawa pasien ke rumah sakit tanpa persetujuannya
- B. Mengikuti keputusan keluarga karena kondisi pasien berisiko
- C. Menghentikan seluruh pelayanan karena pasien menolak rujukan
- D. Menilai kapasitas pasien, menjelaskan risiko dan alternatif perawatan, kemudian menghormati keputusan pasien
- E. Menyembunyikan informasi tentang risiko penyakit agar pasien tidak merasa cemas

Kunci Jawaban: D. Menilai kapasitas pasien, menjelaskan risiko dan alternatif perawatan, kemudian menghormati keputusan pasien

Rasional:

Prinsip autonomi menegaskan bahwa lansia mempunyai hak untuk menentukan keputusan mengenai pengobatan dan perawatannya selama masih memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Pada kasus ini, pasien sadar, mampu memahami informasi, dan dapat menjelaskan risiko keputusannya. Perawat harus memberikan informasi secara jujur dan mudah dipahami, memastikan keputusan dibuat secara sadar, serta menghormati pilihan pasien untuk dirawat di rumah.

2. Seorang perempuan berusia 79 tahun dirawat karena luka pada kaki yang memerlukan tindakan perawatan luka. Hasil anamnesis: pasien terkadang lupa waktu dan sulit memahami penjelasan yang panjang. Anak pasien langsung menyetujui tindakan tanpa melibatkan pasien. Hasil pengkajian: pasien sadar, dapat berkomunikasi, mampu menyebutkan identitasnya, tetapi belum dapat menjelaskan tujuan dan risiko tindakan yang akan dilakukan.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Melakukan tindakan karena anak pasien telah memberikan persetujuan
- B. Membatalkan seluruh tindakan tanpa memberikan penjelasan kepada pasien
- C. Memberikan penjelasan sederhana, menilai kembali pemahaman dan kapasitas pasien, serta melibatkan keluarga bila diperlukan
- D. Meminta pasien menandatangani persetujuan tanpa menjelaskan risiko tindakan

E. Menyerahkan seluruh keputusan kepada keluarga tanpa mengkaji kemampuan pasien

Kunci Jawaban: C. Memberikan penjelasan sederhana, menilai kembali pemahaman dan kapasitas pasien, serta melibatkan keluarga bila diperlukan Rasional:

Sebelum tindakan dilakukan, lansia harus memperoleh penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami agar dapat memberikan persetujuan secara sadar. Penurunan fungsi kognitif tidak secara otomatis menghilangkan seluruh hak pasien untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Perawat perlu menyesuaikan cara komunikasi, menilai kapasitas pasien, menghormati keinginannya, dan melibatkan keluarga apabila pasien benar-benar memerlukan bantuan dalam mengambil keputusan.

3. Seorang laki-laki berusia 71 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol hipertensi dan diabetes melitus. Hasil anamnesis: pasien meminta agar kondisi kesehatannya tidak disampaikan kepada tetangga karena khawatir menjadi bahan pembicaraan. Hasil pengkajian: setelah pelayanan selesai, perawat menceritakan diagnosis dan hasil pemeriksaan pasien kepada ketua lingkungan tanpa persetujuan pasien dan tanpa kepentingan pelayanan.

Apakah aspek etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut?

- A. Autonomi
- B. Beneficence
- C. Justice
- D. Non-maleficence
- E. Privasi dan kerahasiaan

Kunci Jawaban: E. Privasi dan kerahasiaan

Rasional:

Informasi kesehatan lansia harus dijaga kerahasiaannya. Perawat tidak boleh menyampaikan identitas, diagnosis, hasil pemeriksaan, atau informasi pribadi pasien kepada orang lain tanpa izin pasien, kecuali terdapat kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Tindakan perawat yang membagikan informasi kepada ketua lingkungan tanpa persetujuan dan tanpa kepentingan pelayanan merupakan pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan pasien.

4. Seorang perempuan berusia 82 tahun dengan keterbatasan mobilitas dikunjungi perawat di rumah. Hasil anamnesis: pasien mengatakan sering tidak diberi makan ketika anaknya pergi bekerja dan takut berbicara karena pernah dimarahi serta didorong. Hasil pengkajian: tubuh pasien tampak kurus, pakaian kotor, terdapat

memar pada lengan, lingkungan tempat tidur tidak terawat, dan pasien tampak takut ketika anaknya mendekat.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengabaikan temuan karena perawatan lansia merupakan urusan keluarga
- B. Menanyakan kejadian hanya di hadapan anak pasien
- C. Menyarankan pasien menerima perlakuan tersebut karena bergantung kepada keluarga
- D. Mengkaji pasien secara privat, mengenali tanda kekerasan dan penelantaran, menjaga keselamatan pasien, serta mengoordinasikan bantuan yang sesuai
- E. Menyampaikan seluruh cerita pasien kepada tetangga agar keluarga mendapat tekanan sosial

Kunci Jawaban: D. Mengkaji pasien secara privat, mengenali tanda kekerasan dan penelantaran, menjaga keselamatan pasien, serta mengoordinasikan bantuan yang sesuai

Rasional:

Lansia berisiko mengalami kekerasan fisik, emosional, verbal, maupun penelantaran. Tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab etik untuk mengenali tanda-tanda tersebut dan mengambil tindakan yang tepat. Memar, ketakutan terhadap anggota keluarga, kurangnya makanan, kebersihan yang buruk, dan lingkungan yang tidak terawat merupakan temuan yang perlu dikaji lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keamanan dan privasi pasien.

H. Ringkasan

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan pemahaman lansia dan keluarga tentang etik legal perawatan lansia stroke di rumah. Misalnya lansia dan keluarga mengatakan mengerti, keluarga mau menandatangani informed consent dan kontrak perawatan di rumah. Namun apabila ada kondisi yang membahayakan keluarga bisa mengambil Keputusan untuk membawa pasien ke rumah sakit.

I. Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Lansia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil kesehatan Indonesia 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2016). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. Pearson.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- United Nations (1991). *United Nations Principles for Older Persons*.
- World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2004). Clinical management of acute diarrhoea: WHO/UNICEF joint statement. World Health Organization.
- World Health Organization. (2005). The treatment of diarrhoea: A manual for physicians and other senior health workers (4th rev.). World Health Organization.
- World Health Organization. (2010). WHO recommendations on the management of diarrhoea and pneumonia in HIV-infected infants and children: Integrated management of childhood illness (IMCI). World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Ageing and Health*.
- World Health Organization. (Active Ageing: A Policy Framework, 2002).

BAB 3

MENETAPKAN DIAGNOSIS KEPERAWATAN GERONTIK DAN MENYUSUN RENCANA ASUHAN BERBASIS EVIDENCE

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu-keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.

CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Gerontik dan Peran Perawat	1.1 Menguraikan ruang lingkup keperawatan gerontik, terminologi kunci, dan kebutuhan layanan lansia.	1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, dan kompetensi perawat dalam tim geriatri serta alur layanan promotif–paliatif.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-6
Bab 2. Teori Penuaan & Perubahan Biopsikososial-Spiritual pada Lansia	2.1 Membedakan teori/konsep penuaan dan implikasinya terhadap respon kesehatan lansia.	2.2 Menganalisis perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia sebagai dasar intervensi holistik.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5
Bab 3. Etika, Hak Lansia, dan Isu Legal dalam Praktik Keperawatan	3.1 Menerapkan prinsip etika dalam penyelesaian kasus-kasus keperawatan gerontik.	3.2 Menjelaskan hak lansia, informed consent, kerahasiaan, dan isu legal (penelantaran, kekerasan, kapasitas keputusan).	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6

Bab 4. Pengkajian Gerontik Komprehensif (CGA): ADL/IADL, frailty, risiko	4.1 Melakukan CGA terstruktur menggunakan instrumen ADL/IADL, skrining frailty, kognitif, mood, nutrisi, dan risiko jatuh.	4.2 Mensintesis temuan CGA menjadi masalah prioritas, risiko, dan kebutuhan rujukan/kolaborasi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Diagnosa Keperawatan Gerontik & Perencanaan Asuhan Berbasis Evidence	5.1 Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik berbasis data dengan prioritas yang jelas.	5.2 Menyusun rencana asuhan berbasis evidence (tujuan terukur, intervensi, evaluasi) dan indikator hasil.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-6
Bab 6. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia & Keluarga (kultural dan empatik)	6.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada lansia secara empatik dan adaptif terhadap keterbatasan sensori/kognitif.	6.2 Merancang edukasi kesehatan dan counseling keluarga dengan pendekatan kultural, health literacy, dan shared decision-making.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-2
Bab 7. Dokumentasi, Continuity of Care, dan Pengantar Mutu-Keselamatan Pasien Lansia	7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.	7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 8. Frailty, Sarcopenia, dan Risiko Disabilitas	8.1 Menilai frailty dan sarcopenia serta keterkaitannya dengan disabilitas dan outcome.	8.2 Merancang intervensi keperawatan/kolaboratif untuk pencegahan dan penanganan frailty-sarcopenia.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4

Bab 9. Jatuh pada Lansia: Skrining Risiko, Pencegahan, dan Rehabilitasi	9.1 Melakukan skrining risiko jatuh dan identifikasi faktor intrinsik-ekstrinsik.	9.2 Menyusun paket pencegahan jatuh dan rencana rehabilitasi dasar pasca-jatuh termasuk edukasi lingkungan aman.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 10. Delirium: Deteksi Dini, Tata Laksana Keperawatan, dan Pencegahan	10.1 Melakukan deteksi dini delirium dan identifikasi faktor pemicu menggunakan alat skrining sederhana.	10.2 Menyusun intervensi keperawatan nonfarmakologis, monitoring, dan pencegahan delirium secara kolaboratif.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
Bab 11. Ulkus Tekan & Perawatan Kulit Lansia: Pencegahan hingga Perawatan Luka	11.1 Mengidentifikasi risiko ulkus tekan dan langkah pencegahan berbasis repositioning serta perawatan kulit.	11.2 Merencanakan perawatan luka dasar (asesmen luka, balutan, nyeri) dan rujukan sesuai tingkat keparahan.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 12. Inkontinensia Urin/Feses dan Asuhan Keperawatan Terintegrasi	12.1 Mengkaji tipe/derajat inkontinensia dan dampaknya pada kualitas hidup serta risiko komplikasi.	12.2 Merancang asuhan terintegrasi dan edukasi (latihan, manajemen cairan, higiene, alat bantu) dengan evaluasi terukur.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
Bab 13. Malnutrisi, Dehidrasi, dan Masalah Menelan (Dysphagia) pada Lansia	13.1 Melakukan skrining malnutrisi, dehidrasi, dan dysphagia serta menetapkan risiko aspirasi.	13.2 Menyusun intervensi nutrisi-hidrasi aman (modifikasi tekstur, posisi, pemantauan) dan evaluasi outcome.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
Bab 14. Polifarmasi & Keselamatan Obat pada Lansia	14.1 Mengidentifikasi polifarmasi, obat berisiko tinggi, dan	14.2 Merancang strategi keselamatan obat: rekonsiliasi obat, edukasi kepatuhan, dan komunikasi	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

(kolaborasi interprofesional)	potensi interaksi/efek samping melalui medication review sederhana.	interprofesional untuk deprescribing bila perlu.		
-------------------------------	---	--	--	--

Uraian Materi

Peningkatan angka harapan hidup di berbagai negara menyebabkan jumlah populasi lansia semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam penyediaan asuhan keperawatan yang komprehensif bagi lansia. Lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mempertahankan kesehatan dan kemandirian. Oleh karena itu, pendekatan asuhan keperawatan gerontik harus dilakukan secara sistematis melalui proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Keperawatan gerontik merupakan pelayanan profesional yang berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendekatan bio-psiko-sosio-spiritual secara holistik. Pelayanan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi penyakit, tetapi juga mempertahankan fungsi dan kemandirian lansia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.

Salah satu tahapan penting dalam proses keperawatan adalah penetapan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap respons individu terhadap masalah kesehatan yang dialami. Diagnosis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang tepat dan efektif. Pada lansia, diagnosis keperawatan sering berkaitan dengan masalah seperti risiko jatuh, gangguan mobilitas, defisit perawatan diri, gangguan pola tidur, nyeri kronis, serta isolasi sosial.

Seiring berkembangnya ilmu keperawatan, praktik keperawatan modern menekankan penggunaan Evidence Based Nursing Practice (EBNP). Pendekatan ini mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis perawat, serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

Dalam konteks pendidikan keperawatan, pendekatan Outcome Based Education (OBE) menekankan pencapaian kompetensi mahasiswa yang terukur. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep diagnosis keperawatan gerontik, tetapi juga mampu menerapkan perencanaan asuhan berbasis bukti secara sistematis dalam praktik klinik.

A. Pengertian Diagnosis dan Standar Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan klinis yang dibuat oleh perawat berdasarkan data pengkajian untuk menggambarkan respons individu terhadap masalah kesehatan. Diagnosis ini berbeda dengan diagnosis medis karena lebih berfokus pada respons pasien terhadap kondisi kesehatan yang dialaminya,

Pada lansia, diagnosis keperawatan memiliki karakteristik khusus karena dipengaruhi oleh proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi fisiologis. Selain itu, lansia sering mengalami penyakit kronis multipel yang memerlukan pendekatan asuhan yang komprehensif.

Diagnosis keperawatan juga diartikan sebagai elemen kunci untuk menetapkan perawatan yang sesuai dalam mendukung pencapaian tingkat kesehatan yang optimal (PPNI, 2017) serta menjadi dasar dalam pemilihan rencana tindakan keperawatan yang sudah menjadi tanggung jawab profesi perawat (disetujui pada Konferensi NANDA Kesembilan; diubah pada tahun 2009, 2013, 2019, 2023). Diagnosis keperawatan merupakan sebuah penilaian klinis yang bertujuan mengenali reaksi klien, baik dari individu, keluarga, maupun komunitas terhadap isu kesehatan atau perjalanan kehidupan yang dihadapi, baik nyata maupun potensial (PPNI, 2017).

Standar Diagnosis Keperawatan lebih dikenal SDKI, merupakan acuan atau pedoman dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk menetapkan diagnosis keperawatan secara sistematis dan konsisten. SDKI dirancang untuk memastikan layanan keperawatan yang diberikan oleh perawat profesional sesuai dengan standar keamanan, efektif dan sesuai dengan prinsip etika profesi. Dengan mengacu kepada Standar Praktik Keperawatan Indonesia yang diterbitkan tahun 2005 oleh PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). SDKI mencerminkan dedikasi yang tinggi sebagai profesi keperawatan dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mendukung perawat dalam pengambilan keputusan klinis yang akurat dan berbasis bukti demi asuhan keperawatan yang profesional (PPNI, 2017).

SDKI merupakan standar diagnosis yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan, dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, kejelasan dalam penalaran diagnostik, kelengkapan jenis diagnosis serta standar bahasa (Nurhesti et al., 2020). SDKI juga merupakan standar diagnosis keperawatan yang dikembangkan oleh PPNI dan gabungan diagnosis keperawatan berdasarkan NANDA, ICNP dan Carpenito. Terdapat 148 diagnosa keperawatan dalam SDKI dengan label diagnosa sesuai NANDA. SDKI juga merupakan inovasi perawat di Indonesia untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan yang praktis sesuai budaya, situasi dan kondisi di Indonesia.

Perawat diharapkan mampu dalam memberikan perhatian yang menyeluruh, baik kepada klien dalam kondisi sehat maupun sakit. Respons tersebut menjadi sebuah reaksi klien terhadap permasalahan kesehatan dan perjalanan hidup klien. Masalah kesehatan berkaitan dengan reaksi klien terhadap keadaan sehat maupun sakit, sementara proses kehidupan, mulai dari pembuahan, lahir, pertumbuhan,

perkembangan, hingga akhir hayat dan kematian yang memerlukan diagnosis keperawatan serta dapat ditangani atau dimodifikasi melalui intervensi keperawatan (Christensen & Kenney, 2009; Seaback, 2009). Pendekatan ini memastikan bahwa perawat memberikan asuhan keperawatan yang holistik, berpusat pada individu, serta berorientasi pada kebutuhan fisik, psikologis, sosial maupun spiritual.

Diagnosis keperawatan lebih banyak kepada proses berpikir kritis perawat dengan pencatatan yang digunakan oleh perawat untuk menyampaikan hasil analisis dan penilaian pengkajian data dengan cara yang terstandarisasi (NANDA International, 2024). Hal ini, memudahkan komunikasi yang efektif antar profesi kesehatan. Penggunaan istilah yang sudah terstandarisasi penting agar seluruh tim memahami masalah keperawatan dan rencana perawatan pasien secara komprehensif (NANDA International, 2024). Selain itu, istilah yang terstandarisasi dan memiliki kode mendukung upaya penelitian dengan memungkinkan studi respons pasien yang memiliki definisi dan indikator diagnostik yang identik di berbagai tempat, pengaturan perawatan maupun negara (NANDA International, 2024). Penerapan terminologi yang terstandarisasi untuk menggambarkan penilaian dan intervensi klinis menjaga konsistensi di berbagai disiplin ilmu perawatan kesehatan, termasuk keperawatan. Pendekatan terpadu ini memastikan komunikasi yang efektif dan menumbuhkan pemahaman bersama dalam menangani perawatan klien (NANDA International, 2024). Beberapa sasaran dari standarisasi perawatan adalah untuk menjadi pedoman dalam penetapan diagnosis, menentukan hasil dan intervensi keperawatan, meningkatkan kemandirian perawat, mempermudah komunikasi antara profesional serta multidisiplin, meningkatkan kualitas perawatan.

Diagnosis keperawatan merupakan landasan dalam menentukan intervensi keperawatan agar mencapai hasil yang diharapkan (NANDA International, 2024). Sebagian besar banyak yang sudah mengenal diagnosis medis, seperti mengidentifikasi penyakit, gangguan kesehatan atau cedera berdasarkan tanda dan gejala yang dialami individu (Hansbauer, 2021), namun banyak yang tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa perawat juga menentukan diagnosis, meskipun fokusnya berbeda dengan diagnosis medis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diagnosis keperawatan, bila digunakan dengan tepat, memiliki prediktabilitas yang lebih besar dalam aspek-aspek penting, seperti lamanya perawatan dan kembali rawat inap ulang di rumah sakit dibandingkan hanya menggunakan diagnosis medis (D'Agostino et al., 2019; Sanson et al., 2019; Zeffiro et al., 2020).

Perawat memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan pasien, memberikan edukasi kesehatan, membantu meningkatkan kemampuan pasien

untuk hidup lebih sehat, dan mendengarkan empati pengalaman unik klien (NANDA International, 2024). SDKI menjadi acuan penting dalam penyusunan diagnosis yang tepat, serta mendasari intervensi keperawatan yang sesuai untuk mencapai hasil yang dicapai.

Penerapan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia sangat penting bagi perawat dalam melaksanakan praktiknya di berbagai lingkup pelayanan keperawatan. Hal ini disebabkan diagnosis keperawatan merupakan bagian integral dari pemberian asuhan keperawatan yang mencakup proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi), sehingga dengan adanya standar diagnosis keperawatan di Indonesia, diharapkan pelayanan keperawatan menjadi lebih terstandar dan berkualitas (PPNI, 2017)

B. Tujuan Diagnosis Keperawatan

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi menurut Wahid & Suprpto (2012), sebagai berikut:

1. Masalah dimana adanya respon pasien terhadap status kesehatan atau penyakit;
2. Faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah;
3. Kemampuan pasien untuk mencegah dan menyelesaikan masalah;
4. Mengkomunikasikan masalah pasien pada tim kesehatan;
5. Mendemonstrasikan tanggung jawab dalam identifikasi masalah pasien

C. Klasifikasi Diagnosis Keperawatan

Sistem klasifikasi International Classification for Nursing Practice (ICNP) lebih komprehensif daripada sekadar diagnosis keperawatan, yang mencakup tiga aspek utama dalam praktik keperawatan diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam ICNP, diagnosis keperawatan dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yakni (PPNI, 2017):

1. Fisiologis, berkaitan dengan pernapasan, sirkulasi darah, nutrisi, kebutuhan cairan elektrolit, dan seterusnya
2. Psikologis, berkaitan dengan kenyamanan, rasa sakit, pertumbuhan dan juga perkembangan
3. Perilaku, berkaitan dg kebersihan individu, kebiasaan, edukasi dan informasi
4. Relasional, berkaitan dengan hubungan sosial dengan orang lain
5. Lingkungan, berkaitan dengan keamanan dan proteksi

Klasifikasi tersebut membantu perawat dalam memahami dan menangani berbagai kebutuhan klien dengan lebih baik.

D. Jenis Diagnosis Keperawatan

Terdapat dua jenis diagnosis keperawatan, yakni (Carpenito, 2013):

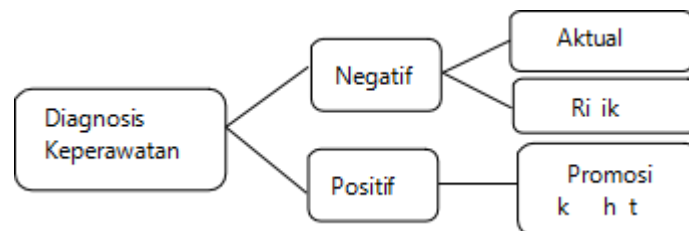
1. Diagnosis negatif

Menjadi acuan dalam memberikan intervensi keperawatan yang memiliki tujuan menyembuhkan, memulihkan, atau mencegah penyakit. Terdapat dua jenis diagnosis negatif, yaitu:

- Diagnosis aktual, mencerminkan masalah isu kesehatan yang dihadapi klien saat ini, dengan adanya tanda-tanda atau gejala utama yang dikenali dan divalidasi.
- Diagnosis risiko, menggambarkan potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada klien karena adanya faktor risiko, meskipun belum ada tanda-tanda atau gejala yang muncul

2. Diagnosis positif

Diagnosis ini dikenal dengan diagnosis promosi kesehatan yang menunjukkan keinginan dan motivasi klien dalam meningkatkan kondisi kesehatannya (PPNI, 2017).



Gambar 3.1 Jenis Diagnosis Keperawatan

Sumber: (PPNI, 2017)

E. Komponen Diagnosis Keperawatan

Komponen dalam diagnosis keperawatan terdapat dua (PPNI, 2017), berikut penjelasannya:

1. Masalah

Merupakan label atau nama diagnosis yang mencerminkan respons klien terhadap keadaan kesehatan atau perjalanan hidupnya. Label diagnosis terdiri atas deskriptor (pernyataan yang menggambarkan suatu fokus diagnosis terjadi) dan fokus diagnostik (aspek utama yang menjadi pusat perhatian dalam diagnosis) (Lihat tabel 2.1). Deskriptor digunakan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik fokus diagnosis dalam proses keperawatan. Contoh: gangguan pertukaran gas, label diagnosisnya adalah gangguan sebagai deskriptor dan pertukaran gas sebagai fokus diagnostik.

Tabel 2.1 Deskriptor dan Fokus Diagnostik

Deskriptor	Fokus diagnostik
Defisit	Pengetahuan
Gangguan	Pertukaran gas
Intoleransi	Aktivitas
Penurunan	Curah jantung
Tidak efektif	Bersihkan jalan napas

Sumber: (PPNI, 2017)

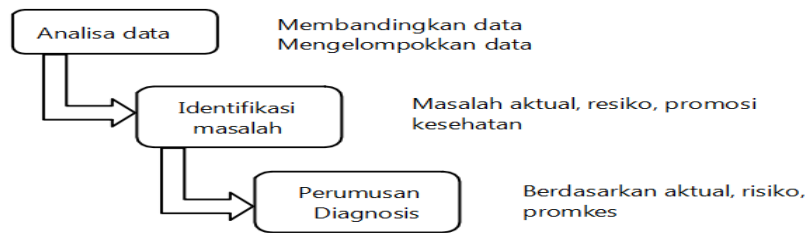
2. Indikator diagnostik

Dibagi menjadi tiga elemen utama yaitu (PPNI, 2017):

- a. Etiologi atau penyebab adalah elemen-elemen yang berpengaruh terhadap perubahan dalam status kesehatan. Penyebab ini dapat dibagi menjadi empat kategori, diantaranya:
 - 1) Fisiologis, biologis, atau psikologis, berkaitan dengan fungsi tubuh, kondisi biologis atau mental
 - 2) Efek terapi/tindakan, disebabkan pengobatan/prosedur tertentu
 - 3) Situasional, dipengaruhi lingkungan atau personal;
 - 4) Maturasional, berkaitan dengan proses perkembangan dan pertumbuhan
- b. Tanda/gejala, tanda merupakan sebuah data objektif yang didapatkan melalui pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, prosedur lainnya. Sedangkan, gejala yaitu data secara subjektif yang didapatkan dari wawancara atau keluhan yang disampaikan klien. Terdapat dua kelompok tanda dan gejala yaitu mayor ditemukan sebanyak 80% - 100% kasus untuk menegakkan diagnosis; dan minor tidak selalu ditemukan, dan bersifat sebagai data pendukung
- c. Faktor risiko adalah keadaan yang membuat individu lebih rentan terhadap masalah kesehatan, seperti pola hidup, riwayat keluarga atau faktor lingkungan

F. Proses Penegakan Diagnosis Keperawatan

Secara sistematis, sebelum menegakkan diagnosis keperawatan terdapat tahapan yang harus dilalui yaitu, analisa data, identifikasi masalah dan perumusan diagnosa. Berikut uraiannya meliputi (PPNI, 2017) :



Gambar 2.2 Tahapan Proses Penegakan Diagnosis Keperawatan
Sumber: (Ackley et al., 2017; Berman et al., 2015; Potter & Perry, 2013)

1. Analisis data

Tahap ini melibatkan beberapa langkah, diantaranya:

- a. Membandingkan data dengan nilai normal, data yang sudah dikumpulkan dianalisis, kemudian membandingkan nilai-nilai normal untuk mengidentifikasi tanda/gejala yang signifikan.

Contoh:

Data subyektif: "Klien mengeluhkan nyeri saat menelan, karena tumor di leher, sehingga BB turun lebih dari 10 kg dalam 5 bulan terakhir".

Data objektif: TB = 153 cm, BB = 40kg

Bila terdapat data antropometri (TB, BB), maka harus menghitung IMT nya, yaitu:

$$IMT = BB / (TB \text{ dalam meter})^2 = 40 / 2.34 = 17.09$$

Hasil IMT pada klien adalah 17,04, sedangkan nilai normal IMT adalah 18,59 – 22,9. Data hasil perhitungan IMT menunjukkan bahwa status gizi klien saat ini sedang ada gangguan/masalah.

- b. Mengelompokkan data

- 1) Data yang relevan disusun berdasarkan pola kebutuhan dasar klien
- 2) Proses pengelompokan data, dilakukan dengan pendekatan induktif, memilah data untuk membentuk pola tertentu berdasarkan temuan; pendekatan deduktif, menggunakan pola atau kategori tertentu untuk mengatur data berdasarkan kategori yang relevan.

Data dikelompokkan sesuai dengan masalah keperawatan, untuk mendukung penegakan diagnosis keperawatan (Susilaningsih, 2018).

2. Identifikasi masalah

Perawat bersama klien bekerjasama mengenali dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada, setelah data dianalisis. Masalah dapat berupa:

- a. Masalah aktual, masalah kesehatan yang dialami saat ini atau klien saat ini sedang mengalami gangguan/masalah tertentu (aktual) (Susilaningsih, 2018)
- b. Risiko, potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Apabila terdapat suatu respon tertentu dari klien yang apabila tidak dilakukan penanganan,

maka dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau klien bisa jatuh dalam kondisi lebih parah/mengalami komplikasi di kemudian hari, walaupun pada saat ini klien belum mengalami gangguan/masalah (Susilaningsih, 2018)

- c. Promosi kesehatan, peluang meningkatkan kondisi kesehatan klien. Suatu kondisi yang memungkinkan klien mengembangkan potensi-potensi peningkatan kesehatan (Susilaningsih, 2018).

Langkah berikutnya, adalah memvalidasi data. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keakuratan diagnosis, dimana perawat bersama klien memvalidasi diagnosis, sehingga diketahui bahwa klien setuju dengan masalah yang sudah dibuat dan faktor-faktor yang mendukungnya. Contoh: Perawat mengukur BB klien akibat tumor yang dideritanya.

3. Perumusan diagnosis keperawatan

Tahap selanjutnya adalah merumuskan diagnosis keperawatan ditulis berdasarkan tipe diagnosis yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan diagnosis keperawatan, yaitu:

- a. Perhatikan kategori dan subkategori dalam diagnosis keperawatan.

Terdapat lima kategori dalam perumusan diagnosis keperawatan sesuai dengan SDKI, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan.

- b. Penulisan diagnosis keperawatan, menggunakan model three part atau two part. Penulisan dengan three part digunakan pada masalah aktual, sedangkan two part digunakan pada masalah risiko dan promosi kesehatan.

- 1) Three part (penulisan tiga bagian)

Metode yang digunakan untuk diagnosis aktual yang mencakup masalah, penyebab dan tanda atau gejala, dengan formasi berikut:

**Masalah berhubungan dengan penyebab
dibuktikan dengan tanda/gejala**

Frasa "berhubungan dengan" dapat disingkat b.d. dan "**dibuktikan dengan**" disingkat d.d.

Contoh penulisan:

Bersihkan jalan napas tidak efektif b.d. spasme jalan napas d.d. batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dispnea, gelisah

- 2) Two Part (penulisan dua bagian)

Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan, dengan formulasi sebagai berikut:

- a) Diagnosis risiko

Masalah dibuktikan dengan Faktor Risiko

Ditulis dalam dua bagian, mencakup pernyataan masalah dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap masalah

Contoh: risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun

b) Diagnosis promosi kesehatan

Masalah dibuktikan dengan Tanda/gejala

Menyatakan kesiapan klien untuk peningkatan kesehatan dan tanda-tanda kesiapan

Contoh: Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal

Menentukan diagnosis keperawatan yang utama dengan mempertimbangkan masalah yang mengancam nyawa atau jiwa, masalah keamanan, prioritas menurut klien, prioritas menurut perawat dan bila ditangani, akan mengatasi diagnosa keperawatan lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diagnosis keperawatan dapat dilakukan secara akurat untuk membantu menentukan intervensi yang tepat bagi klien.

G. Kriteria Penunjuk Penulisan Diagnosis Keperawatan

Menurut Rohmah (2017), kriteria petunjuk penulisan diagnosis keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Tulis masalah pasien/perubahan status kesehatan pasien;
2. Pastikan bahwa masalah pasien didahului adanya penyebab dan keduanya dihubungkan dengan kata "berhubungan dengan";
3. Definisi karakteristik, jika diikuti dengan penyebab kemungkinan dihubungkan dengan kata dibuktikan dengan;
4. Tulis istilah yang umum digunakan;
5. Pastikan bahwa pernyataan masalah menandakan apakah keadaan yang tidak sehat dari pasien atau apa yang diharapkan pasien bisa berubah;
6. Hindarkan menggunakan definisi karakteristik diagnosis medis atau sesuatu yang tidak bisa dirubah dalam pernyataan masalah;
7. Baca ulang diagnosis keperawatan untuk memastikan bahwa pernyataan masalah bisa dicapai dan penyebabnya bisa diukur oleh perawat

H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan Diagnosis Medis

Menurut Rohmah (2017), ada beberapa perbedaan antara diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis, di bawah ini:

1. Diagnosis keperawatan

- Berfokus pada respon atau reaksi pasien terhadap penyakitnya;
- Berorientasi pada kebutuhan individu, bio-psiko-sosio- spiritual;
- Berubah sesuai dengan perubahan respon pasien
- Mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi

2. Diagnosa medis

- Berfokus pada faktor-faktor yang bersifat pengobatan dan penyembuhan penyakit;
- Berorientasi kepada keadaan patologis
- Cenderung tetap, mulai dari sakit sampai sembuh;
- Mengarah kepada tindakan medik yang sebagian besar dikolaborasikan kepada perawat

I. Format atau Lembar Diagnosis Keperawatan

1. Format analisis data

Format ini merupakan format yang berisi data-data abnormal yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Dalam format Analisa data pada bagian atas terdiri atas nama/umur, ruang/kelas dan nomor rekam medis klien. Data harus diisi semua untuk memastikan, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan ke klien.

Contoh: Tabel Analisis Data pada gerontik sesuai Buku SDKI

No	Problem Keperawatan	Etiologi (E)	Data Pendukung : Gejala Mayor / Faktor Resiko (S)
1	Risiko Jatuh, (D.0143)	-	Faktor Risiko Usia kurang lebih 65 ke atas Riwayat jatuh Kekuatan otot menurun
2		Kerusakan integritas struktur tulang	A. Gejala Mayor. Data S. 1).mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas Data O.

	Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)	Ketidak bugaran fisik	1) kekuatan otot menurun 2) rentang gerak (ROM) menurun B. Gejala Minor. (sebagai data pendukung, tidak wajib ada)
3	Defisit Perawatan Diri mandi (D.0109)	Gangguan musculoskeletal Gangguan neuromuskuler	A. Gejala Mayor. Data S. 1).menolak melakukan perawatan diri Data O. tidak mampu mandi minat melakukan perawatan diri kurang B. Gejala Minor. (sebagai data pendukung, tidak wajib ada)
4	Nyeri Kronis(D. 0078)	-Kondisi musculoskeletal kronis -kerusakan system syaraf	A. Gejala Mayor. Data S. 1).mengeluh nyeri 2) merasa depresi (tertekan) Data O. tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas B. Gejala Minor. (sebagai data pendukung, tidak wajib ada)
5	Gangguan Pola Tidur (D.0055)	-Kurang control tidur -Hambatan lingkungan (mis.kelembapan lingkungan sekitar,suhu lingkungan,kebiasaan)	A. Gejala Mayor. Data S. 1).mengeluh sulit tidur 2) mengeluh tidak puas tidur 3) Mengeluh pola tidur berubah Data O. <i>-(tidak tersedia)</i> B. Gejala Minor. (sebagai data pendukung, tidak wajib ada)
6	Risiko Gangguan Integritas Kulit (D.0139)	-	Faktor Risiko perubahan sirkulasi perubahan status nutrisi (kekurangan) kekurangan volume cairan

7	Intoleransi Aktivitas (D.0056)	-Ketidak seimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen -Tirah baring - Kelemahan	A. Gejala Mayor. Data S. 1).mengeluh lelah Data O. frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat B. Gejala Minor. (sebagai data pendukung, tidak wajib ada)
8	Risiko defisiensi nutrisi (D.0032)		Faktor Risiko ketidak mampuan menelan makanan ketidak mampuan mencerna makanan ketidak mampuan mengabsorpsi nutrient
9	Isolasi Sosial (D.0121)	- Keterlambatan perkembangan - Ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan	A. Gejala Mayor. Data S. 1).merasa ingin sendirian 2) merasa tidak aman di tempat umum Data O. menarik diri tidak berminat /menolak berinteraksi dengan orang lain /lingkungan B. Gejala Minor Data S. 1).merasa berbeda dengan orang lain 2) merasa asik dengan pikiran sendiri Data O. afek datar afek sedih
10	Risiko Infeksi (D.0142)	-	Faktor Risiko penyakit kronis (mis.diabetes mellitus) efek prosedur invasive malnutrisi

2. Format Diagnosis Keperawatan

Merupakan format yang berisikan diagnosis keperawatan yang telah dirumuskan dan diurutkan sesuai dengan prioritas masalah.

- Menganalisa data
- Mengidentifikasi masalah
- Memformulasikan diagnosis:
 - Masukkan semua data ke dalam format Analisa data

- 2) Tentukan masalah dari data subjektif dan objektif
- 3) Tentukan etiologi data subjektif dan objektif
- d. Setelah semua format Analisa data terisi, masukkan masalah dan etiologi ke format diagnose keperawatan dengan menambahkan kata "berhubungan dengan".
- e. Setelah memasukkan diagnose keperawatan, tulis tanggal ditemukan diagnosis serta paraf dan nama jelas perawat yang merumuskan diagnosis keperawatan.

Semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. SDKI diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan dan Pendidikan, namun dapat masuk ke dalam sistem JKN sebagai Upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan (Susilaningsih, 2018).

Contoh; Perumusan Diagnosis Keperawatan

1. Risiko Jatuh dibuktikan dengan (dd) adanya Factor risiko, usia kurang lebih 65 ke atas, Riwayat jatuh dan Kekuatan otot menurun
2. Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan dengan (bd) Kerusakan integritas struktur tulang dan
Ketidak bugaran fisik dibuktikan dengan (dd) mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, tidak mampu mandi dan rentang gerak (ROM) menurun
3. Defisit Perawatan Diri mandi Berhubungan dengan (bd) Gangguan neuromuskuler dan Gangguan musculoskeletal dd. menolak melakukan perawatan diri, tidak mampu mandi dan minat melakukan perawatan diri kurang
4. Nyeri kronis Berhubungan dengan (bd) kondisi musculoskeletal kronis dan Gangguan neuromuskuler (dd) mengeluh nyeri, merasa depresi (tertekan), tampak meringis, gelisah dan tidak mampu menuntaskan aktivitas
5. Gangguan Pola Tidur Berhubungan dengan (bd) kurang control tidur dan hambatan lingkungan (mis. kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, kebisingan) (dd) mengeluh sulit tidur, mengeluh tidak puas tidur dan Mengeluh pola tidur berubah
6. Risiko Gangguan Integritas Kulit Tidur dibuktikan dengan (dd) perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi (kekurangan) dan kekurangan volume cairan
7. Intoleransi Aktivitas Berhubungan dengan (bd) ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, tirah baring, dan kelemahan (dd) mengeluh lelah dan frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

8. Risiko deficit nutrisi dibuktikan dengan (dd) ketidak mampuan mengabsorbsi nutrient, ketidak mampuan menelan makanan dan ketidak mampuan mencerna makanan
9. Isolasi Sosial Berhubungan dengan (bd) keterlambatan perkembangan dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan (dd) merasa ingin sendirian, merasa tidak aman di tempat umum, menarik diri dan tidak berminat /menolak berinteraksi dengan orang lain /lingkungan
10. Risiko Infeksi dibuktikan dengan (dd) penyakit kronis (mis diabetes mellitus), efek prosedur invasife dan malnutrisi

J. Konsep Tahap Perencanaan Dalam Keperawatan

Definisi intervensi dan tindakan keperawatan memiliki definisi yang berbeda. Intervensi keperawatan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh perawat, didasarkan pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai kriteria hasil yang diharapkan. Sedangkan, tindakan keperawatan merujuk pada langkah-langkah spesifik yang perawat lakukan sebagai bagian dari pelaksanaan intervensi keperawatan (PPNI, 2018a). Intervensi keperawatan perlu distandarisasi sebagai panduan penyusunan intervensi keperawatan, penyeragaman istilah/penyebutan intervensi keperawatan; perluasan (ekspansi) ilmu keperawatan; pengembangan sistem informasi; pembelajaran decision making bagi peserta didik keperawatan; penentuan biaya pelayanan yang diberikan oleh perawat; sebagai media mengkomunikasikan keperawatan ke tenaga kesehatan lain (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) merupakan panduan yang digunakan untuk merencanakan intervensi keperawatan yang bertujuan memberikan asuhan keperawatan secara aman, efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. SIKI juga merupakan salah satu standar profesi yang dibutuhkan dalam menjalankan praktik keperawatan. Intervensi merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan klien, individu, keluarga, dan komunitas. Intervensi keperawatan yang diterapkan di beberapa instansi pelayanan kesehatan di Indonesia telah mengacu kepada standar dan referensi internasional. Akan tetapi, karena belum distandarisasi dan dibakukan, maka diterapkan secara beragam. Penggunaan terminology intervensi keperawatan yang terstandar dapat secara signifikan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektifitas asuhan keperawatan. PPNI menerbitkan panduan berupa Standar Intervensi Keperawatan Indonesia agar tercipta keseragaman terminologi (PPNI, 2018a).

Salah satu keunggulan yang harus dimiliki standar intervensi keperawatan

adalah komprehensif (area generalis dan spesialis; fisiologis dan psikososial; kuratif, preventif; dan promotif; individu, keluarga dan komunitas; direct care dan indirect care; independent dan collaborative); berbasis riset; mudah digunakan; menggunakan istilah klinis yang jelas dan dapat dikaitkan dengan diagnosis dan outcome keperawatan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

Adapun rentang intervensi keperawatan yang dimaksud ada empat, yakni direct care intervention (intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien/laying on of hands); indirect care intervention (intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien namun dilaksanakan demi pasien); nurse- initiated intervention (intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan); health provider- initiated intervention (intervensi yang diinisiasi oleh tenaga Kesehatan lain, namun diberikan oleh perawat) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

K. Tujuan Intervensi Keperawatan

Tujuan SIKI, yaitu:

1. Menjadi panduan bagi perawat dalam Menyusun intervensi keperawatan
2. Meningkatkan otonomi bagi perawat dalam memberikan pelayanan Kesehatan
3. Memudahkan komunikasi intraprofesional dan interprofessional melalui penggunaan istilah intervensi keperawatan yang seragam dan terstandarisasi
4. Meningkatkan mutu asuhan keperawatan

Tujuan SIKI juga membantu perawat merencanakan dan melaksanakan perawatan dengan cara sistematis dan berbasis pengetahuan ilmiah, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Standar ini disusun berdasarkan sistem klasifikasi dari International Classification of Nursing Practice (ICNP) (PPNI, 2018a). Standar ini mencerminkan komitmen profesi keperawatan dalam memberikan praktik keperawatan.

L. Klasifikasi Intervensi Keperawatan

Sistem pengelompokan yang disusun secara hierarki, mulai dari konsep yang bersifat umum atau tingkat tinggi hingga konsep yang lebih khusus atau tingkat rendah merupakan klasifikasi intervensi keperawatan. Tujuan klasifikasi tersebut untuk mempermudah pencarian intervensi keperawatan, serta memahami berbagai jenis intervensi yang sesuai dengan area praktik dan cabang disiplin ilmu keperawatan serta memudahkan pengkodean yang sesuai dengan penggunaan basis komputer.

Secara skematis (Doengoes et al., 2013; Wake & Coeen, 1998), sistem klasifikasi ini mencakup lima kategori utama dan empat belas subkategori yang dirinci (PPNI, 2018a):

1. Fisiologis, kategori ini mencakup intervensi yang mendukung pemulihan fisik dan regulasi homeostasis, meliputi:
 - a. Respirasi: yang memuat kelompok intervensi keperawatan yang mendukung pemulihan fungsi pernapasan dan oksigenasi
 - b. Sirkulasi: mendukung pemulihan fungsi jantung dan pembuluh darah
 - c. Nutrisi/cairan, mendukung pemulihan fungsi asupan makanan bergizi, gastrointestinal, metabolisme, serta keseimbangan cairan dan elektrolit
 - d. Eliminasi: mendukung pemulihan fungsi eliminasi fekal dan urinaria
 - e. Aktivitas/istirahat: mendukung pemulihan fungsi muskuloskeletal, pengelolaan energi dan istirahat/tidur
 - f. Neurosensoris, mendukung pemulihan fungsi otak dan sistem saraf
 - g. Reproduksi dan seksualitas, mendukung pemulihan fungsi reproduksi dan aspek seksual
2. Psikologis, kategori ini berfokus mendukung fungsi fisik serta proses mental, meliputi:
 - a. Nyeri dan kenyamanan: mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa nyaman.
 - b. Integritas ego: memulihkan kesejahteraan emosional
 - c. Pertumbuhan dan perkembangan: mendukung fungsi tumbuh dan perkembangan individu
3. Perilaku, kategori ini bertujuan mendukung perubahan perilaku atau penerapan pola hidup sehat, meliputi:
 - a. Kebersihan diri, memulihkan kebiasaan, gaya hidup, kemampuan individu dalam merawat dirinya sendiri
 - b. Penyuluhan dan pembelajaran, meningkatkan informasi, pengetahuan, serta edukasi tentang pola hidup sehat
4. Relasional, mencakup intervensi yang mendukung interaksi sosial, termasuk pemulihan hubungan sosial antar individu
5. Lingkungan, kategori ini meliputi: keamanan dan proteksi: meningkatkan keselamatan dan mencegah cedera

M. Komponen Intervensi Keperawatan

Komponen intervensi keperawatan pada standar ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu (PPNI, 2018a):

1. Label

Merupakan nama dari intervensi yang menjadi kata kunci untuk memperoleh informasi tentang intervensi tersebut. Label biasanya terdiri dari satu atau beberapa kata yang diawali dengan kata benda, bukan kata kerja, dan berfungsi sebagai deskriptor intervensi keperawatan.

Terdapat sekitar 18 deskriptor yang digunakan pada label intervensi keperawatan, yaitu:

Tabel 2.2 Deskriptor Intervensi Keperawatan

Deskriptor	Definisi
Dukungan	Memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan
Edukasi	Mengajarkan atau memberikan informasi
Kolaborasi	Melakukan kerjasama atau interaksi
Konseling	Memberikan bimbingan
Konsultasi	Memberikan informasi tambahan atau pertimbangan
Latihan	Mengajarkan suatu keterampilan atau kemampuan
Manajemen	Mengidentifikasi dan mengelola
Pemantauan	Mengumpulkan dan menganalisis data
Pemberian	Menyiapkan dan memberikan
Pemeriksaan	Mengobservasi dengan teliti
Pencegahan	Meminimalkan risiko atau komplikasi
Pengontrolan	Mengendalikan
Perawatan	Mengidentifikasi dan merawat
Promosi	Meningkatkan
Rujukan	Menyusun penatalaksanaan lebih lanjut
Resusitasi	Memberikan tindakan secara tepat untuk mempertahankan kehidupan
Skrining	Mendeteksi secara dini
Terapi	Memulihkan Kesehatan dan/atau menurunkan risiko

Sumber: (PPNI, 2018a)

2. Definisi

Memberikan penjelasan tentang makna dari label intervensi berupa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh profesi perawat.

3. Tindakan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan intervensi keperawatan. Tindakan ini dikelompokkan menjadi empat jenis, dan penyusunan intervensi keperawatan menggunakan pendekatan OTEK yaitu (Berman et al., 2015; Potter & Perry, 2013; Wilkinson et al., 2016):

a. Observasi

serta analisis data mengenai kondisi kesehatan klien. Kata-kata yang sering digunakan dalam tindakan ini, adalah "identifikasi", "periksa", atau "monitor". Penggunaan kata "kaji", sebaiknya dihindari karena istilah tersebut lebih sering digunakan pada tahap awal proses keperawatan (sebelum diagnosis), sehingga dapat menyebabkan kerancuan, sementara itu, tindakan observasi merupakan langkah yang dilakukan setelah diagnosis untuk memantau kondisi pasien.

b. Terapeutik

Tindakan langsung yang dapat memulihkan kondisi Kesehatan klien atau mencegah buruknya masalah kesehatan. Kata-kata yang biasa digunakan, "berikan", "lakukan", maupun istilah serupa untuk menggambarkan aktivitas yang berdampak langsung terhadap kesehatan pasien

c. Edukasi

Tindakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan merawat diri melalui pembelajaran perilaku dan keterampilan baru untuk mengatasi masalah kesehatan. Kata-kata yang sering digunakan dalam tindakan edukasi adalah "ajarkan" "anjurkan", atau "latih".

d. Kolaborasi

Tindakan ini berkaitan dengan kolaborasi antara perawat dan professional kesehatan lainnya atau sesama profesi. Kolaborasi dilakukan bila perawat memerlukan penanganan lebih lanjut. Tindakan ini memerlukan gabungan wawasan atau pengetahuan, dan keterampilan, dari berbagai professional Kesehatan. Kata-kata yang sering digunakan adalah "kolaborasi", "rujuk", "konsultasikan".

4. Penentuan Intervensi Keperawatan

Penentuan intervensi keperawatan berdasarkan pilihan tindakan yang sesuai yaitu menuliskan label intervensi sesuai dengan standar; tindakan dapat ditambah, dikurangi atau dimodifikasi, tulis tindakan secara sistematis (urutan OTEK). Pada konteks gawat darurat dan/atau kritis, maka gunakan pemilihan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien dan karakteristik pasien gawat

darurat, kemudian pilihlah tindakan prioritas untuk menyelamatkan nyawa dan menstabilkan kondisi pasien.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan perawat dalam menentukan intervensi keperawatan (DeLaune & Ladner, 2011; Gordon, 1994; Potter & Perry, 2013) :

a. Karakteristik diagnosis keperawatan

Merupakan elemen penting dalam proses keperawatan yang membantu perawat merumuskan intervensi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan klien. Apabila penyebabnya tidak dapat diatasi secara langsung (misalnya penyakit kronis atau terminal), maka intervensi keperawatan difokuskan pada pengelolaan tanda/gejala, seperti mengelola gejala seperti meningkatkan kenyamanan, mendukung adaptasi klien terhadap kondisi dan memberikan dukungan psikososial kepada klien dan keluarga. Diagnosis risiko berfokus pada menghilangkan faktor risiko.

b. Outcome yang diharapkan

merupakan hasil akhir yang diharapkan tercapai setelah implementasi dilakukan. Outcome ini memberikan arahan yang jelas bagi perawat dalam merencanakan dan menentukan Langkah-langkah intervensi yang sesuai untuk mencapai tujuan.

c. Kemampulaksanaan Intervensi Keperawatan

Perawat merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan dengan melihat waktu, tenaga dan sumber daya manusia yang tersedia untuk memastikan bahwa intervensi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

1) Kemampuan perawat

Perawat harus memiliki pengetahuan ilmiah dasar untuk menerapkan intervensi dan memiliki keterampilan psikomotorik yang diperlukan untuk melaksanakan Tindakan yang akurat.

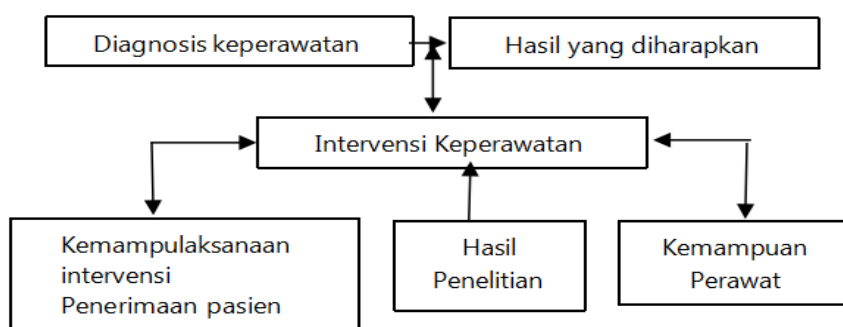
2) Penerimaan pasien

Intervensi yang dipilih sangat dipengaruhi nilai, keyakinan, serta budaya yang dianut pasien, sehingga, klien lebih koooperatif, menghargai dan diterima dengan baik.

3) Hasil penelitian

Pelaksanaan intervensi keperawatan didasarkan pada bukti penelitian yang menunjukkan efektivitas intervensi terhadap klien. Jika belum tersedia bukti penelitian, perawat dapat mengandalkan prinsip ilmiah dasar, melakukan konsultasi dengan ahli atau dari perawat spesialis, mengacu pada pedoman klinis serta mengevaluasi efek/respon dari intervensi untuk menentukan pilihan intervensi yang tepat.

Untuk memudahkan, faktor penentuan dalam intervensi keperawatan berikut gambaran skema 4.1



Gambar 4.1 Faktor Penentuan Intervensi Keperawatan
Sumber: (DeLaune & Ladner, 2011; Gordon, 1994; Potter & Perry, 2013)

Setelah dilakukan penentuan intervensi keperawatan, perawat selanjutnya melakukan implementasi keperawatan, yaitu sebuah fase dimana perawat melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya (Kozier, Erb, Berman & Synder, 2011). Tahapan pelaksanaan terdiri dari tindakan mandiri dan kolaborasi yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi coping, supaya kondisi pasien cepat membaik, perawat perlu bekerjasama dengan keluarga dalam melaksanakan tercapainya tujuan dan kriteria hasil yang sudah dibuat dalam intervensi (Nursalam, 2016). Setelah dilakukan implementasi keperawatan, fase akhir dalam proses keperawatan adalah evaluasi keperawatan, baik berupa evaluasi formatif atau sumatif. Evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif, yaitu dilakukan setelah program selesai dan mendapatkan informasi efektifitas dalam pengambilan keputusan (Deswani, 2011). Evaluasi keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (Subyektif, Obyektif, Assessment, Planning). Subyektif Dimana perawat mendapatkan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan; Obyektif, data yang berdasarkan hasil observasi/pengukuran perawat secara langsung kepada pasien dan yang dirasakan pasien setelah diberikan tindakan keperawatan; Assessment, interpretasi dari data subyektif dan obyektif; Planning, perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.2 Perencanaan dalam Keperawatan Gerontik (SIKI & SLKI)

No	Diagnosis Keperawatan (SDKI)	PERENCANAAN	
		Luaran Keperawatan (SLKI)	Intervensi (SIKI)
1	Risiko Jatuh, dd. Factor risiko : Usia, Riwayat Jatuh, dan kekuatan otot menurun	L.14138 Setelah dilakukan keperawatan selama 1 X 24 jam, tingkat jatuh dengan ekspektasi menurun, dg kriteria hasil : Jatuh saat berdiri menurun (5) Jatuh saat berjalan menurun (5) Jatuh saat duduk menurun (5)	Intervensi Utama : Pencegahan Jatuh I.14540 O. 1) Identifikasi faktor risiko jatuh. 2) Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. T. 1) Gunakan alat bantu berjalan. 2) Orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga. E.1) Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. 2) Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah.
2	Gangguan Mobilitas Fisik bd, kerusakan integritas struktur tulang dan ketidakbugaran fisik dd. Mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas, kekuatan otot menurun, dan rentang gerak (ROM) menurun	L. 05042 Setelah dilakukan keperawatan selama 2 X 24 jam, gangguan mobilitas dengan ekspektasi meningkat, dg kriteria hasil : Pergerakan ekstremitas meningkat (5) Kekuatan otot meningkat (5) Rentang gerak sendi (ROM) meningkat (5)	Intervensi Utama : Dukungan Ambulasi I.06171 O. 1). Identifikasi adanya nyeri atau keluhan lainnya. 2). Identifikasi toleransi fisik melalui ambulasi. T. 1). Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. 2). Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik. E. 1). Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. 2). Anjurkan melakukan ambulasi dini.

3	Defisit perawatan diri (Mandi) bd, gangguan neuromuskuler dan ganggaun muskuluskuletal dd, menolak melakukan perawatan diri, tidak mampu mandi dan minat melakukan perawatan diri kurang	L.11103 Setelah dilakukan keperawatan selama 1 X 24 jam, Perawatan Diri dengan ekspektasi Meningkat, dg kriteria hasil : Kemampuan mandi meningkat (5) Minat melakukan perawatan diri meningkat (5) Verbarlisasi keinginan melakukan perawatan diri meningkat (5)	Intervensi Utama : Dukungan Perawatan Mandi : Mandi I.11352 O. 1). Monitor kebersihan tubuh. 2). Monitor integritas kulit. T. 1). Berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian. 2). Sediakan perawatan mandi. E. 1). Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi thd kes. 2). Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien jika perlu.
4	Nyeri Kronis bd, Kondisi muskuloskuletal kronis dan kerusakan system syaraf dd, mengeluh nyeri, merasa depresi (Tertekan), tampak meringis, gelisah, dan tidak mampu menuntaskan aktivitas.	L.08066 Setelah dilakukan keperawatan selama 2 X 24 jam, tingkat Nyeri dengan ekspektasi menurun, dg kriteria hasil : Keluhan nyeri menurun (5) Perasaan depresi (Tertekan) menurun (5) Meringis menurun (5) Gelisah menurun (5) Kemampuan menuntaskan aktivitas menurun (5)	Intervensi Utama : Manajemen Nyeri I.08238 O. 1). Identifikasi skala nyeri. 2). Identifikasi respon nyeri non verbal. T. 1). Menfasilitasi istirahat dan tidur. 2). Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri E. 1). Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. 2). Jelaskan strategi meredakan nyeri. K. 1). Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu.

5	Gangguan Pola Tidur bd , Kurang control tidur, hambatan lingkungan (Mis. Kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, dan kebisingan) dd , mengeluh sulit tidur, mengeluh tidur tidak puas dan mengeluh pola tidur berubah.	L.05045 Setelah dilakukan keperawatan selama 1 X 24 jam, Pola Tidur dengan ekspektasi membaik, dg kriteria hasil : Keluhan sulit tidur menurun (5) Keluhan pola tidur berubah menurun (5)	Intervensi Utama : Dukungan Tidur I.05174 O. 1). Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 2). Identifikasi faktor pengganggu tidur. T. 1). Modifikasi lingkungan. 2). Batasi waktu tidur siang. E. 1). Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. 2). Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur.
6	Risiko Gangguan Integritas Kulit dd , perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi (Kekurangan) dan Kekurangan cairan	L.14125 Setelah dilakukan keperawatan selama 1 X 24 jam, Integritas Kulit dan Jaringan dengan ekspektasi meningkat, dg kriteria hasil : Kerusakan kulit menurun (5) Suhu kulit mendekati normal (5)	Intervensi Utama : Perawatan Integritas Kulit I.11353 O. 1). Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit T. 1). Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring 2). Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang. E. 1). Anjurkan minum air yang cukup. 2). Anjurkan menggunakan pelembab.
7	Intoleransi Aktivitas bd , Ketidakseimbangan antara suplai dan Kebutuhan oksigen, tirah baring dan kelemahan dd , mengeluh lelah dan	L.05047 Setelah dilakukan keperawatan selama 2 X 24 jam, toleransi aktivitas dengan ekspektasi meningkat, dg kriteria hasil :	Intervensi Utama : Manajemen Energi I.05178 O. 1). Monitor pola dan jam tidur. 2). Monitor kelelahan fisik dan emosional.

	frekuensi jantung >20% dari kondisi istirahat	Keluhan lelah menurun (5) Iskemik pada EKG menurun (5)	T. 1). Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. 2). Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. E. 1). Anjurkan tirah baring. 2). Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. K. 1). Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.
8	Risiko Defisit Nutrisi dd , Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient, ketidakmampuan menelan makanan dan ketidakmampuan mencerna makanan.	L.03030 Setelah dilakukan perawatan selama 2 X 24 jam, status nutrisi dengan ekspektasi membaik, dg kriteria hasil : Kekuatan otot menelan Meningkat (5), Berat badan meningkat (5)	Intervensi Utama : Manajemen Nutrisi I.03119 O. 1). Identifikasi status nutrisi. 2). Monitor berat badan. T. 1). Berikan suplemen makanan. 2). Lakukan oral hygiene sebelum makan. E. 1). Anjurkan posisi duduk jika mampu. 2). Ajarkan diet yang di programkan K. 1). Pemberian medikasi sebelum makan. 2). Kolaborasi dgn ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan.
9	Isolasi Sosial bd , Keterlambatan perkembangan dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan	L.13116 Setelah dilakukan perawatan selama 2 X 24 jam, Keterlibatan sosial dengan ekspektasi	Intervensi Utama : Promosi Sosialisasi I.13498

	dd, Merasa ingin sendirian, merasa tidak aman ditempat umum, menarik diri dan tidak berminat atau menolak berinteraksi dgn org lain / lingkungan.	meningkat, dg kriteria hasil : Verbalisasi ketidakamanan ditempat umum menurun (5) Minat interaksi meningkat (5) Perilaku menarik diri menurun (5)	O. 1). Identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan org lain. 2). Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan org lain. T. 1). Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan. 2.). Motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan E.1). Anjurkan berinteraksi dengan orang lain 2). Anjurkan ikut serta kegiatan social dan kemasyarakatan
10	Risiko Infeksi dd, Penyakit kronis (Mis. Diabetes mellitus), efek prosedur invasif dan malnutrisi.	L.14137 Setelah dilakukan keperawatan selama 2 X 24 jam, tingkat infeksi dengan ekspektasi menurun, dg kriteria hasil : Bengkak menurun (5) Nyeri menurun (5)	Intervensi Utama : Manajemen Imunisasi / Vaksinasi I.14508 O. 1). Identifikasi riwayat kes. dan riwayat alergi. 2). Identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi. T. 1). Berikan suntikan pada bayi dibagian paha anterolateral. 2). Dokumentasikan informasi vaksinasi. E. 1). Jelaskan tujuan manfaat reaksi yang terjadi, jadwal dan efek samping. 2). Informasikan vaksinasi untuk kejadian khusus.

Desain Asesmen Berdasarkan Piramida Miller

LEVEL 1 – KNOWS (Pengetahuan)

Fokus: Mengingat konsep dasar

Bentuk : MCQ

Indikator:

- Definisi diagnosis keperawatan gerontik
- Komponen SDKI–SLKI–SIKI
- Prinsip evidence-based nursing
- Kriteria tujuan SMART

Soal Level KNOWS

1. Diagnosis keperawatan adalah...
 - A. Tindakan medis untuk pasien
 - B. Keputusan klinis tentang respon individu terhadap masalah kesehatan
 - C. Rencana pengobatan dokter
 - D. Hasil pemeriksaan laboratorium
 - E. Tindakan rehabilitasi
2. Komponen SLKI digunakan untuk...
 - A. Menentukan diagnosis
 - B. Menentukan intervensi
 - C. Menentukan luaran keperawatan
 - D. Menentukan terapi obat
 - E. Menentukan biaya
3. Tujuan keperawatan yang baik harus memenuhi kriteria SMART, kecuali...
 - A. Specific
 - B. Measurable
 - C. Achievable
 - D. Random
 - E. Time-bound

LEVEL 2 – KNOWS HOW (Aplikasi & Analisis)

Fokus: Mampu menerapkan konsep pada kasus

Bentuk: MCQ berbasis kasus

Indikator:

- Menentukan diagnosis keperawatan gerontik
- Menyusun tujuan SMART
- Memilih intervensi berbasis evidence

Soal Level KNOWS HOW

4. Seorang lansia mengalami kelemahan, sering jatuh, dan kesulitan berjalan. Diagnosis keperawatan yang paling tepat adalah...
 - A. Gangguan nutrisi
 - B. Risiko infeksi
 - C. Risiko jatuh
 - D. Gangguan tidur
 - E. Nyeri akut
5. Tujuan keperawatan yang tepat untuk kasus risiko jatuh adalah...
 - A. Pasien tidak jatuh
 - B. Pasien memahami bahaya jatuh
 - C. Pasien menunjukkan peningkatan keseimbangan dalam 3 hari
 - D. Pasien dirawat di rumah sakit
 - E. Pasien diberikan obat
6. Intervensi berbasis evidence untuk mencegah jatuh pada lansia adalah...
 - A. Istirahat total
 - B. Pembatasan aktivitas
 - C. Latihan keseimbangan dan modifikasi lingkungan
 - D. Pemberian antibiotic
 - E. Isolasi pasien

LEVEL 3 – SHOWS HOW (Demonstrasi)

Fokus: Menunjukkan kemampuan klinis (simulasi)

Bentuk: OSCE / vignette analitik

Indikator:

- Menyusun diagnosis lengkap (problem–etiologi–symptom)
- Menyusun tujuan SMART
- Menentukan intervensi sesuai SDKI–SLKI–SIKI

Soal Level SHOWS HOW

7. Seorang lansia mengeluh sulit tidur, sering terbangun, dan tampak lelah. Diagnosis yang tepat adalah...
 - A. Insomnia
 - B. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan ditandai sering terbangun
 - C. Kurang istirahat
 - D. Risiko stress
 - E. Kelelahan
8. Tujuan SMART yang paling tepat adalah...
 - A. Pasien tidur nyenyak

- B. Pasien merasa lebih baik
 - C. Pasien mampu tidur 6–8 jam per malam dalam 5 hari
 - D. Pasien tidak lelah
 - E. Pasien dirawat
9. Intervensi keperawatan yang tepat adalah...
- A. Memberikan obat tidur langsung
 - B. Edukasi sleep hygiene dan relaksasi
 - C. Membatasi makan
 - D. Isolasi pasien
 - E. Tidak melakukan apa-apa

LEVEL 4 – DOES (Praktik Nyata)

Fokus: Kinerja nyata di praktik klinik

Bentuk: Mini-CEX / evaluasi berbasis kasus nyata

Indikator:

- Implementasi diagnosis keperawatan
- Evaluasi hasil (SLKI)
- Penyesuaian intervensi berbasis evidence

Soal Level DOES

10. Dalam praktik, perawat mengevaluasi bahwa lansia masih sering jatuh meskipun sudah diberi edukasi. Tindakan selanjutnya adalah...
- A. Menghentikan intervensi
 - B. Mengabaikan kondisi
 - C. Memodifikasi rencana intervensi berbasis evaluasi
 - D. Menyerahkan ke dokter
 - E. Menyalahkan keluarga
11. Perawat melakukan monitoring tekanan darah dan keseimbangan lansia secara berkala. Hal ini merupakan bagian dari...
- A. Diagnosis
 - B. Implementasi
 - C. Evaluasi
 - D. Pengkajian
 - E. Edukasi
12. Perawat melibatkan keluarga dalam perawatan lansia di rumah. Ini termasuk prinsip...
- B. Kuratif
 - C. Individualistik
 - D. Family-centered care
 - E. Isolasi

F. Medikalisasi

Ringkasan Pemetaan Miller

Level	Fokus	No Soal
Knows	Pengetahuan	1–3
Knows How	Aplikasi	4–6
Shows How	Demonstrasi	7–9
Does	Praktik nyata	10–12

Catatan: Asesmen ini sudah mencakup :

1. Diagnosis keperawatan gerontik
2. Penyusunan tujuan SMART
3. Evidence-based nursing
4. Integrasi SDKI–SLKI–SIKI
5. Pendekatan family-cent

Paket Osce Gerontik (3 Station)

STATION 1: RISIKO JATUH PADA LANSIA

1. Tujuan: Mahasiswa mampu:
 - a. Mengkaji faktor risiko jatuh
 - b. Menetapkan diagnosis keperawatan
 - c. Memberikan edukasi pencegahan jatuh
2. Waktu: 10 menit (2 menit baca, 8 menit praktik)
3. Skenario: Seorang lansia (70 tahun) sering merasa pusing, berjalan tidak stabil, dan pernah jatuh di kamar mandi. Rumah memiliki pencahayaan kurang dan lantai licin.
4. Tugas Mahasiswa
 - a. Lakukan komunikasi terapeutik
 - b. Identifikasi faktor risiko jatuh
 - c. Tentukan diagnosis keperawatan
 - d. Berikan edukasi pencegahan jatuh
5. Checklist Penilaian
 - a. Komunikasi (0–2 tiap item)
 - 1) Salam & pengenalan
 - 2) Empati
 - 3) Bahasa mudah
 - b. Pengkajian
 - 1) Riwayat jatuh

- 2) Keseimbangan/gaya berjalan
 - 3) Lingkungan rumah
 - c. Diagnosis
 - 1) Risiko jatuh (tepat)
 - 2) Alasan logis
 - d. Edukasi Preventif
 - 1) Modifikasi lingkungan (lampu, pegangan)
 - 2) Alas kaki aman
 - 3) Latihan keseimbangan
 - e. Penutup
 - 1) Ringkasan
 - 2) Kesempatan bertanya
- Skor maksimal: 40

STATION 2: DEMENSIA

1. Tujuan: Mahasiswa mampu:

- a. Mengkaji gangguan kognitif
- b. Menetapkan diagnosis keperawatan
- c. Memberikan edukasi pada keluarga

2. **Skenario: Lansia** (75 tahun) sering lupa, bingung waktu dan tempat, serta mengulang pertanyaan. Keluarga merasa kesulitan merawat.

3. Tugas Mahasiswa

- a. Bangun komunikasi terapeutik
- b. Identifikasi gangguan kognitif
- c. Tentukan diagnosis
- d. Edukasi keluarga

4. Checklist Penilaian

- a. Komunikasi
 - 1) Sabar & empatik
 - 2) Tidak menghakimi
- b. Pengkajian
 - 1) Orientasi (waktu, tempat, orang)
 - 2) Memori
 - 3) Perilaku
- c. Diagnosis
 - 1) Gangguan memori/kognitif
 - 2) Sesuai data

- d. Edukasi
 - 1) Stimulasi kognitif
 - 2) Rutinitas harian
 - 3) Keamanan pasien
 - e. Pemberdayaan keluarga
 - 1) Libatkan caregiver
 - 2) Dukungan emosional
- Skor maksimal: 40

STATION 3: INKONTINENSIA URIN

1. Tujuan: Mahasiswa mampu:

- a. Mengkaji pola eliminasi
- b. Menentukan diagnosis
- c. Memberikan intervensi

2. Skenario: Lansia (68 tahun) mengeluh sering tidak bisa menahan BAK, terutama saat batuk/bersin. Mengurangi aktivitas sosial karena malu.

3. Tugas Mahasiswa

- a. Lakukan komunikasi terapeutik
- b. Kaji masalah eliminasi
- c. Tentukan diagnosis
- d. Berikan intervensi

4. Checklist Penilaian

- a. Komunikasi
 - 1) Menjaga privasi
 - 2) Empati
- b. Pengkajian
 - 1) Frekuensi BAK
 - 2) Pencetus (batuk/aktivitas)
 - 3) Dampak psikologis
- c. Diagnosis: Inkontinensia urin (tepat)
- d. Intervensi
 - 1) Latihan Kegel
 - 2) Bladder training
 - 3) Edukasi cairan
- e. Edukasi & dukungan
 - 1) Mengurangi stigma
 - 2) Motivasi pasien

Skor maksimal: 40

REKAP PENILAIAN OSCE

Station	Skor Maks	Skor Diperoleh
Risiko Jatuh	40	
Demensia	40	
Inkontinensia	40	
TOTAL	120	

Nilai akhir = (Total/120) × 100

KRITERIA KELULUSAN

Nilai	Kategori
≥ 80	Kompeten
70–79	Cukup
< 70	Belum kompeten

Keunggulan paket OSCE adalah sbb:

- Berbasis **kasus nyata gerontik**
- Mengukur level **Shows How (Miller)**
- Terintegrasi **SDKI–SLKI–SIKI**
- Menilai **komunikasi, clinical reasoning, edukasi**
- Siap untuk **ujian OSCE / akreditasi LAM-PTKes**

N. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 77 tahun dirawat di rumah setelah mengalami stroke dua bulan yang lalu. Hasil anamnesis: pasien mengeluh sulit menggerakkan tangan dan kaki kiri serta membutuhkan bantuan saat berpindah dari tempat tidur ke kursi. Hasil pengkajian: kekuatan otot ekstremitas kiri 2/5, rentang gerak sendi menurun, gerakan tampak terbatas, tekanan darah 140/86 mmHg, dan nadi 82 kali/menit.

Apakah diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Risiko jatuh
- B. Gangguan mobilitas fisik
- C. Intoleransi aktivitas
- D. Defisit perawatan diri mandi
- E. Nyeri kronis

Kunci Jawaban: B. Gangguan mobilitas fisik

Rasional:

Diagnosis gangguan mobilitas fisik sesuai dengan data pasien yang mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, mengalami penurunan kekuatan otot, dan

penurunan rentang gerak sendi. Data subjektif dan objektif tersebut menunjukkan bahwa masalah sudah terjadi sehingga termasuk diagnosis aktual. Dalam naskah, gejala mayor gangguan mobilitas fisik meliputi keluhan sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, dan rentang gerak atau ROM menurun.

2. Seorang perempuan berusia 82 tahun tinggal bersama anaknya. Hasil anamnesis: pasien mengatakan pernah terjatuh dua kali dalam enam bulan terakhir dan merasa kedua tungkainya semakin lemah. Hasil pengkajian: kekuatan otot ekstremitas bawah 3/5, gaya berjalan tidak stabil, lantai kamar mandi licin, pencahayaan menuju kamar mandi kurang, tetapi saat ini tidak ditemukan luka atau cedera akibat jatuh.

Apakah rumusan diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Risiko jatuh berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan pernah jatuh dua kali
- B. Risiko jatuh dibuktikan dengan usia lanjut, riwayat jatuh, dan kekuatan otot menurun
- C. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan usia lanjut dibuktikan dengan lantai licin
- D. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan riwayat jatuh dibuktikan dengan gaya berjalan tidak stabil
- E. Risiko cedera berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan tidak terdapat luka

Kunci Jawaban: B. Risiko jatuh dibuktikan dengan usia lanjut, riwayat jatuh, dan kekuatan otot menurun

Rasional:

Diagnosis risiko menggambarkan masalah kesehatan yang berpotensi terjadi karena adanya faktor risiko, meskipun tanda dan gejala masalah tersebut belum muncul. Pada kasus ini, pasien belum mengalami cedera, tetapi memiliki usia lanjut, riwayat jatuh, kekuatan otot menurun, gaya berjalan tidak stabil, serta lingkungan yang tidak aman. Data tersebut mendukung diagnosis risiko jatuh.

3. Seorang perempuan berusia 73 tahun dengan osteoarthritis lutut menjalani perawatan di puskesmas. Hasil anamnesis: pasien mengeluh nyeri pada kedua lutut sejak satu tahun terakhir, terutama ketika berjalan dan menaiki tangga. Nyeri menyebabkan pasien tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah. Hasil pengkajian: skala nyeri 6, pasien tampak meringis, gelisah, sering memegang lutut, dan pergerakannya terbatas.

Apakah rumusan diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis dibuktikan dengan keluhan nyeri, meringis, gelisah, dan tidak mampu menuntaskan aktivitas
- B. Osteoarthritis berhubungan dengan usia lanjut dibuktikan dengan nyeri pada kedua lutut
- C. Risiko nyeri kronis dibuktikan dengan osteoarthritis dan usia lanjut
- D. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dibuktikan dengan osteoarthritis
- E. Nyeri akut berhubungan dengan cedera jaringan dibuktikan dengan nyeri selama satu tahun

Kunci Jawaban: A. Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis dibuktikan dengan keluhan nyeri, meringis, gelisah, dan tidak mampu menuntaskan aktivitas

Rasional:

Pasien mengalami nyeri selama satu tahun yang berkaitan dengan kondisi muskuloskeletal kronis. Keluhan nyeri disertai data objektif berupa meringis, gelisah, dan ketidakmampuan menyelesaikan aktivitas. Data tersebut sesuai dengan indikator diagnosis nyeri kronis dalam naskah.

4. Seorang laki-laki berusia 75 tahun dirawat di ruang geriatri. Hasil anamnesis: pasien mengeluh sulit mulai tidur, sering terbangun pada malam hari, dan merasa tidurnya tidak memuaskan sejak dirawat. Pasien mengatakan suara percakapan petugas dan cahaya dari lorong mengganggu tidurnya. Hasil pengkajian: pasien tampak mengantuk pada pagi hari, sering menguap, dan tidur siang selama tiga jam.

Apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengidentifikasi pola tidur dan faktor pengganggu, memodifikasi lingkungan, membatasi tidur siang, serta menganjurkan kebiasaan waktu tidur
- B. Mengidentifikasi risiko jatuh, menyediakan alat bantu jalan, dan memasang pegangan di kamar mandi
- C. Memantau kelelahan, menganjurkan tirah baring, dan melakukan latihan rentang gerak
- D. Mengidentifikasi skala nyeri, memfasilitasi istirahat, dan berkolaborasi memberikan analgesik
- E. Mengidentifikasi hambatan interaksi dan menganjurkan mengikuti kegiatan sosial

Kunci Jawaban: A. Mengidentifikasi pola tidur dan faktor pengganggu, memodifikasi lingkungan, membatasi tidur siang, serta menganjurkan kebiasaan waktu tidur

Rasional:

Keluhan sulit tidur, sering terbangun, tidur tidak puas, dan perubahan pola tidur menunjukkan gangguan pola tidur. Faktor pengganggu yang ditemukan adalah kebisingan, cahaya, dan durasi tidur siang yang panjang. Intervensi utama yang sesuai adalah dukungan tidur, meliputi identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu, modifikasi lingkungan, pembatasan waktu tidur siang, serta anjuran mempertahankan kebiasaan waktu tidur.

5. Seorang perempuan berusia 80 tahun dirawat di rumah setelah mengalami stroke. Hasil anamnesis: keluarga mengatakan pasien lebih banyak berbaring dan hanya berpindah posisi ketika dimandikan. Asupan makan dan minum pasien menurun. Hasil pengkajian: pasien tidak mampu mengubah posisi secara mandiri, kulit tampak kering, sirkulasi perifer menurun, berat badan berkurang, tetapi belum ditemukan luka atau kerusakan kulit.

Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Mengubah posisi setiap dua jam, memantau kondisi kulit, menganjurkan asupan cairan yang cukup, dan menggunakan pelembap
- B. Mempertahankan posisi telentang agar pasien dapat beristirahat secara optimal
- C. Membatasi asupan cairan untuk mengurangi frekuensi berkemih
- D. Membersihkan kulit menggunakan alkohol setiap dua jam
- E. Menunggu sampai luka muncul sebelum melakukan perawatan kulit

Kunci Jawaban: A. Mengubah posisi setiap dua jam, memantau kondisi kulit, menganjurkan asupan cairan yang cukup, dan menggunakan pelembap

Rasional:

Pasien memiliki faktor risiko gangguan integritas kulit berupa imobilitas, perubahan sirkulasi, penurunan status nutrisi, kekurangan cairan, dan kulit kering. Karena belum terdapat kerusakan kulit, tindakan ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor risiko. Intervensi perawatan integritas kulit dalam naskah meliputi identifikasi penyebab, perubahan posisi setiap dua jam pada pasien tirah baring, pemenuhan cairan yang cukup, dan penggunaan pelembap.

O. Ringkasan

Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan atau penilaian klinis yang ditetapkan perawat berdasarkan hasil pengkajian untuk menggambarkan respons

individu, keluarga, maupun komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialami. Pada lanjut usia, penetapan diagnosis memerlukan pengkajian yang komprehensif karena proses penuaan, penurunan fungsi fisiologis, penyakit kronis multipel, serta perubahan psikologis, sosial, dan spiritual dapat saling memengaruhi. Penggunaan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) membantu perawat menetapkan diagnosis secara sistematis, konsisten, dan menggunakan terminologi yang terstandar sehingga mendukung komunikasi antarprofesi, ketepatan pengambilan keputusan klinis, serta peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan keperawatan.

Penegakan diagnosis keperawatan dilakukan melalui tahapan analisis data, pengelompokan data subjektif dan objektif, identifikasi masalah, validasi data bersama klien, serta perumusan diagnosis. Diagnosis aktual dirumuskan dalam tiga bagian yang mencakup masalah, penyebab, serta tanda dan gejala, sedangkan diagnosis risiko dan promosi kesehatan dirumuskan dalam dua bagian. Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan masalah yang mengancam kehidupan, keselamatan klien, kebutuhan dan pilihan klien, serta masalah yang apabila ditangani dapat membantu mengatasi diagnosis lainnya.

Diagnosis yang tepat menjadi landasan dalam menentukan luaran dan intervensi keperawatan. Integrasi SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) memungkinkan perawat menyusun asuhan yang terarah, terukur, aman, efektif, serta sesuai dengan kondisi individual lansia. Tindakan keperawatan disusun melalui komponen observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan mempertimbangkan karakteristik diagnosis, luaran yang diharapkan, kemampuan perawat, penerimaan pasien, ketersediaan sumber daya, serta bukti penelitian.

Pelaksanaan intervensi harus diikuti dengan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai pencapaian luaran dan menentukan apakah rencana asuhan perlu dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah. Dokumentasi evaluasi melalui format SOAP membantu menjaga kesinambungan pelayanan dan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Dengan demikian, kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, luaran, intervensi, implementasi, dan evaluasi merupakan kompetensi penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik yang profesional, holistik, berpusat pada lansia dan keluarga, serta berorientasi pada pemeliharaan fungsi, pencegahan komplikasi, peningkatan kemandirian, dan kualitas hidup lansia.

P. Daftar Pustaka

- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik. Jakarta: Dewan Pengurus PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2017). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: Dewan Pengurus PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2017). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: Dewan Pengurus PPNI
- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). Community and public health nursing: Promoting the public's health (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). Family nursing: Research, theory, and practice (5th ed.). Pearson Education.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). Family health care nursing: Theory, practice, and research (6th ed.). F.A. Davis Company.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelayanan keperawatan keluarga. Jakarta: Kemenkes RI.
- Orem, D. E. (2001). Nursing: Concepts of practice (6th ed.). Mosby.
- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2015). Health promotion in nursing practice (7th ed.). Pearson.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier.
- Roy, C., & Andrews, H. A. (2009). The Roy adaptation model (3rd ed.). Pearson.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). Public health nursing: Population-centered health care in the community (10th ed.). Elsevier.
- Azis Alimul H.A, Pengantar Dokumentasi Proses Keperawatan. Jakarta, EGC 2002
- Dinarti, Kerangka Waktu Dalam Dokumentasi Proses Keperawatan. Disampaikan dalam Pelatihan Dokumentasi

- Nursalam, Proses dan Dokumentasi Keperawatan Konsep dan Praktik, Jakarta, Salemba Medika 2001
- Standar Praktik Keperawatan Indonesia (PPNI, 2005); International Classification of Nursing Practice – Diagnosis Classification (ICNP, 2015)
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). ANA Publishing.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023*. Thieme.
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2018). *Nursing outcomes classification (NOC)* (6th ed.). Elsevier.
- Nasrullah, D. (2016). *Buku ajar keperawatan gerontik dengan pendekatan asuhan keperawatan NANDA–NIC–NOC*. UMSurabaya Publishing. ([UMSURA Repository](#))
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Smeltzer, S., Bare, B., Hinkle, J., & Cheever, K. (2020). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier.

BAB 4

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DENGAN LANSIA & KELUARGA (KULTURAL DAN EMPATIK)

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu-keselamatan pasien, dokumentasi, dan <i>continuity of care</i> dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, <i>frailty</i> , dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, <i>continuity of care</i> , serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia & Keluarga (kultural dan empatik)	6.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada lansia secara empatik dan adaptif terhadap keterbatasan sensori/kognitif.	6.2 Merancang edukasi kesehatan dan <i>counseling</i> keluarga dengan pendekatan <i>cultural</i> , <i>health literacy</i> , dan <i>shared decision-making</i> .	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-2

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE/ <i>role play</i> komunikasi; penugasan materi edukasi	Keterampilan komunikasi (empati, klaritas, validasi, adaptasi sensori/kognitif) minimal "baik" pada ≥4 komponen; materi edukasi sesuai <i>health literacy</i> dan budaya (≥2 strategi adaptasi)	10	Video/lembar observasi OSCE; <i>leaflet/outline</i> edukasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Keterampilan komunikasi terapeutik dengan lansia	Tidak empatik; komunikasi tidak jelas; tidak adaptif	Empati ada namun kurang konsisten; adaptasi terbatas	Empatik, jelas, adaptif; membangun hubungan dan validasi	Sangat empatik; responsif; mengelola hambatan sensorik/kognitif secara efektif
5.2 Kualitas edukasi & kolaborasi dengan keluarga	Materi tidak sesuai kebutuhan/kemampuan; tanpa tindak lanjut	Materi cukup sesuai; strategi adaptasi minim	Materi sesuai; adaptif budaya & literasi; ada rencana tindak lanjut	Sangat sesuai; melibatkan keluarga; strategi adaptasi kuat; evaluasi pemahaman jelas

Uraian Materi

Peningkatan jumlah lansia merupakan fenomena global yang berdampak pada sistem pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan gerontik. Lansia memiliki karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda dibanding kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang digunakan perawat tidak dapat disamakan dengan komunikasi pada pasien dewasa muda.

Komunikasi terapeutik menjadi kompetensi inti dalam asuhan keperawatan gerontik karena melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat membangun hubungan saling percaya, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan terapi, serta memperkuat kualitas hidup lansia.

Menurut Hildegard Peplau dalam bukunya *Interpersonal Relations in Nursing* (1952), hubungan interpersonal antara perawat dan pasien merupakan inti praktik keperawatan. Hubungan tersebut bersifat terapeutik jika dilakukan secara sadar, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Pendekatan ini diperkuat oleh Joyce Travelbee (tahun 1971) yang menekankan pentingnya hubungan “human-to-human” dalam membantu pasien menemukan makna dari pengalaman sakit.

Pada lansia, komunikasi terapeutik harus dikembangkan dengan dua landasan utama: yaitu empati dan sensitivitas budaya (kultural).

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip komunikasi terapeutik pada lansia serta mampu menerapkan pendekatan komunikasi yang empatik dan sensitif terhadap budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada lansia dan keluarganya secara profesional dan etis.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan gerontik.
2. Menguraikan tujuan dan manfaat komunikasi terapeutik pada lansia.
3. Menjelaskan tahapan atau fase komunikasi terapeutik dalam hubungan perawat dengan pasien lansia.
4. Mengidentifikasi perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial pada lansia yang mempengaruhi proses komunikasi.
5. Menjelaskan konsep empati dalam komunikasi terapeutik dengan lansia.
6. Mengidentifikasi berbagai teknik komunikasi empatik yang dapat digunakan dalam interaksi dengan lansia.
7. Menjelaskan konsep komunikasi kultural dalam pelayanan keperawatan.

8. Menguraikan peran nilai budaya, keyakinan, dan struktur keluarga dalam proses komunikasi dengan lansia.
9. Menjelaskan peran keluarga dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan terkait perawatan lansia.
10. Menganalisis hambatan yang dapat terjadi dalam komunikasi terapeutik dengan lansia dan keluarganya.
11. Menerapkan prinsip komunikasi terapeutik yang empatik dan sensitif budaya dalam situasi klinis keperawatan gerontik.

Capaian Pembelajaran

Kognitif

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan gerontik.

Afektif

Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, empatik, dan menghargai nilai budaya dalam berkomunikasi dengan lansia dan keluarganya.

Psikomotor

Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi terapeutik secara efektif dalam praktik keperawatan gerontik.

A. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Gerontik

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan antara dua orang atau lebih melalui pesan verbal maupun nonverbal. Dalam praktik keperawatan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena melalui komunikasi yang efektif perawat dapat membangun hubungan terapeutik dengan pasien serta membantu pasien memahami kondisi kesehatannya (Arnold & Boggs, 2019).

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan untuk membantu pasien mencapai kesejahteraan fisik maupun psikologis. Menurut Peplau (1952), komunikasi terapeutik merupakan bagian integral dari hubungan interpersonal antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien melalui interaksi yang profesional dan bermakna. Hubungan interpersonal ini menjadi dasar bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif.

Dalam keperawatan gerontik, komunikasi terapeutik memiliki peran yang sangat penting karena lansia sering mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Perubahan tersebut dapat berupa penurunan fungsi sensorik, perubahan kondisi psikologis, serta perubahan dalam peran sosial (Eliopoulos, 2020). Oleh karena itu, perawat perlu memiliki keterampilan komunikasi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lansia.

Komunikasi terapeutik yang efektif dapat membantu lansia merasa dihargai, dipahami, dan didukung dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi pada masa lanjut usia. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan lansia terhadap perawat sehingga proses perawatan dapat berjalan lebih optimal (Arnold & Boggs, 2019).

B. Tujuan dan Manfaat Komunikasi Terapeutik pada Lansia

Komunikasi terapeutik memiliki berbagai tujuan dalam praktik keperawatan gerontik. Salah satu tujuan utama komunikasi terapeutik adalah membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Hubungan yang didasarkan pada rasa percaya akan memudahkan pasien untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, serta masalah yang mereka alami (Peplau, 1952).

Selain itu, komunikasi terapeutik juga bertujuan untuk membantu lansia memahami kondisi kesehatan yang mereka alami. Lansia yang mendapatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses perawatan serta mengambil keputusan terkait kesehatannya (Arnold & Boggs, 2019).

Komunikasi terapeutik juga berperan dalam membantu lansia beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi akibat proses penuaan. Lansia sering menghadapi perubahan fisik, kehilangan peran sosial, maupun kehilangan orang yang dicintai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan sedih, cemas, atau kesepian. Melalui komunikasi yang empatik, perawat dapat membantu lansia mengatasi perasaan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Eliopoulos, 2020).

Selain memberikan manfaat bagi pasien, komunikasi terapeutik juga memberikan manfaat bagi keluarga. Melalui komunikasi yang baik, keluarga dapat memahami kondisi lansia secara lebih jelas serta berperan aktif dalam mendukung proses perawatan pasien.

C. Tahapan Komunikasi Terapeutik

Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik dilakukan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik antara perawat dan pasien secara sistematis. Menurut Peplau (1952), terdapat empat fase dalam komunikasi terapeutik, yaitu fase pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi.

1. Fase Pra-Interaksi

Fase pra-interaksi merupakan tahap persiapan sebelum perawat bertemu dengan pasien. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien, baik dari rekam medis maupun dari tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, perawat juga mempersiapkan diri secara emosional dan mental agar dapat memberikan respons yang profesional selama proses komunikasi (Arnold & Boggs, 2019).

2. Fase Orientasi

Fase orientasi merupakan tahap awal pertemuan antara perawat dan pasien. Pada tahap ini, perawat memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tujuan interaksi, serta membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Perawat juga menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan serta melakukan kontrak waktu dengan pasien (Peplau, 1952).

3. Fase Kerja

Fase kerja merupakan tahap inti dalam komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat membantu pasien mengeksplorasi masalah yang dialami serta memberikan dukungan emosional kepada pasien. Perawat menggunakan berbagai teknik komunikasi terapeutik seperti mendengarkan secara aktif, memberikan klarifikasi, melakukan refleksi perasaan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif (Arnold & Boggs, 2019).

4. Fase Terminasi

Fase terminasi merupakan tahap akhir dari hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Pada tahap ini, perawat melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi yang telah berlangsung serta merencanakan tindak lanjut yang diperlukan. Terminasi yang baik dapat membantu pasien merasa dihargai serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan mereka mengenai proses interaksi yang telah terjadi (Peplau, 1952).

D. Perubahan pada Lansia yang Mempengaruhi Komunikasi

Proses penuaan menyebabkan berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam berkomunikasi. Perubahan tersebut dapat meliputi perubahan fisik, psikologis, maupun sosial.

1. Perubahan Fisik

Salah satu perubahan fisik yang umum terjadi pada lansia adalah penurunan fungsi pendengaran atau presbikusis. Kondisi ini dapat menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam mendengar percakapan, terutama pada lingkungan yang bising. Selain itu, lansia juga sering mengalami penurunan kemampuan penglihatan atau presbiopia yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membaca atau memahami informasi visual (Eliopoulos, 2020).

Penelitian oleh Chen et al., (2020) menunjukkan bahwa penurunan fungsi kognitif dan sensori pada lansia berkontribusi terhadap terjadinya miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat perlu menyesuaikan teknik komunikasi, seperti menggunakan bahasa sederhana, berbicara secara perlahan atau lambat, serta memberikan waktu bagi pasien untuk merespons.

2. Perubahan Psikologis

Lansia juga dapat mengalami perubahan psikologis yang berkaitan dengan proses penuaan. Menurut Erikson (1982), individu pada masa lanjut usia berada pada tahap perkembangan *integrity versus despair*. Pada tahap ini, individu melakukan refleksi terhadap pengalaman hidup yang telah dijalani. Jika individu merasa puas dengan kehidupannya, maka ia akan mencapai integritas ego. Sebaliknya, jika individu merasa menyesal atau tidak puas terhadap kehidupannya, maka ia dapat mengalami perasaan putus asa.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial seperti pensiun, berkurangnya interaksi sosial, serta kehilangan pasangan hidup dapat menyebabkan lansia merasa kesepian atau terisolasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis lansia serta mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain (Eliopoulos, 2020).

E. Komunikasi Empatik dalam Keperawatan Lansia

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Dalam praktik keperawatan, empati merupakan unsur penting dalam membangun hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Menurut Travelbee (1971), hubungan terapeutik yang efektif antara perawat dan pasien harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman pasien sebagai manusia.

Perawat yang mampu menunjukkan empati akan lebih mudah membangun hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan pasien. Teknik komunikasi empatik yang dapat digunakan antara lain mendengarkan secara aktif, memberikan refleksi perasaan, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien (Arnold & Boggs, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunikasi empatik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis lansia. Studi oleh Park dan Song (2022) menemukan bahwa komunikasi empatik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mampu menurunkan tingkat depresi dan meningkatkan kepuasan perawatan pada lansia secara bermakna. Selain itu, penelitian oleh Williams et al., (2021) menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara perawat dan pasien lansia berhubungan erat dengan kepatuhan terapi dan keberhasilan manajemen penyakit kronis.

Dalam konteks lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi, pendekatan komunikasi yang tepat menjadi sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Zen, dkk., (2024) menunjukkan bahwa intervensi berbasis relaksasi seperti *Benson relaxation therapy* dan *progressive muscle relaxation* dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien hipertensi, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya alat interaksi, tetapi juga bagian integral dari keberhasilan intervensi keperawatan.

Pendekatan empatik sangat penting dalam keperawatan lansia karena lansia sering menghadapi berbagai kehilangan dalam kehidupannya, baik kehilangan kesehatan, peran sosial, maupun orang yang dicintai.

F. Komunikasi Kultural dalam Asuhan Keperawatan Lansia

Selain empati, pendekatan kultural juga menjadi faktor penting dalam komunikasi terapeutik. Penelitian oleh Saha et al., (2020) menunjukkan bahwa komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan kualitas hubungan terapeutik. Dalam konteks Indonesia yang memiliki budaya kolektivistik, keterlibatan keluarga dalam proses komunikasi menjadi sangat

penting. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Rahmawati et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pendekatan *family-centered care* meningkatkan dukungan sosial dan kepatuhan lansia terhadap pengobatan.

Budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap cara individu memandang kesehatan, penyakit, serta proses perawatan. Oleh karena itu, perawat perlu memahami latar belakang budaya pasien agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan pasien.

Teori *Transcultural Nursing* yang dikembangkan oleh Leininger menjelaskan bahwa perawat perlu memahami nilai budaya, kepercayaan, serta praktik kesehatan pasien untuk memberikan asuhan keperawatan yang efektif (Leininger & McFarland, 2006).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang tua merupakan aspek budaya yang sangat kuat. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam proses perawatan lansia menjadi sangat penting. Pendekatan ini dikenal sebagai *family-centered care*, yaitu pendekatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan pasien.

Dengan memahami latar belakang budaya pasien, perawat dapat membangun komunikasi yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan kepada lansia.

Dalam penelitian Zen, dkk., (2024) sebagai salah satu bukti yang bahwa pendekatan berbasis budaya pada lansia dengan risiko hipertensi dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan pasien. Dalam penelitian tersebut, komunikasi edukatif yang disesuaikan dengan persepsi dan keyakinan pasien terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi. Temuan ini menguatkan pentingnya pendekatan komunikasi yang mempertimbangkan aspek kognitif, budaya, dan kepercayaan pasien.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis **stroke ringan** sejak dua hari yang lalu. Pasien tampak lebih banyak diam dan jarang berbicara dengan orang di sekitarnya. Ketika perawat mencoba mengajak berbicara, pasien mengatakan, "Sejak sakit saya merasa tidak berguna lagi bagi keluarga."

Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelum sakit pasien sangat aktif di lingkungan masyarakat dan sering mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini pasien tampak murung dan lebih memilih berbaring di tempat tidur.

Keluarga juga mengungkapkan bahwa mereka bingung bagaimana cara memberikan dukungan kepada pasien agar tidak merasa sedih.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien tampak murung dan kurang bersemangat
- Kontak mata kurang saat berbicara
- Pasien mengatakan merasa menjadi beban keluarga
- Tekanan darah 150/90 mmHg
- Frekuensi nadi 92 x/menit
- Frekuensi napas 20 x/menit
- Suhu 36,6°C

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi data subjektif dan data objektif yang ditemukan pada kasus tersebut.
2. Jelaskan masalah psikososial yang mungkin dialami oleh pasien berdasarkan data pengkajian.
3. Tentukan teknik komunikasi terapeutik yang paling tepat digunakan oleh perawat dalam berinteraksi dengan pasien pada kasus tersebut.
4. Jelaskan bagaimana perawat dapat menunjukkan sikap empatik dalam komunikasi dengan pasien lansia tersebut.
5. Jelaskan peran keluarga dalam mendukung kondisi psikologis pasien pada kasus tersebut.

Mahasiswa diminta mendiskusikan jawaban bersama anggota kelompok, kemudian menyusun hasil analisis dan mempresentasikannya di kelas. Diskusi kelompok diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami penerapan komunikasi terapeutik secara lebih mendalam dalam praktik keperawatan gerontik.

G. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 79 tahun dirawat di ruang geriatri karena hipertensi. Hasil anamnesis: pasien mengatakan tidak dapat mendengar penjelasan perawat dengan jelas, terutama ketika ruangan ramai. Hasil pengkajian: pasien sadar penuh, beberapa kali meminta perawat mengulang pertanyaan, memiringkan kepala untuk mendengar, dan tampak kebingungan ketika perawat berbicara dengan cepat dari samping tempat tidur.

Apakah tindakan komunikasi perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Berbicara dengan suara keras dari jarak jauh agar pasien mendengar
- B. Mengajak pasien ke tempat yang lebih tenang, menghadap pasien, berbicara perlahan, dan menggunakan bahasa sederhana
- C. Meminta keluarga menjawab seluruh pertanyaan agar komunikasi lebih cepat
- D. Mengulangi penjelasan dengan kecepatan yang sama tetapi volume suara lebih tinggi
- E. Memberikan semua informasi tertulis menggunakan huruf berukuran kecil

Kunci Jawaban: B. Mengajak pasien ke tempat yang lebih tenang, menghadap pasien, berbicara perlahan, dan menggunakan bahasa sederhana

Rasional:

Pasien menunjukkan hambatan komunikasi yang berkaitan dengan penurunan fungsi pendengaran atau presbikusis. Kondisi tersebut menyebabkan lansia kesulitan mengikuti percakapan, terutama dalam lingkungan yang bising. Perawat perlu mengurangi kebisingan, menghadap langsung kepada pasien agar gerakan bibir dan ekspresi wajah terlihat, menggunakan kalimat sederhana, berbicara secara perlahan, dan memberikan waktu yang cukup bagi pasien untuk merespons.

2. Seorang perempuan berusia 75 tahun baru dirawat di ruang penyakit dalam karena diabetes melitus. Hasil anamnesis: pasien mengatakan, "Saya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda langsung menanyakan banyak hal kepada saya?" Hasil pengkajian: pasien tampak tegang, menjaga barang pribadinya, menjawab pertanyaan secara singkat, dan belum bersedia menceritakan keluhannya. Perawat sebelumnya langsung melakukan pengkajian tanpa memperkenalkan diri.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Melanjutkan pengkajian agar data pasien segera lengkap
- B. Meminta anggota keluarga menjawab semua pertanyaan

- C. Memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tujuan interaksi, serta membuat kontrak waktu dengan pasien
- D. Mengakhiri interaksi dan mencatat bahwa pasien tidak kooperatif
- E. Meyakinkan pasien bahwa ia tidak perlu mengetahui tujuan pertanyaan perawat

Kunci Jawaban: C. Memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan tujuan interaksi, serta membuat kontrak waktu dengan pasien

Rasional:

Masalah terjadi karena perawat belum melaksanakan fase orientasi dengan benar. Pada fase orientasi, perawat perlu memperkenalkan diri, menjelaskan peran, menyampaikan tujuan interaksi, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, dan membuat kontrak waktu. Tahapan tersebut penting untuk membangun rasa aman dan hubungan saling percaya sebelum perawat menggali masalah pasien lebih lanjut.

3. Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat karena stroke ringan. Hasil anamnesis: pasien mengatakan, "Sejak sakit, saya merasa tidak berguna dan hanya menjadi beban keluarga." Sebelum sakit, pasien aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Hasil pengkajian: pasien tampak murung, lebih sering berbaring, kontak mata kurang, berbicara dengan suara pelan, dan menolak berbincang dengan pasien lain. Apakah respons perawat yang paling terapeutik pada kasus tersebut?
 - A. "Bapak tidak boleh berpikir seperti itu karena keluarga masih membutuhkan Bapak."
 - B. "Bapak harus bersyukur karena penyakit Bapak tidak terlalu berat."
 - C. "Bapak tampaknya sedih karena merasa peran Bapak berubah. Ceritakan hal yang paling Bapak khawatirkan."
 - D. "Tenang saja, nanti Bapak pasti kembali seperti sebelum sakit."
 - E. "Sebaiknya Bapak tidak terlalu memikirkan keadaan ini agar cepat sembuh."

Kunci Jawaban: C. "Bapak tampaknya sedih karena merasa peran Bapak berubah. Ceritakan hal yang paling Bapak khawatirkan."

Rasional:

Respons tersebut menunjukkan empati melalui refleksi perasaan dan pertanyaan terbuka. Perawat mengakui kesedihan pasien tanpa menghakimi, meremehkan, atau memberikan jaminan yang belum pasti. Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi perasaan, kekhawatiran, kehilangan peran, dan perubahan yang dialaminya setelah sakit.

4. Seorang perempuan berusia 80 tahun datang ke puskesmas untuk mengontrol hipertensi. Hasil anamnesis: pasien mengatakan lebih percaya pada ramuan keluarga dan bersedia mendengarkan penjelasan kesehatan apabila anak perempuannya ikut mendampingi. Hasil pengkajian: tekanan darah 168/92 mmHg, pasien sadar penuh, dapat berkomunikasi, tetapi tampak ragu ketika perawat menjelaskan pengobatan tanpa melibatkan keluarga.

Apakah tindakan komunikasi perawat yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Menyatakan bahwa keyakinan pasien salah dan harus ditinggalkan
- B. Memberikan instruksi pengobatan tanpa membahas nilai dan keyakinan pasien
- C. Berbicara hanya kepada anak pasien karena pasien sudah lanjut usia
- D. Menggali keyakinan pasien, memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana, dan melibatkan keluarga sesuai keinginan pasien
- E. Menyetujui seluruh penggunaan ramuan tanpa memberikan penjelasan kesehatan

Kunci Jawaban: D. Menggali keyakinan pasien, memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana, dan melibatkan keluarga sesuai keinginan pasien

Rasional:

Komunikasi yang sensitif terhadap budaya dilakukan dengan memahami nilai, kepercayaan, dan praktik kesehatan pasien. Perawat tidak langsung menolak keyakinan pasien, tetapi menggali maknanya, memberikan informasi yang dapat dipahami, serta membangun keputusan perawatan yang menghormati nilai pasien. Dalam masyarakat dengan nilai kekeluargaan yang kuat, keterlibatan keluarga dapat meningkatkan dukungan sosial dan kepatuhan lansia terhadap perawatan.

5. Seorang laki-laki berusia 76 tahun telah berbicara dengan perawat selama 20 menit mengenai kecemasannya dalam menjalani pengobatan penyakit kronis. Hasil anamnesis: pasien mengatakan merasa lebih tenang dan mulai memahami cara mengatasi kecemasannya. Hasil pengkajian: pasien mampu mengulangi kembali dua cara relaksasi yang telah dibahas. Waktu interaksi akan segera berakhir dan perawat akan melakukan kunjungan kembali pada hari berikutnya.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat selanjutnya?

- A. Mengakhiri percakapan secara langsung karena tujuan interaksi telah tercapai
- B. Memulai pembahasan baru mengenai masalah keluarga pasien
- C. Menyerahkan pembicaraan berikutnya kepada keluarga tanpa memberi tahu pasien

- D. Mengulangi seluruh pengkajian dari awal agar tidak ada informasi yang terlewat
- E. Mengevaluasi hasil interaksi, merangkum pembahasan, menanyakan perasaan pasien, dan menyepakati tindak lanjut

Kunci Jawaban: E. Mengevaluasi hasil interaksi, merangkum pembahasan, menanyakan perasaan pasien, dan menyepakati tindak lanjut

Rasional:

Kasus tersebut telah memasuki fase terminasi. Pada fase ini, perawat mengevaluasi proses dan hasil komunikasi, merangkum hal-hal penting yang telah dibahas, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya, dan merencanakan tindak lanjut. Terminasi yang dilakukan secara jelas membantu pasien merasa dihargai dan memahami kelanjutan hubungan terapeutik.

H. Ringkasan

Komunikasi terapeutik merupakan proses interaksi profesional antara perawat dan pasien yang bertujuan membantu pasien memahami kondisi kesehatannya serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis. Dalam keperawatan gerontik, komunikasi terapeutik memiliki peran penting karena lansia sering mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Proses komunikasi terapeutik dilakukan melalui terapeutik pada lansia perlu dilakukan dengan pendekatan empatik dan sensitif terhadap budaya. Empati memungkinkan perawat memahami pengalaman dan perasaan pasien sehingga tercipta hubungan yang hangat dan penuh penghargaan. Di sisi lain, pemahaman terhadap nilai budaya dan peran keluarga sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan seperti di Indonesia. Dengan mengintegrasikan komunikasi empatik dan pendekatan kultural, perawat dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan lansia dan keluarganya sehingga asuhan keperawatan dapat diberikan secara lebih holistik dan bermakna.

I. Daftar Pustaka

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2019). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Chen, Y., Li, X., & Zhang, Q. (2020). تأثير perubahan kognitif terhadap komunikasi lansia. *Journal of Geriatric Nursing*, 41(3), 215–221.
- Eliopoulos, C. (2020). *Gerontological nursing* (9th ed.). Wolters Kluwer.

- Erikson, E. H. (1982). *The life cycle completed*. Norton.
- Leininger, M., & McFarland, M. R. (2006). *Culture care diversity and universality: A worldwide nursing theory* (2nd ed.). Jones & Bartlett.
- Park, H., & Song, M. (2022). The effect of empathic communication on depression in older adults. *Geriatric Nursing*, 43(2), 120–126.
- Peplau, H. E. (1952). *Interpersonal relations in nursing*. G. P. Putnam's Sons.
- Rahmawati, D., et al. (2021). Family-centered care approach in elderly patients. *Indonesian Journal of Nursing*, 24(1), 45–52.
- Saha, S., et al. (2020). Patient-centered communication and cultural competence. *Patient Education and Counseling*, 103(1), 1–8.
- Travelbee, J. (1971). *Interpersonal aspects of nursing*. F. A. Davis.
- Williams, K., et al. (2021). Nurse–patient communication and treatment adherence. *Journal of Clinical Nursing*, 30(5–6), 789–798.
- Zen, ND, dkk. (2024). Penerapan Terapi Relaksasi Otot Progresif Pada Lansia Dengan Risiko Hipertensi Dengan Pendekatan Health Belief Model. *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- Zen, ND, dkk. (2024). Application of benson relaxation therapy and progressive muscle relaxation on sleep quality in hypertensive patients in Linggasari Village, Ciamis Regency. *Science Midwifery*, Vol 12 No. 2.

BAB 5

DOKUMENTASI, CONTINUITY OF CARE, DAN PENGANTAR MUTU–KESELAMATAN PASIEN LANSIA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, kepatuhan aspek legal, dan advokasi hak lansia dalam praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-5
CPL-2	Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.	CPMK-1
CPL-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif dan menafsirkan hasilnya untuk menetapkan masalah prioritas serta risiko.	CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Merumuskan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur.	CPMK-4; CPMK-3
CPL-5	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan lansia, keluarga, serta tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Menerapkan mutu–keselamatan pasien, dokumentasi, dan continuity of care dalam asuhan keperawatan lansia.	CPMK-6; CPMK-4; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar keperawatan gerontik dan proses penuaan untuk menjelaskan kebutuhan biopsikososial-spiritual lansia.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika, hak lansia, dan aspek legal dalam pengambilan keputusan serta advokasi pada praktik keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian gerontik komprehensif (CGA) menggunakan instrumen standar untuk mengidentifikasi fungsi, frailty, dan risiko utama.
CPMK-4	Menetapkan diagnosis keperawatan gerontik dan menyusun rencana asuhan berbasis evidence dengan tujuan terukur serta evaluasi.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.
CPMK-6	Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu-keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.
CPMK-7	Merancang dan mengevaluasi intervensi keperawatan untuk sindrom geriatri prioritas secara kolaboratif dan berorientasi pencegahan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Gerontik dan Peran Perawat	1.1 Menguraikan ruang lingkup keperawatan gerontik, terminologi kunci, dan kebutuhan layanan lansia.	1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, dan kompetensi perawat dalam tim geriatri serta alur layanan promotif-paliatif.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-6
Bab 2. Teori Penuaan & Perubahan Biopsikososial-Spiritual pada Lansia	2.1 Membedakan teori/konsep penuaan dan implikasinya terhadap respon kesehatan lansia.	2.2 Menganalisis perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia sebagai dasar intervensi holistik.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5
Bab 3. Etika, Hak Lansia, dan Isu Legal dalam Praktik Keperawatan	3.1 Menerapkan prinsip etika dalam penyelesaian kasus-kasus keperawatan gerontik.	3.2 Menjelaskan hak lansia, informed consent, kerahasiaan, dan isu legal (penelantaran, kekerasan, kapasitas keputusan).	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Pengkajian Gerontik Komprehensif (CGA): ADL/IADL, frailty, risiko	4.1 Melakukan CGA terstruktur menggunakan instrumen ADL/IADL, skrining frailty, kognitif, mood, nutrisi, dan risiko jatuh.	4.2 Mensintesis temuan CGA menjadi masalah prioritas, risiko, dan kebutuhan rujukan/kolaborasi.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Diagnosa Keperawatan Gerontik & Perencanaan Asuhan Berbasis Evidence	5.1 Merumuskan diagnosis & keperawatan gerontik berbasis data dengan prioritas yang jelas.	5.2 Menyusun rencana asuhan berbasis evidence (tujuan terukur, intervensi, evaluasi) dan indikator hasil.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-6
Bab 6. Komunikasi Terapeutik dengan Lansia & Keluarga (kultural dan empatik)	6.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada lansia secara empatik dan adaptif terhadap keterbatasan sensori/kognitif.	6.2 Merancang edukasi kesehatan dan counseling keluarga dengan pendekatan kultural, health literacy, dan shared decision-making.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-2
Bab 7. Dokumentasi, Continuity of Care, dan Pengantar Mutu–Keselamatan Pasien Lansia	7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.	7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
Bab 8. Frailty, Sarcopenia, dan Risiko Disabilitas	8.1 Menilai frailty dan sarcopenia serta keterkaitannya	8.2 Merancang intervensi keperawatan/kolaboratif untuk pencegahan dan	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	dengan disabilitas dan outcome.	penanganan frailty–sarcopenia.		
Bab 9. Jatuh pada Lansia: Skrining Risiko, Pencegahan, dan Rehabilitasi	9.1 Melakukan skrining risiko jatuh dan identifikasi faktor intrinsik–ekstrinsik.	9.2 Menyusun paket pencegahan jatuh dan rencana rehabilitasi dasar pasca-jatuh termasuk edukasi lingkungan aman.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 10. Delirium: Deteksi Dini, Tata Laksana Keperawatan, dan Pencegahan	10.1 Melakukan deteksi dini delirium dan identifikasi faktor pemicu menggunakan alat skrining sederhana.	10.2 Menyusun intervensi keperawatan nonfarmakologis, monitoring, dan pencegahan delirium secara kolaboratif.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
Bab 11. Ulkus Tekan & Perawatan Kulit Lansia: Pencegahan hingga Perawatan Luka	11.1 Mengidentifikasi risiko ulkus tekan dan langkah pencegahan berbasis repositioning serta perawatan kulit.	11.2 Merencanakan perawatan luka dasar (asesmen luka, balutan, nyeri) dan rujukan sesuai tingkat keparahan.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-6
Bab 12. Inkontinensia Urin/Feses dan Asuhan Keperawatan Terintegrasi	12.1 Mengkaji tipe/derajat inkontinensia dan dampaknya pada kualitas hidup serta risiko komplikasi.	12.2 Merancang asuhan terintegrasi dan edukasi (latihan, manajemen cairan, higiene, alat bantu) dengan evaluasi terukur.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
Bab 13. Malnutrisi, Dehidrasi, dan Masalah Menelan (Dysphagia) pada Lansia	13.1 Melakukan skrining malnutrisi, dehidrasi, dan dysphagia serta menetapkan risiko aspirasi.	13.2 Menyusun intervensi nutrisi–hidrasi aman (modifikasi tekstur, posisi, pemantauan) dan evaluasi outcome.	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 14. Polifarmasi & Keselamatan Obat pada Lansia (kolaborasi interprofesional)	14.1 Mengidentifikasi polifarmasi, obat berisiko tinggi, dan potensi interaksi/efek samping melalui medication review sederhana.	14.2 Merancang strategi keselamatan obat: rekonsiliasi obat, edukasi kepatuhan, dan komunikasi interprofesional untuk deprescribing bila perlu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Kuis/tes tertulis; tugas ringkas (concept map)	Ketepatan konsep penuaan & gerontik ($\geq 80\%$ benar); kemampuan mengaitkan perubahan biopsikosial-spiritual dengan kebutuhan asuhan (≥ 2 contoh tepat)	10	Nilai kuis; concept map terstruktur
CPMK-2	Analisis kasus etik-legal tertulis; refleksi terarah	Identifikasi isu etik-legal & hak lansia (≥ 4 poin relevan); rekomendasi keputusan/advokasi konsisten dengan prinsip etika dan prosedur (≥ 2 justifikasi)	10	Lembar analisis kasus; refleksi etis
CPMK-3	OSCE pengkajian; penugasan laporan CGA	Kelengkapan item CGA ($\geq 90\%$ terisi); ketepatan skoring instrumen (selisih ≤ 1 kategori); sintesis prioritas masalah & risiko (≥ 3 prioritas dengan alasan)	15	Lembar CGA; laporan interpretasi; checklist OSCE
CPMK-4	Studi kasus (care plan) berbasis	Ketepatan diagnosis/masalah (sesuai data, ≥ 3 diagnosis); tujuan/outcome terukur	20	Dokumen care plan; daftar

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
	evidence; penilaian portofolio	(SMART, ≥ 3); intervensi rasional berbasis evidence (≥ 3 sumber kredibel)		pustaka ringkas; portofolio kasus
CPMK-5	OSCE/role play komunikasi; penugasan materi edukasi	Keterampilan komunikasi (empati, klaritas, validasi, adaptasi sensori/kognitif) minimal "baik" pada ≥ 4 komponen; materi edukasi sesuai health literacy dan budaya (≥ 2 strategi adaptasi)	10	Video/lembar observasi OSCE; leaflet/outline edukasi
CPMK-6	Audit dokumentasi simulasi; tugas handover & rekonsiliasi obat; kuis keselamatan	Dokumentasi (lengkap, akurat, tepat waktu) $\geq 85\%$ item terpenuhi; kualitas handover (SBAR/format setara) ≥ 4 elemen lengkap; identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan (≥ 3 risiko + 3 tindakan)	15	Catatan SOAP/ADPIE; form handover; form rekonsiliasi obat; hasil audit
CPMK-7	Ujian akhir berbasis kasus sindrom geriatri; OSCE intervensi terpilih	Ketepatan paket intervensi (pencegahan + tata laksana) sesuai masalah kasus ($\geq 80\%$ sesuai pedoman/bukti); monitoring outcome & kriteria rujukan jelas (≥ 3 parameter + ≥ 1 rujukan/kolaborasi tepat)	20	Lembar jawaban kasus; rencana intervensi terintegrasi; checklist OSCE

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep penuaan	Banyak konsep keliru;	Konsep dasar cukup namun ada kekeliruan	Konsep tepat dan cukup lengkap;	Konsep sangat tepat, komprehensif,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& keperawatan gerontik	istilah tidak tepat; <60% benar	penting; 60–74% benar	kesalahan minor; 75–89% benar	dan terintegrasi; ≥90% benar
1.2 Analisis perubahan biopsikososial-spiritual & implikasi asuhan	Uraian deskriptif tanpa kaitan implikasi asuhan	Mengaitkan sebagian perubahan dengan implikasi; contoh terbatas	Analisis logis; mengaitkan perubahan dengan kebutuhan asuhan; contoh relevan	Analisis mendalam, integratif, memprioritaskan implikasi; argumentasi kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Identifikasi isu etik-legal & hak lansia pada kasus	Isu utama tidak teridentifikasi/keliru	Isu teridentifikasi sebagian; ada yang terlewat	Isu utama teridentifikasi lengkap dan relevan	Isu lengkap, tajam, termasuk risiko dan pihak terkait
2.2 Kualitas keputusan/advokasi (alasan dan langkah)	Rekomendasi tidak konsisten; tanpa justifikasi	Rekomendasi cukup, justifikasi lemah/umum	Rekomendasi tepat; justifikasi berbasis prinsip; langkah jelas	Rekomendasi sangat tepat; justifikasi kuat; mempertimbangkan alternatif dan dampak

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan & ketepatan pelaksanaan CGA	Data banyak kosong; sering salah	Data cukup; beberapa komponen CGA terlewat	Data lengkap; skoring benar dengan kesalahan minor	Data sangat lengkap; skoring akurat; teknik pengkajian sistematis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		skoring kurang konsisten		
3.2 Sintesis hasil CGA menjadi prioritas masalah & risiko	Tidak mampu memprioritaskan; alasan tidak berbasis data	Prioritas ada namun kurang didukung data	Prioritas jelas; alasan berbasis data; risiko utama terpetakan	Prioritas sangat tajam; mengaitkan faktor risiko, protektif, dan kebutuhan kolaborasi

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan diagnosis/masalah keperawatan berbasis data	Tidak sesuai data; pernyataan masalah kabur	Sebagian sesuai data; masih ada diagnosis tidak tepat	Sesuai data; prioritas logis; pernyataan jelas	Sangat sesuai data; prioritas sangat tepat; mempertimbangkan komorbid & risiko
4.2 Kualitas rencana asuhan berbasis evidence	Tujuan tidak terukur; intervensi generik tanpa rasional	Tujuan cukup; intervensi ada namun kurang spesifik/kurang bukti	Tujuan SMART; intervensi spesifik; rasional berbasis evidence; evaluasi ada	Sangat terstruktur; evidence kuat; indikator hasil jelas; rencana evaluasi dan penyesuaian rinci

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Keterampilan komunikasi terapeutik dengan lansia	Tidak empatik; komunikasi tidak jelas; tidak adaptif	Empati ada namun kurang konsisten;	Empatik, jelas, adaptif; membangun hubungan dan validasi	Sangat empatik; responsif; mengelola hambatan sensori/kognitif secara efektif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		adaptasi terbatas		
5.2 Kualitas edukasi & kolaborasi dengan keluarga	Materi tidak sesuai kebutuhan/kemampuan; tanpa tindak lanjut	Materi cukup sesuai; strategi adaptasi minim	Materi sesuai; adaptif budaya & literasi; ada rencana tindak lanjut	Sangat sesuai; melibatkan keluarga; strategi adaptasi kuat; evaluasi pemahaman jelas

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas dokumentasi & handover/continuity	Tidak lengkap; tidak akurat; tidak tepat waktu	Cukup lengkap namun ada kekurangan elemen penting	Lengkap, akurat, tepat waktu; format konsisten	Sangat lengkap; sangat akurat; mendukung transisi dan keterlacakan klinis
6.2 Identifikasi risiko keselamatan & rencana pencegahan	Risiko tidak terpetakan; rencana tidak spesifik	Risiko sebagian teridentifikasi; rencana umum	Risiko utama teridentifikasi; rencana pencegahan spesifik dan realistis	Risiko komprehensif; rencana pencegahan terintegrasi, prioritas jelas, dan terukur

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan intervensi sindrom geriatri (pencegahan & tata laksana)	Intervensi tidak sesuai masalah; berisiko/kontraindikasi	Intervensi sebagian sesuai; masih ada komponen penting terlewat	Intervensi sesuai masalah; mencakup pencegahan dan	Intervensi sangat tepat; komprehensif; mempertimbangkan preferensi,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			tata laksana	keamanan, dan evidence
7.2 Monitoring outcome, evaluasi, dan kolaborasi/rujukan	Tidak ada parameter monitoring; evaluasi tidak jelas	Parameter terbatas; rujukan/kolaborasi kurang tepat	Parameter monitoring jelas; evaluasi dan kolaborasi tepat	Monitoring sangat terukur; evaluasi adaptif; kolaborasi/rujukan tepat waktu dan efektif

Menerapkan mutu–keselamatan pasien, dokumentasi, dan *continuity of care* dalam asuhan keperawatan lansia.

Bab 7. Dokumentasi, Continuity of Care, dan Pengantar Mutu–Keselamatan Pasien Lansia	7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.	7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-5
--	--	--	--------	----------------

7.1 Menyusun dokumentasi asuhan gerontik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mendukung transisi perawatan.

7.2 Menganalisis risiko keselamatan pasien lansia dan strategi pencegahan insiden berbasis mutu.

CPMK Utama

No. 6 Mengelola dokumentasi, continuity of care, serta strategi mutu–keselamatan pasien lansia termasuk keselamatan obat.

Audit dokumentasi simulasi; tugas handover &	Dokumentasi (lengkap, akurat, tepat waktu) $\geq 85\%$ item terpenuhi; kualitas handover (SBAR/format setara) ≥ 4 elemen lengkap; identifikasi risiko	15	Catatan SOAP/ADPIE; form handover; form
--	--	----	---

rekonsiliasi obat; kuis keselamatan	keselamatan & rencana pencegahan (≥ 3 risiko + 3 tindakan)		rekonsiliasi obat; hasil audit
-------------------------------------	--	--	--------------------------------

CPMK Pendukung

No. 2 Menguasai konsep penuaan dan perubahan biopsikososial-spiritual untuk memahami kebutuhan kesehatan lansia.

Analisis kasus etik-legal tertulis; refleksi terarah	Identifikasi isu etik-legal & hak lansia (≥ 4 poin relevan); rekomendasi keputusan/advokasi konsisten dengan prinsip etika dan prosedur (≥ 2 justifikasi)
--	---

No. 5 Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan pada lansia serta keluarga secara empatik, kultural, dan kolaboratif.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Keterampilan komunikasi terapeutik dengan lansia	Tidak empatik; komunikasi tidak jelas; tidak adaptif	Empati ada namun kurang konsisten; adaptasi terbatas	Empatik, jelas, adaptif; membangun hubungan dan validasi	Sangat empatik; responsif; mengelola hambatan sensori/kognitif secara efektif
5.2 Kualitas edukasi & kolaborasi dengan keluarga	Materi tidak sesuai kebutuhan/kemampuan; tanpa tindak lanjut	Materi cukup sesuai; strategi adaptasi minim	Materi sesuai; adaptif budaya & literasi; ada rencana tindak lanjut	Sangat sesuai; melibatkan keluarga; strategi adaptasi kuat; evaluasi pemahaman jelas

Deskripsi Bab

Bab ini membahas konsep penting dalam praktik keperawatan gerontik terkait dokumentasi asuhan keperawatan, kesinambungan pelayanan (*continuity of care*),

serta mutu dan keselamatan pasien lansia. Materi ini bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan.

Capaian Pembelajaran (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dokumentasi keperawatan gerontik
2. Melaksanakan dokumentasi sesuai standar
3. Memahami konsep *continuity of care* pada lansia
4. Menganalisis mutu pelayanan kesehatan lansia
5. Menerapkan prinsip keselamatan pasien lansia

A. Dokumentasi Keperawatan Gerontik

1. Pengertian Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan adalah pencatatan sistematis tentang seluruh proses asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Dokumentasi mencakup pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi.

Dokumentasi berfungsi sebagai:

- a. Alat komunikasi antar tenaga kesehatan: Dokumentasi menjadi media pertukaran informasi antar perawat, dokter, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lain agar perawatan pasien berkesinambungan (*continuity of care*). Setiap tenaga kesehatan dapat mengetahui kondisi terakhir pasien, tindakan yang sudah dilakukan, serta rencana selanjutnya tanpa harus mengulang pengkajian dari awal.

Contoh:

Seorang lansia dengan stroke, yang terdapat kelemahan ekstremitas, sebagai perawat yang bertugas saat itu mencatat: "Pasien mengalami kelemahan ekstremitas kanan, latihan ROM pasif dilakukan 2x/hari, respon pasien kooperatif, skala nyeri 2-3 (nyeri ringan), sudah diajarkan dan mampu melakukan tehnik relaksasi saat terasa nyeri."

Fisioterapis membaca dokumentasi tersebut dan melanjutkan terapi mobilisasi sesuai kondisi.

Tanpa dokumentasi yang baik, bisa terjadi tindakan berulang atau kesalahan terapi.

Dokumentasi merupakan, bukti hukum pelayanan, sumber evaluasi mutu pelayanan, dasar penelitian dan pendidikan. Dalam keperawatan gerontik, dokumentasi harus memperhatikan kondisi lansia yang kompleks (bio-psiko-sosial-spiritual).

- b. Bukti Hukum Pelayanan: Dokumentasi merupakan bukti tertulis bahwa perawat telah melakukan tindakan sesuai standar profesi dan prosedur. Jika terjadi masalah hukum (misalnya komplain keluarga), catatan keperawatan menjadi bukti utama apakah tindakan sudah benar atau tidak.

Contoh:

Pada lansia dengan risiko jatuh, dokumentasi: "Dilakukan edukasi pencegahan jatuh, pemasangan side rail, lingkungan aman." Jika pasien tetap jatuh, perawat dapat menunjukkan bahwa tindakan pencegahan sudah dilakukan sesuai standar.

Prinsip: *"If it is not documented, it is not done."*

- c. Sumber Evaluasi Mutu Pelayanan: Dokumentasi digunakan untuk menilai kualitas asuhan keperawatan.

Data dalam dokumentasi dianalisis untuk melihat apakah intervensi efektif dan sesuai standar.

Contoh:

Kasus lansia dengan luka decubitus, Hari 1: Luka derajat II, ukuran 3 cm, Hari 5: Luka mengecil menjadi 2 cm

Dari dokumentasi terlihat bahwa perawatan luka yang telah dilakukan efektif, Sebaliknya, jika luka memburuk artinya perlu evaluasi tindakan.

- d. Dasar Penelitian dan Pendidikan: Dokumentasi menjadi sumber data untuk penelitian dan pembelajaran mahasiswa keperawatan. Data pasien (tanpa identitas) dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan meningkatkan praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based*).

Contoh:

Penelitian pada lansia: Data dokumentasi menunjukkan banyak lansia mengalami insomnia. Digunakan untuk penelitian tentang efektivitas terapi relaksasi pada lansia.

Mahasiswa juga belajar dari: Studi kasus nyata dalam dokumentasi pasien

- e. Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual pada Lansia: Dalam keperawatan gerontik, dokumentasi harus mencakup aspek menyeluruh:

1) Biologis (Fisik)

Kondisi tubuh dan penyakit pasien, tekanan darah: 150/90 mmHg, nyeri sendi skala 4/10, mobilitas terbatas.

2) Psikologis

Kondisi emosi, mental, dan kognitif, pasien tampak cemas, mengalami penurunan memori (lupa waktu),
Skor MMSE menurun.

3) c. Sosial

Hubungan pasien dengan keluarga dan lingkungan, tinggal sendiri tanpa pendamping, dukungan keluarga kurang, dilingkungan pasien jarang berinteraksi dengan tetangga.

4) Spiritual

Keyakinan, nilai, dan kebutuhan ibadah pasien, contoh: Pasien ingin tetap menjalankan ibadah harian membutuhkan bantuan untuk berdoa, mengalami kecemasan terkait kematian,

Kesimpulan:

Dokumentasi keperawatan bukan sekadar pencatatan, tetapi merupakan bagian penting dalam proses asuhan keperawatan yang berfungsi sebagai komunikasi,

bukti hukum, evaluasi mutu, dan dasar pengembangan ilmu. Pada lansia, dokumentasi harus komprehensif dengan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual agar kebutuhan pasien terpenuhi secara holistik.

B. Prinsip Dokumentasi Keperawatan

1. Akurat (Sesuai Fakta)

Dokumentasi harus mencerminkan kondisi pasien yang sebenarnya, tanpa kesalahan data, manipulasi, atau perkiraan yang tidak jelas.

Contoh: ✗ Tidak akurat: "Pasien tampak agak sakit", ✓ Akurat: "Pasien mengeluh nyeri lutut kanan skala 5/10, tampak meringis saat berjalan". Data harus berdasarkan hasil pengkajian nyata (observasi, wawancara, pemeriksaan).

2. Lengkap

Semua aspek proses keperawatan harus dicatat: pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi.

Contoh: ✗ Tidak lengkap: Hanya menulis tindakan: "Memberikan obat", ✓ Lengkap: Pengkajian: TD 160/90 mmHg, Diagnosis: Risiko perfusi tidak efektif, Intervensi: Monitor tekanan darah, Implementasi: Obat antihipertensi diberikan, Evaluasi: TD turun menjadi 140/85 mmHg. Dokumentasi harus menggambarkan alur asuhan secara utuh.

3. Tepat Waktu

Pencatatan dilakukan segera setelah tindakan atau observasi, tidak ditunda.

Contoh: ✗ Tidak tepat waktu: Perawat mencatat tindakan pagi hari pada sore hari, ✓ Tepat waktu: "08.00: Memberikan obat Amlodipin 5 mg per oral", dokumentasi yang terlambat berisiko lupa atau salah informasi.

4. Objektif

Dokumentasi harus berdasarkan fakta, bukan opini atau asumsi perawat.

Contoh: ✗ Tidak objektif: "Pasien malas makan", ✓ Objektif: "Pasien menghabiskan 2 sendok makan dari porsi yang disediakan", hindari kata-kata subjektif seperti malas, nakal, atau rewel.

5. Sistematis

Dokumentasi harus tersusun rapi dan mengikuti format yang berlaku (misalnya SOAP, SDKI-SLKI-SIKI).

Contoh (SOAP):

S (Subjektif): Pasien mengeluh pusing

O (Objektif): TD 150/90 mmHg

A (Assessment): Hipertensi tidak terkontrol

P (Plan): Monitor TD dan edukasi diet rendah garam

Dokumentasi yang sistematis memudahkan tenaga kesehatan lain memahami kondisi pasien.

6. Rahasia (Confidentiality)

Informasi pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang.

Contoh: ✗ Melanggar kerahasiaan: Membicarakan kondisi pasien kepada orang lain di luar tim kesehatan

Mengunggah data pasien ke media sosial, ✓ Menjaga kerahasiaan: dokumentasi disimpan di rekam medis resmi, informasi hanya diberikan kepada keluarga inti atau tenaga kesehatan terkait. Ini merupakan bagian dari etika dan aspek legal keperawatan.

Kesimpulan: Prinsip dokumentasi keperawatan meliputi, Akurat sesuai fakta, Lengkap mencakup seluruh proses keperawatan, Tepat waktu dicatat segera, Objektif berdasarkan data, bukan opini, Sistematis tersusun sesuai format, Rahasia menjaga privasi pasien

Semua prinsip ini sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta perlindungan hukum bagi perawat.

C. Standar Dokumentasi

1. Pengkajian (Assessment)

Tahap awal untuk mengumpulkan data pasien secara menyeluruh meliputi aspek bio-psiko-sosial-spiritual.

Jenis data:

Subjektif: keluhan pasien

Objektif: hasil pemeriksaan (TTV, observasi, dll)

Contoh (Lansia dengan hipertensi):

S: "Saya sering pusing di pagi hari"

O: TD 160/90 mmHg, tampak lemah

Kedua data ini menjadi dasar penentuan diagnosis.

2. Diagnosis Keperawatan (NANDA)

Menentukan masalah keperawatan berdasarkan analisis data menggunakan standar NANDA.

Nyeri kronis berhubungan dengan degenerasi sendi

Risiko jatuh berhubungan dengan penurunan kekuatan otot

Gangguan pola tidur

Diagnosis harus jelas (problem + etiologi + gejala bila ada).

3. Perencanaan (Planning)

Menentukan tujuan (*outcome*) dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan.

Menggunakan: Outcome → NOC (*Nursing Outcome Classification*, Intervensi → NIC (*Nursing Intervensi Classification*), contoh: Diagnosis: Nyeri kronis
Outcome (NOC): Nyeri berkurang (skala ≤ 3 dalam 3 hari)
Intervensi (NIC): Manajemen nyeri (Ajarkan teknik relaksasi, Monitor skala nyeri
Perencanaan harus spesifik, terukur, dan realistis.

4. Implementasi (Implementation)

Pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah dibuat.

Contoh: Memberikan kompres hangat pada sendi, Mengajarkan teknik napas dalam, Memberikan obat sesuai instruksi dokter. Harus dicatat apa yang dilakukan, kapan, dan respon pasien.

5. Evaluasi (Evaluation)

Menilai apakah tujuan (outcome) tercapai atau belum. Jenis evaluasi: Tercapai, Sebagian tercapai, Tidak tercapai

Contoh: Hari ke-3: Nyeri turun dari skala 6 → 3 (Masalah teratasi sebagian), Jika belum tercapai → rencana diperbaiki. Integrasi NANDA – NIC – NOC dalam Dokumentasi

Contoh sederhana (kasus lansia): Pengkajian: Pasien mengeluh nyeri lutut, skala 6, kaki terasa nyeri terutama saat berjalan. Diagnosis (NANDA): Nyeri kronis, Outcome (NOC): Nyeri berkurang menjadi skala ≤ 3 , Intervensi (NIC): Manajemen nyeri, relaksasi. Implementasi: Kompres hangat, edukasi teknik napas

Evaluasi: Nyeri turun menjadi skala 3, pasien mengatakan saat ini sudah lebih nyaman berjalan, meskipun masih ada nyeri.

Kesimpulan: Standar dokumentasi keperawatan harus mengikuti 5 tahap proses keperawatan, yaitu: Pengkajian, Diagnosis, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi. Dengan pendekatan NANDA–NIC–NOC, dokumentasi menjadi: lebih terstruktur, berbasis standar Internasional, memudahkan komunikasi dan evaluasi, mendukung praktik keperawatan berbasis bukti.

D. Model Dokumentasi

Beberapa model dokumentasi:

1. Model SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*), adalah metode dokumentasi yang paling umum digunakan dalam praktik keperawatan.

Komponen:

S (Subjective): Data dari pasien (keluhan, perasaan)

O (Objective): Data hasil observasi/periksa (TTV, hasil lab)

A (Assessment): Kesimpulan dari objektif dan subjektif/Analisis/diagnosis keperawatan

P (Plan): Rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis

Contoh: S: Pasien mengeluh nyeri pada luka operasi

O: Luka tampak merah, skala nyeri 5/10

A: Nyeri akut

P: Berikan analgesik sesuai program

Tanggal	Waktu	Masalah	S.O.A.P
30/3/2026	Jam 14.00	Integritas Kulit	S: Px mengeluh nyeri di bagian punggung O: - terdapat luka di area punggung, akibat tirah baring 1) Kulit sekitar luka tampak kemerahan 2) Skala nyeri 5/10 3) Luka tidak berbau 4) Sudah dilakukan rawat luka dengan ... perawatan luka selanjutnya tgl 5) Dst... A: Luka memperlihatkan tanda awal penyembuhan P: - Lanjutkan perawatan luka 6) Berikan analgesic sesuai program

2. Model SOAPIER (SOAP + *Implementation, Evaluation, Revision*)

Model pendokumentasian ini lebih tepat digunakan apabila rencana pasien ada yang akan dirubah dan proses evaluasi mulai dilakukan. Merupakan pengembangan dari SOAP yang lebih lengkap karena mencakup tindakan dan evaluasi.

S: Subjective (Pernyataan atau keluhan pasien)

O: Objective (Data yang diperoleh dari hasil observasi)

A: Analisis (Kesimpulan berdasarkan data objektif dan subjektif)

P: Planning (Apa yang dilakukan terhadap masalah)

I: Implementation (Tindakan yang dilakukan)

E: Evaluation (Evaluasi hasil)

R: Revision (Revisi rencana)

Contoh:

I: Memberikan analgesik IV

E: Nyeri berkurang dari 5/10 menjadi skala 2/10

R: Lanjutkan terapi

Contoh Simple: "SOAPIE" / Nursing care plan

Patient name: Mrs. T

Case: Post CS (*Cesarean Surgery*) Room. 202-A

S: "It's real pain, and it's really hurt" as verbalized by the patient

Pain scale of 6/10

O: -(+) Facial grimace

a. Irritability

b. Restlessness

A: Acute pain related to post CS

P: At the end of 8 hours shift, patient will report relived pain from 6/10 to 4/10

I: Provide quite environment

a. Encouraged to do deep breathing exercise

b. Encourage to support the affected area upon movement

E: Family knows the reason for limited visitor's

a. Goal met, patient's pain decreased from 6/10 to 4/10

b. Pt able to demonstrate deep breath exercise

3. Model dokumentasi FOCUS Charting (DAR: Data, Action, Response)

Sistem pendokumentasian yang berfokus pada masalah atau respon pasien, bukan hanya diagnosis. Disebut juga model dokumentasi POS (*Process-oriented-system*), atau model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan mulai dari pengumpulan data pasien, diagnose keperawatan (masalah yang muncul), penyebab masalah atau definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai dengan keadaan/kondisi pasien

Komponen: D (Data): Data subjektif & objektif, A (*Action*): Tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan, R (*Response*): Respons pasien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien

Contoh:

D: Pasien sesak napas

A: Berikan oksigen nasal kanul 3 L/menit

R: Sesak berkurang

Keuntungan model dokumentasi POS / DAR:

a. Model ini lebih luas dan lebih positif

b. Sifatnya fleksibel

- c. Catatan rencana asuhan keperawatan model dokumentasi POS ini memudahkan data untuk dikenali
 - d. Waktu pendokumentasian lebih singkat
 - e. Mudah dipergunakan dan dimengerti
- Kerugian model dokumentasi POS / DAR adalah: dapat membingungkan, khususnya antara intervensi yang belum dan sudah dilakukan

Tabel 5.2 Contoh format

Tanggal/waktu/tandatangan	FOCUS	Catatan perkembangan Kategori: DAR
31/03/2026 Malam hari Jam 22.00 Rangga	Keadaan pasien, diagnose keperawatan, masalah, penyebab atau definisi karakteristik dinyatakan dalam FOCUS	DATA: tahap pengumpulan data dan informasi Informasi subyektif dan obyektif yang mendukung FOCUS Action tindakan yang segera dan akan dilakukan

4. Model dokumentasi Electronic Health Record (EHR)

Dokumentasi berbasis digital menggunakan system komputer.

Karakteristik: Terintegrasi antar profesi kesehatan, Akses cepat & real-time, Mengurangi kesalahan dokumentasi, Mendukung keselamatan pasien



Gambar 5.1 Electronic Health Record

Contoh:

Perawat menginput data pasien langsung ke sistem komputer rumah sakit (SIMRS).

Kesimpulan:

SOAP → sederhana dan sistematis

SOAPIER → lebih lengkap (ada implementasi & evaluasi)

DAR → fokus pada masalah/respon pasien

EHR → berbasis teknologi, modern dan efisien

E. Dokumentasi Khusus pada Lansia dalam keperawatan

Dokumentasi pada lansia harus lebih komprehensif karena adanya perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Fokus utama adalah menjaga keselamatan, fungsi, dan kualitas hidup.

Hal yang perlu diperhatikan:

1. Gangguan kognitif (demensia)

Demensia adalah penurunan fungsi kognitif (memori, bahasa, orientasi) yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Lansia dengan demensia sering mengalami: Disorientasi waktu/tempat, Gangguan komunikasi, Perubahan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa demensia menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, bahasa, dan pengambilan keputusan serta berdampak pada aspek psikososial lansia. Risiko meningkat pada usia lanjut dan aktivitas harian yang rendah.

Fokus Dokumentasi:

Status orientasi (orang, waktu, tempat)

Fungsi memori (jangka pendek/panjang)

Perubahan perilaku (agitasi, apatis)

Kemampuan komunikasi

Contoh Dokumentasi SOAP:

S: Pasien mengatakan "saya tidak tahu di mana saya berada"

O: Tampak bingung, salah menyebut tanggal, lupa nama benda yang ditunjuk (bolpoin)

A: Gangguan proses pikir (demensia)

P: Berikan orientasi realitas, komunikasi sederhana

2. Polifarmasi

Polifarmasi adalah penggunaan ≥ 5 obat secara bersamaan pada lansia. Kondisi ini meningkatkan risiko:

Terjadi Interaksi obat, Efek samping yang sulit dihindarkan, Ketidakpatuhan minum obat akibat rasa jenuh.

Lansia dengan penyakit kronis sering membutuhkan banyak terapi sehingga risiko kesalahan obat juga sangat meningkat.

Fokus Dokumentasi

Daftar obat lengkap (nama, dosis, frekuensi)

Kepatuhan pasien

Efek samping (pusing, mual, hipotensi)

Interaksi obat

Contoh Dokumentasi DAR:

D: Pasien minum 6 jenis obat, mengeluh pusing dan muntah 1x (air dan sisa makanan)

A: Edukasi jadwal obat, kolaborasi dengan dokter

R: Pasien mampu mengulang jadwal obat dengan benar

3. Risiko Jatuh

Lansia berisiko tinggi jatuh akibat: Penurunan keseimbangan, Gangguan mobilitas, Efek obat

Penurunan fungsi fisik dan koordinasi meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Hal yang perlu diperhatikan, status nutrisi, status kognitif, skala kekuatan otot, status 5 indera penting dalam tubuh.

Fokus Dokumentasi: Riwayat jatuh berapa kali dalam satu tahun terakhir, Keseimbangan dan gaya berjalan

Penggunaan alat bantu, Faktor lingkungan (lantai licin, pencahayaan).

Contoh Dokumentasi SOAPIER:

S: Pasien merasa lemas saat berjalan

O: Gait tidak stabil, pasien menggunakan kaca mata, BMI = *under nutrition*

A: Risiko jatuh

P: Pasang side bed rail, edukasi keluarga untuk pendampingan pasien

I: Membantu ambulasi,

E: Tidak terjadi jatuh

R: Lanjutkan monitoring

4. Status Fungsional (ADL – Activity of Daily Living)

ADL adalah kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas dasar seperti: Makan, Mandi, Berpakaian, Eliminasi, Mobilisasi. Penurunan ADL berkaitan erat dengan demensia dan kualitas hidup lansia. Tugas dan peran perawat sebagai *educator, advocator, collaborator, motivator, dan researcher* dalam upaya peningkatan kemandirian pasien lansia.

Fokus Dokumentasi: Tingkat kemandirian (mandiri/parsial/total), Alat bantu yang digunakan, Perubahan kemampuan,

Contoh Dokumentasi SOAP:

S: Pasien mengatakan sulit mandi sendiri

O: Membutuhkan bantuan sebagian

A: Defisit perawatan diri

P: Kolaborasi dengan bagian rehabilitasi medik, Latih kemandirian bertahap

5. Kondisi Psikososial

Masalah psikososial lansia meliputi: Depresi, Kesepian, Isolasi sosial, Kehilangan peran

Dukungan sosial terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dan menurunkan dampak negatif dari demensia.

Fokus Dokumentasi: Status emosi (sedih, cemas), Interaksi sosial, Dukungan keluarga, Spiritualitas

Contoh Dokumentasi DAR:

D: Pasien tampak murung, jarang berbicara

A: Fasilitasi komunikasi, libatkan keluarga

R: Pasien mulai berinteraksi

Kesimpulan

Dokumentasi lansia harus mencakup: Kognitif → deteksi dini demensia, Obat → cegah efek polifarmasi, Mobilitas → cegah jatuh, *Activity Daily Living* (ADL) → nilai kemandirian, Psikososial → tingkatkan kualitas hidup.

Pendokumentasian yang lengkap membantu: meningkatkan keselamatan pasien, mencegah komplikasi, mendukung *continuity of care*.

F. Continuity of Care (Continuum of Care)

1. Pengertian

Continuity of care adalah kesinambungan pelayanan kesehatan dari satu fasilitas ke fasilitas lain atau dari satu tahap ke tahap berikutnya secara terintegrasi.

2. Tujuan Continuity of Care (CoC)

Tujuan *Continuity of Care* pada Lansia

CoC adalah kesinambungan pelayanan kesehatan yang terintegrasi sejak pasien dirawat di fasilitas kesehatan hingga kembali ke rumah/komunitas. Pendekatan ini sangat penting pada lansia karena sering memiliki penyakit kronis, keterbatasan fungsi, dan kebutuhan jangka panjang.

a. Menjamin Pelayanan Berkelanjutan

Pelayanan berkelanjutan berarti pasien tetap mendapatkan perawatan yang konsisten dan terkoordinasi meskipun berpindah tempat layanan:

Rumah sakit puskesmas rumah; Antar tenaga kesehatan (dokter, perawat, keluarga). Hal ini mencegah terputusnya informasi dan terapi.

Contoh: Pasien lansia dengan stroke:

Di RS: mendapatkan terapi obat dan fisioterapi

Saat pulang: diberikan *discharge planning* (jadwal kontrol, obat, latihan)

Di rumah: perawat komunitas melakukan kunjungan rumah

Dokumentasi mencatat: rencana pulang, edukasi keluarga, dan tindak lanjut.

b. Mencegah Komplikasi

Tanpa perawatan berkelanjutan, lansia berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti: Luka tekan (dekubitus),

Infeksi, Hipoglikemia/hiperglikemia, Kekambuhan penyakit.

CoC memastikan: Monitoring rutin, Kepatuhan terapi, Deteksi dini masalah.

Contoh: Pasien DM lansia, harus diberi edukasi diet & kontrol gula darah, dipantau secara berkala di puskesmas.

Hasil: mencegah komplikasi seperti luka kaki diabetik.

c. Mengurangi Rehospitalisasi

Rehospitalisasi adalah pasien dirawat kembali dalam waktu dekat setelah pulang.

Penyebab utama: Ketidakpatuhan minum obat, Kurangnya edukasi, Tidak ada monitoring di rumah

CoC membantu dengan: Edukasi yang jelas, *Follow-up* terjadwal, Dukungan keluarga

Contoh Pasien gagal jantung harus diberikan edukasi pembatasan cairan, Monitoring berat badan harian

Follow-up via kunjungan rumah

Hasil: pasien tidak perlu dirawat ulang.

d. Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia

Tujuan utama CoC bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga: Mempertahankan kemandirian, Meningkatkan kenyamanan, Mendukung kesejahteraan psikologis.

Pendekatan meliputi:

1) Pendekatan Fisik (aktivitas, nutrisi) bertujuan menjaga kekuatan otot, status nutrisi, dan kemandirian dalam ADL.

Namun, tetap kita waspadai adanya masalah umum, seperti: Penurunan massa otot, malnutrisi, mudah lelah

Contoh kasus: Lansia dengan osteoarthritis lutut.

Intervensi CoC: Latihan ringan (jalan pagi 10-15 menit), diet tinggi protein dan kalsium, monitoring berat badan

Hasil: Lansia tetap bisa berjalan sendiri, nyeri berkurang, aktivitas tidak tergantung keluarga.

- 2) Pendekatan Psikologis (emosi, depresi), Lansia sering mengalami Depresi, Kesepian, Kehilangan pasangan/peran

Jika tidak ditangani:

- a) menurunkan kualitas hidup
- b) memperburuk penyakit fisik

Peran CoC: Memberikan dukungan emosional berkelanjutan, Mendeteksi dini gangguan psikologis

Contoh Kasus: Lansia tinggal sendiri, tampak murung

Intervensi CoC: Komunikasi terapeutik, Jadwal kunjungan rutin, Rujukan ke konselor bila perlu

Hasil: Lansia lebih terbuka, *Mood* membaik, Tidak merasa sendirian

- 3) Pendekatan Sosial (dukungan keluarga) Dukungan sosial sangat berpengaruh terhadap: Kesehatan mental, Kepatuhan terapi, Kualitas hidup
Bentuk dukungan: Keluarga, Teman sebaya, Komunitas (posyandu lansia)

Contoh Kasus: Lansia dengan hipertensi sering lupa minum obat

Intervensi CoC: Libatkan keluarga dalam pengawasan obat, Edukasi *caregiver*, Anjurkan ikut posyandu lansia

Hasil: Kepatuhan minum obat meningkat, Tekanan darah terkontrol, Lansia lebih aktif secara sosial

Integrasi dalam Praktik (Contoh Singkat SOAP):

S: Pasien merasa lemah dan kesepian

O: Aktivitas terbatas, jarang berinteraksi

A: Penurunan kualitas hidup lansia

P: Latihan fisik ringan, Dukungan psikologis, Libatkan keluarga

Contoh Lansia dengan osteoarthritis harus diberikan latihan ringan rutin, dukungan keluarga untuk aktivitas harian. Hasil: lansia tetap mandiri dan tidak tergantung total.

Kesimpulan: Peningkatan kualitas hidup lansia dalam CoC dicapai melalui: Fisik (menjaga kemandirian dan kesehatan tubuh), Psikologis (mencegah depresi dan meningkatkan kesejahteraan), dan sosial (memperkuat dukungan keluarga dan komunitas).

Tujuan utama *Continuity of Care* pada lansia: Menjaga kesinambungan pelayanan, Mencegah komplikasi, Mengurangi rawat ulang, Meningkatkan kualitas hidup.

Dengan dokumentasi yang baik, perawat dapat: memastikan komunikasi antar tenaga kesehatan, meningkatkan keselamatan pasien, memberikan asuhan yang holistik dan berkelanjutan

3. Komponen *Continuity of Care* terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan untuk menjamin pelayanan lansia yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

a. *Informational continuity* (rekam medis dan komunikasi data pasien)

Informational continuity adalah kelangsungan informasi pasien yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh semua tenaga kesehatan.

Meliputi: Rekam medis (manual/elektronik), Handover (operan *shift*), Komunikasi antar tenaga kesehatan

Tujuannya: Menghindari kehilangan informasi penting, Menjamin kesinambungan tindakan, Meningkatkan keselamatan pasien. Contoh Kasus: Pasien lansia dengan DM dirawat di RS

Implementasi: Data gula darah, obat, dan diet dicatat di rekam medis, Perawat melakukan handover menggunakan SBAR, Data diteruskan ke puskesmas saat pasien pulang

Hasil: terapi tetap konsisten, tidak terjadi kesalahan obat

b. *Management Continuity* (Kesinambungan rencana perawatan)

Management continuity adalah kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan.

Meliputi: Rencana asuhan keperawatan, *Discharge planning*, *Follow-up* (kontrol, home care)

Tujuannya: Menjaga konsistensi terapi, Mencegah komplikasi, Menghindari rawat ulang

Contoh Kasus: Pasien stroke lansia

Implementasi: Di RS: dibuat rencana rehabilitasi

Saat pulang: diberikan latihan fisik di rumah

Dilanjutkan: fisioterapi di fasilitas kesehatan

Hasil: fungsi motorik membaik, tidak terjadi kekakuan otot

c. *Relational Continuity* (Hubungan pasien–tenaga kesehatan)

Relational continuity adalah hubungan yang berkelanjutan antara pasien dan tenaga kesehatan.

Fokus pada: Kepercayaan (*trust*), Komunikasi terapeutik, Kedekatan emosional

Tujuannya: Meningkatkan kepatuhan pasien, Membuat pasien merasa aman dan dihargai, Meningkatkan kualitas pelayanan

Contoh Kasus: Lansia hipertensi sering tidak patuh minum obat

Implementasi: Perawat membangun komunikasi empatik, Memberikan edukasi berulang, Melibatkan keluarga

Hasil: pasien lebih percaya dan rutin minum obat

4. Continuity of Care pada Lansia

Meliputi:

- a. Perawatan rumah (home care)
- b. Puskesmas
- c. Rumah sakit
- d. Panti werdha

Pendekatan ini penting karena lansia sering mengalami penyakit kronis dan membutuhkan perawatan jangka panjang, dengan segala karakteristik lansia didalamnya.

5. Peran Perawat dalam Continuity of Care

a. Care coordinator

Perawat berperan sebagai penghubung antar tenaga kesehatan agar pelayanan berjalan terintegrasi.

Tugas: Mengkoordinasikan dokter, fisioterapis, ahli gizi, Menjamin alur pelayanan tidak terputus, Mengatur rujukan dan tindak lanjut

Contoh Pasien lansia stroke--- Perawat menghubungkan dokter, fisioterapi, dan keluarga

Hasil: rehabilitasi berjalan teratur dan berkelanjutan

b. Edukator Keluarga

Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga/caregiver karena sebagian besar perawatan lansia dilakukan di rumah. Materi edukasi: Obat (jadwal & dosis), Nutrisi, Aktivitas, Tanda bahaya

Contoh Pasien hipertensi --- Perawat mengajarkan cara minum obat & diet rendah garam

Hasil: tekanan darah lebih terkontrol

c. Advokat Pasien

Perawat bertindak sebagai pembela hak pasien, memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai kebutuhan. Peran: Menyampaikan keinginan pasien, Melindungi hak pasien, Membantu pengambilan keputusan

Contoh: Pasien lansia menolak tindakan tertentu --- Perawat menyampaikan ke dokter dan menjelaskan pilihan

Hasil: keputusan sesuai keinginan pasien

d. *Case Manager*

Perawat mengelola kasus pasien secara menyeluruh dari awal sampai tindak lanjut. Tugas: Mengidentifikasi kebutuhan pasien, Menyusun rencana perawatan, Monitoring hasil

Contoh Pasien DM lansia --- Perawat memantau gula darah, diet, dan kontrol
Hasil: komplikasi dapat dicegah

G. Mutu Pelayanan Kesehatan Lansia

1. Pengertian Mutu

Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pasien sesuai:

Standar profesi, Standar pelayanan, Kebutuhan pasien

Fokus: aman, efektif, dan memuaskan

2. Dimensi Mutu (WHO & Avedis Donabedian)

a. Struktur (*Structure*)

Struktur adalah sumber daya yang tersedia: Tenaga kesehatan, Fasilitas, Alat
Contoh RS memiliki ruang khusus lansia ---Perawat terlatih gerontik, tersertifikasi

Dampak: pelayanan lebih optimal

b. Proses (*Process*)

Proses adalah pelaksanaan pelayanan: Pengkajian, Diagnosis, Intervensi, Evaluasi

Contoh Perawat melakukan asesmen risiko jatuh, Memberikan intervensi sesuai SOP

Dampak: pelayanan sesuai standar

c. Outcome (*Hasil*)

Outcome adalah hasil dari pelayanan: Kesembuhan, Kemandirian, Kepuasan pasien

Contoh: Lansia mampu kembali mandiri, Dampak: kualitas hidup meningkat

Dimensi Mutu Tambahan

a. Efektivitas Pelayanan sesuai kebutuhan; Contoh: terapi tepat → penyakit terkontrol

b. Efisiensi Hemat biaya & waktu; Contoh: rawat inap tidak terlalu lama

c. Keselamatan (*Patient Safety*) Mencegah cedera; Contoh: pencegahan jatuh

d. Kepuasan Pasien Persepsi pasien terhadap layanan; Contoh: pasien merasa diperhatikan

e. Aksesibilitas Kemudahan akses layanan; Contoh: layanan dekat & terjangkau

3. Mutu dalam Keperawatan Gerontik

- a. Kemandirian Lansia Lansia mampu melakukan ADL, Contoh: mandi dan makan sendiri
- b. Pencegahan Komplikasi Mencegah masalah lanjutan, Contoh: Luka tekan dicegah dengan reposisi DM cegah luka kaki
- c. Kualitas Hidup Lansia tetap nyaman & bahagia, Contoh: aktif secara sosial
- d. Pendekatan Holistik Meliputi: Fisik, Psikologis, Sosial, Spiritual, Contoh: Pasien tidak hanya diberi obat, tetapi juga terdapat Dukungan keluarga, Aktivitas sosial, Pendampingan emosional

Kesimpulan:

Peran perawat dalam CoC dan mutu pelayanan lansia sangat penting:

✓ Perawat = koordinator, edukator, advokat, dan manajer kasus

✓ Mutu pelayanan = struktur + proses + outcome

✓ Fokus gerontik = mandiri, aman, dan kualitas hidup

Jika semua berjalan baik: Komplikasi menurun, Pasien lebih mandiri, Kualitas hidup lansia meningkat

H. Keselamatan Pasien Lansia (Patient Safety)

1. Pengertian

Keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, termasuk pencegahan cedera akibat kesalahan tindakan.

2. Risiko Keselamatan pada Lansia

Lansia memiliki risiko tinggi karena: Penurunan fungsi fisik, Gangguan kognitif, Penyakit kronis, Polifarmasi

Masalah umum: Jatuh, Infeksi, Kesalahan obat, Dekubitus

3. Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety Goals)

- a. Identifikasi pasien dengan benar
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan obat
- d. Pencegahan infeksi
- e. Pencegahan jatuh
- f. Keamanan prosedur

4. Upaya Keselamatan Pasien Lansia

- a. Penilaian risiko jatuh (Morse Fall Scale)
- b. Edukasi keluarga
- c. Modifikasi lingkungan
- d. Monitoring obat

e. Pengawasan ketat

Lingkungan yang aman sangat penting untuk mencegah cedera pada lansia.

Peran Perawat dalam Patient Safety

- a. Mengidentifikasi risiko
- b. Melaporkan insiden
- c. Edukasi pasien & keluarga
- d. Menerapkan SOP

I. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Tujuan utama dokumentasi keperawatan adalah...
 - A. Administrasi
 - B. Bukti hukum
 - C. Komunikasi tim kesehatan
 - D. Semua benar

Jawaban: d

2. Continuity of care bertujuan untuk...
 - A. Mempercepat discharge
 - B. Pelayanan berkelanjutan
 - C. Mengurangi biaya
 - D. Administrasi

Jawaban: b

Essay

1. Jelaskan prinsip dokumentasi keperawatan!
2. Apa saja risiko keselamatan pasien pada lansia?

Seorang lansia usia 75 tahun dirawat dengan riwayat hipertensi dan sering jatuh di rumah.

Pertanyaan:

1. Identifikasi masalah keselamatan pasien
2. Buat rencana continuity of care
3. Tuliskan contoh dokumentasi SOAP

J. Ringkasan

1. Dokumentasi merupakan bagian penting dalam proses keperawatan
2. Continuity of care menjamin pelayanan berkelanjutan
3. Mutu pelayanan menentukan keberhasilan asuhan
4. Keselamatan pasien lansia menjadi prioritas utama karena risiko tinggi

K. Daftar Pustaka

- Agustini, N. R. S., et al. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Sonpedia Publishing.
- Choudhury, A., et al. (2021). *Geriatric clinical care and safety*. Lipincott. Published
- Mujiadi & Rachmah, S. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. STIKES Majapahit.
- Nasrullah, D. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik dengan Pendekatan NANDA NIC NOC*. UMSurabaya.
- Sagala, D. S. P., et al. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Lingkar Edukasi Indonesia.
- Suharti, S., et al. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Sonpedia Publishing.
- WHO. (2021). *Patient Safety in Older Adults*. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

PROFIL PENULIS



Dr. I Wayan Suardana, Ns., S.Kep., M.Kep, lahir di Dawan Kaler, 9 Januari 1972, merupakan lulusan S2 Komunitas Universitas Indonesia dan S3 di FKM Universitas Airlangga dengan konsentrasi keperawatan lanjut usia dan Keperawatan Komplementer Alternative. Sejak tahun 1996 telah menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi antara lain Universitas Ganesha Bali, Universitas Port De Kock Sumatra Barat, Universitas STRADA Kediri, Universitas Brawijaya Jawa Timur dan di banyak perguruan tinggi di Bali dan daerah lain di Indonesia. Selain itu penulis aktif sebagai praktisi praktik mandiri perawat dan home care, serta terlibat dalam penyusunan beberapa regulasi kesehatan di tingkat nasional maupun provinsi. Penulis telah menulis beberapa buku seperti keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan komplementer dan alternative dan keperawatan gerontik. Penulis juga aktif melakukan publikasi di Jurnal Bereputasi internasional maupun nasional serta jurnal terakreditasi lainnya. Saat ini penulis juga pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi yang secara aktif mempromosikan peningkatan kualitas keperawatan di Indonesia.



Resa Livia Nica, S.Kep., Ns., M.Kes Lahir di Menggala, 20 Desember 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Mitra Indonesia tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mitra Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2021 melanjutkan Program Profesi Ners di Universitas Mitra Indonesia lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mitra Indonesia mengampu mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, Biostatistik. Promosi Kesehatan, Metodologi Penelitian, Komunikasi Dasar Keperawatan, Falsafah dan Teori Keperawatan, Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: resalivianica@umitra.ac.id

Motto: "Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Warisan Terbaik."

PROFIL PENULIS



Syaiful, S.kep., Ns., M.Pd., MKes. Seorang dosen dan praktisi keperawatan berdedikasi, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 23 Mei 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2002. Selanjutnya ia meraih gelar Magister Pendidikan di Universitas Adibwana Surabaya pada tahun 2009, dan melengkapi pendidikan Magister Kesehatan (M.Kes.) di Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, Lombok Tengah, NTB, pada tahun 2023.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2000 di Program Studi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB, yang kini menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini, beliau mengajar di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB dengan mata kuliah utama meliputi Metodologi Penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas.

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Syaiful aktif menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber di berbagai seminar serta berkontribusi dalam lokakarya dan pelatihan. Kepakarannya mencakup bidang manajemen keperawatan/kesehatan, Promosi Kesehatan serta Metodologi penelitian.

Hadir dengan Motto Pengajaran,

1."Keperawatan gerontik yang bermakna adalah pelayanan yang humanis, berbasis evidensi, dan berfokus pada penghormatan terhadap nilai, pengalaman serta kebutuhan unik setiap lansia,

2.Perawatan pada lanjut usia bukan sekadar memperpanjang usia tetapi memastikan setiap tahap kehidupan dijalani dengan martabat, kemandirian dan kualitas hidup yang optimal".

Terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan dan mendukung profesionalisme di bidang kesehatan. Beliau dapat dihubungi melalui email di syaiful6823mpd@gmail.com. Terima kasih

PROFIL PENULIS



Dini Nurbaeti Zen, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom. Lahir di Tasikmalaya, 7 April 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Jenderal Achmad Yani dan lulus pada tahun 2013. Dan melanjutkan Spesialis Keperawatan Komunitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus pada tahun 2024. Penulis bekerja sebagai perawat rumah sakit pada awal tahun 2009. Selanjutnya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sejak 2011 sampai dengan sekarang.

Selama menjadi dosen penulis menggeluti kepakaran ilmu keperawatan anak, keluarga, gerontik dan komunitas. Selain mengajar penulis juga aktif penelitian dan pengabdian dibidang kepakarannya tersebut. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dininurbaetizen@unigal.ac.id

PROFIL PENULIS



Martha Lowrani Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Palembang pada 4 September 1982. Beliau merupakan akademisi dan praktisi keperawatan yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik.

Perjalanan akademiknya diawali dengan menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan (AKPER) William Booth Surabaya pada tahun 2004. Semangat untuk terus meningkatkan kompetensi profesional membawanya melanjutkan studi Sarjana Keperawatan di Universitas Pelita Harapan dan meraih gelar Sarjana

Keperawatan (S.Kep.) pada tahun 2008. Selanjutnya, beliau menyelesaikan Program Profesi Ners di universitas yang sama pada tahun 2012 sebelum melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) pada tahun 2020.

Karier profesionalnya dimulai di Siloam Hospitals Surabaya pada tahun 2005. Beliau mengembangkan kompetensi klinis melalui berbagai jenjang profesi, mulai dari Perawat Pelaksana (Staff Nurse), Perawat Primer (Primary Nurse), hingga menjadi Clinical Instructor pada area *Medical Surgical Nursing* dan *Pediatric Nursing*. Pengalaman tersebut membentuk fondasi yang kokoh dalam praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based nursing*), pembimbingan klinik, pengembangan kompetensi tenaga keperawatan, serta penerapan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Sejak tahun 2016, beliau bergabung sebagai dosen di **STIKes William Booth Surabaya**, dengan komitmen untuk menghasilkan lulusan keperawatan yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam menjalankan tugas akademiknya, beliau mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Keperawatan Komunitas dan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Bencana, Keperawatan Dasar, serta Manajemen Keselamatan Pasien (*Patient Safety Management*).

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, beliau aktif melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, penulisan buku ajar, serta berpartisipasi dalam berbagai seminar dan konferensi ilmiah, baik sebagai peserta maupun pemateri. Minat penelitiannya berfokus pada pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, keselamatan pasien, keperawatan gerontik, serta pengembangan pendidikan keperawatan berbasis bukti. Berbagai karya ilmiah dan kegiatan akademik yang dilakukan merupakan wujud komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bagi beliau, profesi perawat bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk melayani, mendidik, dan memberdayakan masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui email di: marthasiagian49@gmail.com.

Motto : "Hakuna Matata – Everything's Gonna Be Okay."

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gerontik membahas prinsip, konsep, dan penerapan asuhan keperawatan kepada lanjut usia secara komprehensif. Proses menua merupakan bagian alami dari kehidupan yang disertai berbagai perubahan pada aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempertahankan kemandirian, dan mencapai kualitas hidup yang optimal.

Buku ini menguraikan teori dan proses penuaan, perubahan sistem tubuh pada lanjut usia, pengkajian gerontik secara multidimensional, masalah kesehatan yang sering terjadi, serta penerapan proses keperawatan berdasarkan kebutuhan individual. Pembahasan turut mencakup komunikasi terapeutik, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan risiko jatuh, pemeliharaan fungsi kognitif, dukungan psikososial dan spiritual, peran keluarga, pelayanan berbasis komunitas, serta aspek etik dan keselamatan dalam merawat lanjut usia.

Disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, dan sikap caring dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen, perawat, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan lanjut usia yang aman, bermartabat, holistik, dan berpusat pada individu.

Buku Ajar Keperawatan Gerontik membahas prinsip, konsep, dan penerapan asuhan keperawatan kepada lanjut usia secara komprehensif. Proses menua merupakan bagian alami dari kehidupan yang disertai berbagai perubahan pada aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempertahankan kemandirian, dan mencapai kualitas hidup yang optimal.

Buku ini menguraikan teori dan proses penuaan, perubahan sistem tubuh pada lanjut usia, pengkajian gerontik secara multidimensional, masalah kesehatan yang sering terjadi, serta penerapan proses keperawatan berdasarkan kebutuhan individual. Pembahasan turut mencakup komunikasi terapeutik, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan risiko jatuh, pemeliharaan fungsi kognitif, dukungan psikososial dan spiritual, peran keluarga, pelayanan berbasis komunitas, serta aspek etik dan keselamatan dalam merawat lanjut usia.

Disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, dan sikap caring dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen, perawat, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan lanjut usia yang aman, bermartabat, holistik, dan berpusat pada individu.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-87-9 (PDF)



9

786347

756879